患者视角 · 科普资料汇编 · V0.2

抑郁症资料库

模块内容与延伸专题

阅读提示：本资料仅供学习科普，不能替代精神科专业评估、诊断或处方。请勿据此自行增减或停用药物；遇到迫切安全风险，请联系当地急救或急诊服务。

目录

资料库总目录

目录

模块1：基础定义与疾病概况

1. 疾病正式名称

2. 疾病本质

3. 流行病学

4. 名词释义

5. 常见合并情况

模块2：临床表现

1. 核心症状

2. 附加症状

3. 不同亚型特点

4. 疾病分期

模块3：病因与诱发因素

1. 生物学因素

2. 心理因素

3. 环境诱因

4. 常见误区澄清

5. 诱发复发的常见触发事件

模块4：就医、评估与诊断

1. 就诊渠道

2. 就诊准备

3. 医生诊断流程

4. 常用自评量表说明

5. 鉴别诊断

模块5：治疗方案

5.1 药物治疗

5.2 心理治疗

5.3 物理治疗

模块6：自我康复、复发管理与危机干预

1. 复发预警信号

2. 日常自我照顾策略

3. 负性思维觉察与调整

4. 危机识别与急救

5. 社会支持

模块7：误区、权益与资源

1. 常见误区澄清

2. 生活与权益

3. 正规书籍与科普资源

4. 偏方与网络疗法风险

可选附加模块

共病专题

家属参考附录

康复者视角

抑郁症资料库（面向患者视角）

> 前置免责声明：本资料库仅作学习科普，**不能替代精神科医生面诊、诊断与处方**。不可自行依据资料判断病情、增减或停用药物。所有内容标注来源，区分临床共识、研究结论、个人体验、争议观点。

整体分为 **7大模块**，内容偏向患者视角，聚焦自我识别、就医、治疗、日常康复、危机应对。

模块1：基础定义与疾病概况

核心：帮患者理解疾病，破除误区

1. 疾病正式名称

- 中文：抑郁障碍（重性抑郁障碍 / 抑郁症），英文 Major Depressive Disorder（MDD）
- ICD-11、DSM-5 编码与命名说明
- 区分：抑郁情绪 vs 抑郁症（一过性心情不好≠疾病）

1. 疾病本质：大脑神经递质、神经可塑性、遗传、环境共同作用的疾病，**不是单纯“想不开、矫情、意志力差”**
2. 流行病学：发病年龄、男女发病特点、复发概率
3. 名词释义：单次发作/反复发作、持续性抑郁障碍（恶劣心境）、季节性抑郁、伴精神病性症状抑郁
4. 常见合并情况：常和焦虑、失眠、躯体不适共病

模块2：临床表现（患者自我觉察为主）

> 从患者感受角度描述，避免生硬教科书式表述

1. 核心症状（2条核心）

- 持续情绪低落、悲伤、空虚，快感缺失（对原本喜欢的事提不起兴趣）

1. 附加症状

- 认知：注意力下降、记忆力变差、自责、无价值感、悲观、思维迟缓
- 躯体：睡眠紊乱（失眠/嗜睡）、食欲体重变化、乏力、疼痛、肠胃不适、性欲下降
- 行为：行动变慢、不愿社交、拖延、自我封闭

1. 不同亚型特点

- 伴有焦虑痛苦的抑郁
- 伴有精神病性症状的抑郁（幻觉、妄想）
- 非典型抑郁（嗜睡、暴食、肢体沉重）

- 季节性抑郁
- 持续性抑郁障碍（长期轻度低落，持续2年以上）

1. 疾病分期：发作期、巩固期、维持期、缓解期

模块3：病因与诱发因素（患者视角：理解为什么会发病）

1. 生物学因素：遗传易感性、神经递质、脑区功能变化、激素（甲状腺、性激素、皮质醇）
2. 心理因素：长期负性思维模式、完美主义、早年创伤
3. 环境诱因：重大丧失、长期压力、孤独、冲突、失业、生病、睡眠长期剥夺
4. 澄清误区：**不是性格软弱造成；只是风险因素叠加，不是单一原因**
5. 诱发复发的常见触发事件（方便患者自我留意）

模块4：就医、评估与诊断

> 重点告诉患者：去哪里就诊、会经历什么，减少就医恐惧

1. 就诊渠道：精神卫生中心、综合医院精神科/心理科；不推荐单纯心理咨询做诊断
2. 就诊准备：就诊前可以提前整理的信息清单（症状时长、睡眠饮食、既往病史、家族史、用药史）
3. 医生诊断流程：精神检查、躯体排查（抽血、甲状腺等，排除躯体疾病引发抑郁）
4. 常用自评量表说明：PHQ-9、SDS、汉密尔顿抑郁量表HAMD

> 重要备注：自评量表**仅筛查，不能作为确诊依据**

1. 鉴别：哪些情况看起来像抑郁但不是（甲状腺疾病、维生素缺乏、脑器质性病变、药物副作用、双相情感障碍）

模块5：治疗方案（患者最关心，循证科普）

5.1 药物治疗

- 抗抑郁药类别简介（SSRI、SNRI、NaSSA等）
- 起效特点：**不是立刻见效，通常2–4周才逐步起效**
- 常见早期副作用，区分短期不适与危险不良反应
- 用药原则：足量足疗程；不要自行突然停药（撤药反应、复发风险）
- 换药、合并用药的适用场景
- 禁忌与注意事项（严禁和部分药物、违禁物质混用）

5.2 心理治疗

- 一线推荐：认知行为疗法CBT、正念认知疗法MBCT（预防复发）

- 其他：IPT人际关系治疗、支持性心理治疗
- 说明：中度重度抑郁，**优先药物+心理联合**；轻度可单用心理治疗

5.3 物理治疗

- 无抽搐电休克 MECT：适用场景，适合重度、有自伤拒食、难治性抑郁；打消恐惧误区
- rTMS重复经颅磁刺激，适用范围

模块6：自我康复、复发管理与危机干预（患者实操模块）

1. 复发预警信号清单（患者可以自我监测）

- 睡眠改变、兴趣下降、消极想法增多、体力持续变差、情绪持续走低

1. 日常自我照顾策略

- 睡眠管理、运动建议、饮食、社交最低限度维持、压力减负
- 正念、情绪记录、情绪日记（简单可落地）

1. 负性思维觉察与调整（简化版CBT，适合日常练习）
2. 危机识别与急救

- 自伤、自杀念头分级：想法、计划、准备、行动
- 紧急求助渠道、如何联系身边支持者、住院指征
- 安全计划模板（可直接保存使用）

1. 社会支持：如何和家人沟通病情，如何向亲友表达需求

模块7：误区、权益与资源

1. 常见误区澄清

- “想开点就好了” “吃药会变傻上瘾” “抑郁症就是矫情” “好了就可以立刻停药”

1. 生活与权益：病假、医保、心理援助热线、残疾相关政策参考
2. 适合患者的正规书籍、科普资源
3. 禁忌提醒：偏方、保健品、网络“抑郁自愈疗法”风险

可选附加模块（按需增加）

- 【共病专题】抑郁合并焦虑、睡眠障碍、躯体疼痛、物质滥用；区分双相情感障碍（极易误诊为抑郁）
- 【康复者视角】康复体验（注明仅个人感受，不代表所有人）
- 【家属参考附录】：家属该怎么陪伴、哪些话不要说（放在附录，主体面向患者）

资料库首页两条核心规则

1. 免责声明：资料库仅科普学习，**不可作为诊断、用药依据，出现症状请前往正规精神科就诊。**
2. 来源标注原则：关键内容标注来源，区分临床指南、综述、个案体验，过滤网络传言。

1. 疾病正式名称

> 本页用于解释"抑郁障碍""抑郁症"这些名字到底指什么、两套国际诊断体系（ICD 与 DSM）在命名上有什么差别。它不能替代医生的面诊诊断：你病历上的具体诊断，以接诊机构采用的分类版本和医生判断为准。

1.1 你会在不同地方看到的几个名字

- **抑郁障碍（Depressive Disorders）**：一组以持续情绪低落、兴趣或愉悦感下降等为主要表现的精神障碍的总称，是临床上比较规范的大类名称。
- **重性抑郁障碍（Major Depressive Disorder，MDD）**：DSM-5/DSM-5-TR 中的具体诊断名称，也就是老百姓口中"抑郁症"最常对应的那个正式诊断。
- **抑郁症**：日常俗称和科普用语，顺口、好懂，但它不一定严格对应某一套分类里的某一个编码。就诊、填保险或医疗资料时，最好直接使用病历上写的那个诊断。
- **抑郁情绪 / 心情不好**：这不是诊断，而是人人都会有的正常情绪状态，详见 1.3。

【临床共识】对外交流时，"抑郁障碍患者"或"正在经历抑郁发作的人"是中性、尊重的说法；"抑郁症"在科普语境下也完全可用。

1.2 两套国际分类：ICD-11 与 DSM-5 的命名差异

目前国际上主要用两套诊断与编码系统，它们的思路大体一致，但名称和编码不完全对等。看病时你可能在不同医院、不同资料里看到不同写法，这并不矛盾。

项目	ICD-11（世界卫生组织）	DSM-5 / DSM-5-TR（美国精神医学学会）
上位类别	抑郁障碍（Depressive disorders）	抑郁障碍（Depressive Disorders）
单次发作	**单次发作性抑郁障碍（编码 6A70）**	重性抑郁障碍，单次发作（Single Episode）
反复发作者	**复发性抑郁障碍（编码 6A71）**	重性抑郁障碍，反复发作（Recurrent）
长期轻度低落	**恶劣心境障碍（编码 6A72，持续 2 年以上）**	并入"持续性抑郁障碍（Persistent Depressive Disorder）"
用途	国际健康统计、病历编码、医保对接	临床研究、学术与心理治疗沟通常用

【临床共识】两点差异请特别注意：

1. ICD-11 至今仍把"恶劣心境（dysthymia）"单独列为一个类别（6A72）；而 DSM-5 把它和其他形式的慢性抑郁合并成了"持续性抑郁障碍"。所以你可能在一份资料里看到"恶劣心境"、在另一份里看到"持续性抑郁障碍"，它们指的是很接近的长期低落状态。
2. 编码是给医院、医保、统计用的"内部编号"，不是给你自我对号入座的清单。**本文不把任何一串编码当作你个人的诊断依据。**

1.3 "抑郁情绪"不等于"抑郁障碍"

这是本页最重要的一点。人在失落、熬夜、被骂、失恋、失业、考试失败后出现几天低落，是非常正常的心理反应，**不自动等于得了抑郁症。**

要达到临床诊断的程度，医生通常会综合评估以下几条：

判别维度	一过性心情不好	可能需要考虑抑郁障碍
持续时间	几天到一两周，事情过去后慢慢好转	核心低落或兴趣下降持续约 **2 周以上**，几乎每天大部分时间都如此
功能影响	该吃吃、该睡睡，基本能照常生活	明显影响工作、学习、人际或自理，比如"连刷牙都像搬石头"
伴随表现	主要是情绪差	同时出现睡眠、食欲、注意力、自我评价等多方面改变
能否被其他原因解释	由具体事件引起	无法用最近的事件、躯体疾病、酒精或药物完全解释

【个人体验】很多人会说："我又没有哭，是不是就不算抑郁？"——不是。有人表现为麻木、空虚、易怒，而不是流泪。反过来，"我已经难过好几天了"也不代表一定是病。**判断权在专业人员，不在这张表。**

1.4 为什么名字的用法有讲究（去羞耻化）

- 抑郁是一种**可以被诊断、可以被治疗的疾病**，和"想不开""矫情""意志力差"没有必然关系。
- 诊断名称是医疗沟通工具，它**不能定义你这个人**，也不能预测你的未来。康复后，你仍然是原来那个你，只是经历过一场需要治疗的病。
- 避免用"他就是想太多""她太脆弱"这类话概括患者——这既是对疾病的误解，也会让真的生病的人更不敢求助。

【临床共识】如果你正在读这份资料，并且怀疑自己可能处于抑郁状态，最有价值的下一步不是给自己贴标签，而是带着这份"我大概持续了多久、影响了哪些事"的记录，去精神科或心理科门诊谈一次。

参考来源

- 世界卫生组织：Depression（抑郁症）事实清单
- 世界卫生组织：ICD-11 浏览器（在线分类）
- 世界卫生组织：ICD-11 临床描述与诊断要求（CDDR）
- NICE（英国国家卫生与临床优化研究所）：Depression in adults: treatment and management（NG222）
- American Psychiatric Association：DSM-5 / DSM-5-TR 官方介绍

2. 疾病本质

> 本页想回答一个很多人心里反复问的问题："我到底是怎么了？"——答案是：抑郁是一种有生物学基础、也受心理社会因素影响的疾病，**不是想不开、不是矫情、不是意志力差**。本页是科普，不能替代医生对你个人情况的解释。

2.1 一句话立场

【临床共识】抑郁障碍是一种**疾病实体（disorder）**，它涉及大脑神经递质、神经环路、内分泌和遗传易感性等多个层面的改变，同时被压力、人际关系、创伤等环境因素触发或加重。它和"性格坚强与否"没有直接关系——就像感冒不是因为"不够坚强"才得的。

2.2 神经递质：不是"缺了某种快乐物质"那么简单

你可能听过"血清素（5-羟色胺）低所以抑郁"的说法。这个说法流传很广，但**过于简化**，需要平衡地理解：

- 参与情绪调节的主要神经递质包括 **5-羟色胺（5-HT）、去甲肾上腺素（NE）、多巴胺（DA）**。
- 临床上常用的抗抑郁药（如 SSRI 类）确实主要通过提高突触间隙 5-HT 水平起效，这是"递质学说"的主要依据。
- 但【研究结论】大量证据显示：抑郁**不是**简单的"大脑里某种物质太少"。服药后几小时脑内递质浓度就变了，但情绪改善往往要 2–4 周才出现，说明真正起作用的是后续的神经可塑性、受体调节等更慢的过程。

【争议观点】"递质不足模型"在学术界已被认为过于朴素，更受认可的是把抑郁理解为神经环路、可塑性与应激系统的综合紊乱。但这不影响——临床上基于递质开发的药物依然是有效的治疗手段。

2.3 神经可塑性与关键脑区：可以把大脑想象成"网络信号出了问题"

为了让患者能听懂，我们用通俗的方式描述几个被反复研究的脑区：

脑区 / 网络	大致功能（通俗版）	抑郁时常见的改变方向
海马（Hippocampus）	记忆、学习、应激调节	长期高压下体积可能缩小，与记忆下降、反刍思维有关
前额叶皮层（PFC）	理性控制、决策、抑制负性想法	活动偏低，"想控制但控制不住"、决策困难
杏仁核（Amygdala）	恐惧、威胁反应	反应偏强，对负面信息过度敏感
默认模式网络（DMN）	发呆、自我反思、反刍时活跃	过度活跃，表现为反复回想自己的错、停不下来

【研究结论】抗抑郁药、心理治疗（如认知行为治疗）甚至运动，都被观察到能在一定程度上改善上述脑区的活动与可塑性——这也是"为什么治疗真的能让人好转"的生物学基础之一。

2.4 神经内分泌：HPA 轴与"压力系统长期报警"

- 人体面对压力时会激活 **下丘脑—垂体—肾上腺轴（HPA 轴）**，释放皮质醇（俗称"压力激素"）。
- 【研究结论】相当一部分抑郁患者存在皮质醇调节异常（如晨间皮质醇过高、地塞米松抑制试验不被抑制），长期慢性高压会损伤海马、加重前述脑区改变。
- 通俗讲：**你的身体长期处于"警报没解除"的状态**，这不是你"想紧张"，而是应激系统的设定被卡住了。

2.5 遗传易感性：有影响，但不等于"命中注定"

- 抑郁有家族聚集倾向，**遗传度大约在 30%–40% 左右**（不同研究数字有出入）。
- 但它不是单基因遗传病，而是多个微效基因叠加、再与环境相互作用的结果。也就是说：有家族史只是风险升高，**不代表你一定会得，也不代表得了就好不了。**
- 【临床共识】真正决定"会不会发作"的，往往是遗传易感性 × 近期压力事件（失业、失恋、躯体疾病、长期熬夜等）的共同作用。

2.6 一个帮助去羞耻化的类比：糖尿病

【个人体验】很多患者会用这个比喻自我说服："抑郁之于大脑，有点像糖尿病之于胰腺——都是器官功能出了问题，需要规范治疗，而不是靠'咬牙坚持'。"

但【争议观点】这个类比有它的**局限**，需要讲清楚：

- ✅ 相似处：都是慢性、可复发、需要长期管理的疾病；都不能靠"想开点"治好；都需要药物 + 生活方式共同干预。
- ❌ 不同处：糖尿病的血糖可以用仪器精确测量，而抑郁目前**没有抽血或影像的"金标准"**，诊断靠临床访谈；心理社会因素在抑郁中权重更大。

所以这个类比适合用来对自己说"我不是懒"，但不适合用来对别人说"抑郁就是糖尿病"——它帮助我们放下羞耻，但不夸大科学已经搞清楚的程度。

2.7 小结：为什么这一页对你重要

1. 如果你正在经历低落，**这不是你的错。**大脑和身体的应激系统出了故障，就像其他器官生病一样。
2. 这也解释了为什么"硬扛""想开点"常常无效——因为问题不 purely 在想法层面。
3. 反过来，正因为它涉及神经可塑性和环路，**规律治疗、运动、心理治疗、睡眠调整这些"慢变量"恰恰是真正能修复它的东西。**

参考来源

- 世界卫生组织：Depression（抑郁症）事实清单
- NICE：Depression in adults: treatment and management（NG222）
- Malhi GS, Mann JJ. Depression. *Lancet*. 2018;392:2299-2312. DOI: 10.1016/S0140-6736(18)31943-331943-3)

- 中华医学会精神医学分会：《中国抑郁障碍防治指南（第二版）》，中华医学电子音像出版社。
- American Psychiatric Association：DSM-5 官方介绍

3. 流行病学

> 本页用数据告诉你：抑郁到底有多常见、哪些人更容易遇上、复发的概率大概多大。读这些数字不是为了吓你，而是让你知道——**你不是一个人，这是一种非常普遍的疾病。**数字来自不同年份、不同调查，请勿把它们混为一谈。

3.1 全球：抑郁是最常见的疾病之一

【研究结论】根据世界卫生组织（WHO）基于 2019 年全球疾病负担的数据：

- 全球约有 **2.8 亿人** 正在遭受抑郁困扰，约占全球人口的 **3.8%**（成年人中约 5%）。
- 抑郁是**全球致残（years lived with disability）的主要原因之一**，也是造成整体疾病负担的重要贡献者。
- 新冠疫情期间（2020 年起），全球抑郁和焦虑的患病率进一步明显上升。

> 小提示：WHO 后续更新的估算数字略有上调（2023 年前后约 4%、约 3.22 亿人）。不同年份、不同口径的数字差异属于正常现象，本页统一给区间并标注年份。

3.2 中国：基于全国性调查的数据

【研究结论】由黄悦勤教授团队主持的 **中国精神卫生调查（China Mental Health Survey, CMHS）** 于 2019 年发表在 *Lancet Psychiatry*，这是目前国内最权威的全国性流行病学数据：

指标	数值
抑郁障碍**终生患病率**（一生中曾患过的比例）	**6.8%**
12 个月患病率（过去一年内的新发/现患比例）	**3.6%**

也就是说，大约**每 15 个中国人中，就有 1 个在一生中某个阶段符合抑郁障碍的诊断。**你身边不起眼的同事、邻居、家人里，可能就有人正在经历或曾经经历过——只是很多人没有说出来。

3.3 好发人群与性别差异

维度	特点	通俗解释
好发年龄	青壮年（约 15–44 岁）是高峰	学业、就业、婚恋、育儿、职场压力集中在这一阶段
性别差异	女性患病风险约为男性的 **1.5–2 倍**	与激素波动（月经、孕产、绝经）、社会角色压力、遭遇暴力风险等多重因素有关
青少年	发病率近年呈上升趋势，表现常以**易激惹**而非悲伤为主	容易被家长误认为"叛逆"

维度	特点	通俗解释
老年人	并不少见，且常被躯体不适、记忆下降掩盖，易被误认为"正常老化"或痴呆	见模块2"老年抑郁"

【临床共识】男性并不比女性"更坚强所以不得病"，而是更倾向于以**易怒、酗酒、风险行为**等方式表达抑郁，因此更容易漏诊。

3.4 复发概率：为什么医生总强调"不要太早停药"

【研究结论】这是本页对患者最有实际意义的一组数据：

- 一次抑郁发作痊愈后，**约 50% 的人会经历第二次发作**。
- 经历过 **2 次**发作后，再次复发的概率升至约 **70%–80%**；
- 经历过 **3 次及以上**发作后，复发概率可高达 **90%** 左右，通常建议长期维持治疗。

【临床共识】规律、足疗程治疗（详见模块2"疾病分期"）能**显著降低**复发风险；而症状一好转就自行停药，是复发最常见的诱因之一。

3.5 疾病负担与"治疗缺口"

- WHO 指出，抑郁是导致全球劳动力损失和残疾调整生命年（DALY）的主要原因之一。
- 【研究结论】但现实中**就诊率、治疗率都偏低**：中国乃至全球范围内，大量抑郁患者从未获得规范的精神卫生服务。
- 主要原因包括：病耻感（"被人知道会被看不起"）、不知道这是病、综合医院识别率低、获得专业服务的可及性不足等。

【个人体验】很多人是先跑了消化科、心内科、中医科，做了一堆检查没查出问题，最后才被建议"去精神心理科看看"。这不是绕远路，而是疾病本身的特点决定的——它常常披着躯体不适的外衣。

3.6 这一页对你意味着什么

1. **常见**：每 15 个人里就有 1 个，你绝不孤单，也不必羞耻。
2. **可复发但可防**：复发概率随发作次数上升，但足疗程治疗能显著压低这个数字。
3. **被低估**：因为大家不说，所以你以为"只有我这样"——其实只是大家都在默默扛。

参考来源

- 世界卫生组织：Depression（抑郁症）事实清单
- Huang Y, Wang Y, Wang H, et al. Prevalence of mental disorders in China: a cross-sectional epidemiological study. *Lancet Psychiatry*. 2019;6(3):211-224. DOI: 10.1016/S2215-0366(18)30511-X30511-X)
- GBD 2019 Mental Disorders Collaborators. Global, regional, and national burden of 12 mental disorders in 204 countries and territories, 1990–2019. *Lancet Psychiatry*. 2022;9(2):137-150. DOI: 10.1016/S2215-0366(21)00395-300395-3)

- 中华医学会精神医学分会：《中国抑郁障碍防治指南（第二版）》。
- NICE：Depression in adults: treatment and management（NG222）

4. 名词释义

> 病历、医生嘴里、科普文章里经常蹦出一堆术语："复发性""恶劣心境""季节性""难治性……"。这一页把它们翻译成大白话，并附上"患者需要知道的事"。**这些解释只帮你读懂资料，不能用来给自己下诊断。**

4.1 一张表先看全：术语 → 是什么 → 对你意味着什么

术语	大白话定义	患者提示
抑郁发作（Depressive Episode）	一次达到诊断标准的、持续的抑郁阶段	医生说"你这是一次发作"，不等于你"一辈子都会这样"
单次发作性抑郁障碍（ICD-11: 6A70）	人生中第一次、目前也只发作过这一次	仍需足疗程治疗，因为有复发可能
复发性抑郁障碍（ICD-11: 6A71）	之前发作过一次以上，这次是新一轮发作	复发 ≠ 你失败了；更需要维持治疗和预警意识
持续性抑郁障碍 / 恶劣心境（ICD-11: 6A72；DSM-5 称 Persistent Depressive Disorder）	长期（成人≥2年、儿童青少年≥1年）的轻度低落，症状不如重性发作那么剧烈，但拖得久	很多人"我以为我天生就是这种性格"——其实可能是病
伴季节性模式（季节性情感障碍）	抑郁发作与季节有规律关联，最典型是**秋冬发作、春夏缓解**	光照治疗是公认有效手段之一
伴精神病性症状的抑郁	严重抑郁时出现幻觉、妄想（如坚信自己有罪、家很穷、身体烂了）	这是需要尽快就医的信号，不等于精神分裂症
围产期抑郁	孕期或产后出现的抑郁	不是"矫情"，家人需重点识别和支持
伴混合特征（With mixed features）	抑郁发作的同时，伴随轻度的情绪高涨、话多、精力旺盛等躁狂样症状	提示医生警惕双相情感障碍，用药选择会不同
伴焦虑痛苦特征（With anxious distress）	抑郁同时明显坐立不安、紧张、担心失控	焦虑越重，治疗反应和风险评估越要重视
缓解（Remission）	症状显著减轻、基本不再符合发作标准	缓解 ≠ 治愈，仍可能有残余症状，不能自行停药
复燃（Relapse）	还在同一轮发作的恢复期内，症状又加重回来了	多与过早减停药物有关
复发（Recurrence）	已经完全缓解、稳定了一段时间之后，**新的一轮**发作	需要更长维持期
难治性抑郁（TRD）	经过两种及以上足剂量、足疗程的抗抑郁药规范治疗仍效果不佳	不等于"治不好"，有增效、联合、物理治疗等多种路径

4.2 重点术语展开讲

（1）复燃 vs 复发：很多人搞混，其实差别很大

- **复燃（Relapse）**：你这次发作还没真正好利索，只是暂时轻了一点，结果症状又卷土重来。好比火灾刚压下去，余烬又烧起来。
- **复发（Recurrence）**：你已经彻底好了、稳定了好几个月甚至更久，然后**新的一次**发作。好比火彻底扑灭了，几年后别处又着了一次。

【临床共识】这个区分直接影响治疗策略：复燃更强调"赶紧把这次压住、别减药"；复发更强调"维持更久、学会识别预警信号"。

（2）恶劣心境 / 持续性抑郁障碍：最容易被误认成"性格"的一种

【个人体验】这种状态特别坑人：它不像重性抑郁那样"轰"地一下把你击倒，而是**两三年、甚至十几年**都笼罩在一层淡淡的灰雾里——"我一直都这样""我天生就是个不快乐的人""可能人生本来就是苦的"。直到某次遇到重大压力，爆发一次重性抑郁，去看病才被点醒："原来前面那十几年也是病。"

【临床共识】ICD-11 仍把它单列为"恶劣心境障碍（6A72）"，要求成人持续至少 2 年、且这两年里没有连续 2 个月以上完全无症状；DSM-5 则把它并入"持续性抑郁障碍"。名称不同，说的都是这一类"慢性轻度低落"。

（3）伴精神病性症状的抑郁：吓人，但要分清

- 典型表现：**心境协调的妄想**——内容和抑郁情绪是"配套"的，比如坚信自己犯了大罪、家里穷到活不下去、内脏已经烂掉。
- 也可出现幻听（比如听到有人骂自己、说自己该死）。
- 【临床共识】关键区别：这些症状是**继发于严重抑郁**的，抑郁好转后它们通常随之消失；这和"原发性精神病性障碍（如精神分裂症）"的起病方式、病程都不同。出现这类体验，请尽快就医。

（4）难治性抑郁：不是"没救了"

- 一般指经过**两种及以上不同种类的抗抑郁药、足量足疗程（通常每种 ≥ 4–6 周）**规范治疗后，疗效仍不理想。
- 【临床共识】"难治"是治疗反应的描述，不是预后的判决书。下一步通常包括：换药、联合用药、增效剂、心理治疗联合、物理治疗（如 MECT、rTMS 等，详见治疗模块）。

4.3 你就诊时可以主动问医生的几句话

- "我这次是单次发作，还是复发性的？"
- "我现在算急性期、巩固期，还是已经在维持期了？"
- "我的症状里有没有需要特别标注的特征（比如焦虑、季节性）？"
- "如果以后出现 XX 情况，是算复燃还是可能要按复发处理？"

参考来源

- 世界卫生组织：ICD-11 浏览器（在线分类）
- 世界卫生组织：ICD-11 临床描述与诊断要求（CDDR）
- American Psychiatric Association：DSM-5 / DSM-5-TR 官方介绍
- NICE：Depression in adults: treatment and management（NG222）
- 中华医学会精神医学分会：《中国抑郁障碍防治指南（第二版）》。
- 世界卫生组织：Depression（抑郁症）事实清单

5. 常见合并情况

> 抑郁很少"单打独斗"。它常常和焦虑、失眠、慢性疼痛、酒精使用等问题一起出现，这种现象叫**共病（comorbidity）**。了解它，能帮你在就诊时把更完整的信息告诉医生，避免"只治了一半"。本页为科普，具体诊断与鉴别由医生完成。

5.1 最常见的几类合并问题（一张表先看全）

合并问题	有多常见	患者常见的表现	对治疗的影响
焦虑障碍（广泛性焦虑、惊恐、社交焦虑等）	最常见，**约半数以上**抑郁患者共病	心里发紧、坐不住、总担心坏事发生、突发心慌气短	焦虑越重，抑郁恢复越慢；用药和心理治疗都要兼顾
失眠 / 睡眠障碍	非常普遍，可高达 60%–90%	入睡难、凌晨早醒（比平时早醒 2 小时以上且无法再入睡）、睡眠很浅	失眠既是症状也是复发诱因，需同步干预
躯体不适 / 慢性疼痛	常见，尤其在老年和综合医院就诊者	头痛、背痛、胃肠不适、胸闷、全身游走性疼痛，检查却查不出器质性问题	容易先跑各科，最后才到精神心理科
物质使用（酒精、镇静类等）	有一定比例，男性更多见	靠喝酒"助眠""压一压情绪"、越喝越多	会加重抑郁、干扰药物，必须如实告知医生
强迫相关 / 创伤后应激（PTSD）	部分患者合并	反复想同一件事、噩梦、回避某些场景	需在抗抑郁基础上叠加针对性心理治疗
双相情感障碍（既往被误诊为单纯抑郁）	需鉴别，不是"合并"，而是"原本就是另一种病"	既往曾有过连续几天异常兴奋、话多、精力旺盛、睡眠需求减少	**用药选择完全不同**，误开抗抑郁药可能诱发躁狂

5.2 重点展开：为什么"焦虑"和"抑郁"总是绑在一起

【研究结论】从神经环路看，焦虑和抑郁共享了 HPA 轴（压力系统）过度激活、杏仁核高反应、前额叶调控不足等生物学基础；从心理体验看，长期焦虑本身就在消耗人的心理资源，久而久之把人拖入低落。

【个人体验】很多患者的真实顺序是：先是"总担心、睡不好"熬了几个月，然后"怎么都高兴不起来、不想动"。去看病时如果只说"我心情低落"，医生可能漏掉焦虑这一半——所以**就诊时建议把"紧张、担心、心慌、坐不住"也一并讲出来。**

5.3 躯体化：抑郁披着"身体病"的外衣

这是中国患者最典型、也最耽误事的共病形式。

【个人体验】"我不是来看心理问题的，我就是胃不舒服/胸口闷/头疼/睡不好。"——这是综合医院门诊里非常常见的开场白。患者做了胃镜、心电图、颈椎片、头颅 CT，结果都"没什么大问题"，但难受是真实的。

【临床共识】这种"查不出器质性病变但真实存在的躯体不适"，在精神医学里被称为**躯体化症状**或"抑郁的躯体表现"。它不是装病，也不是"你想出来的"，而是大脑把情绪痛苦以身体的方式表达出来。识别它，能避免反复

做不必要的检查。

5.4 酒精与物质：一个需要主动坦白的话题

- 有些患者在抑郁早期会不自觉地用酒精"自我药疗"：喝一点能暂时放松、好入睡。
- 但【研究结论】长期来看，酒精会抑制中枢神经、破坏睡眠结构、降低 5-HT 系统功能，**让抑郁更重、更容易复发**，还会与抗抑郁药产生相互作用。

【临床共识】就诊时请**如实**告诉医生你每周喝多少酒、有没有靠安眠药入睡、有没有用过其他物质。这不是让医生评判你，而是为了安全用药和更准确地判断病情。

5.5 与双相情感障碍的鉴别：点到为止

【临床共识】这一块严格来说不是"共病"，而是"**容易被当成单纯抑郁、实际是双相**"的鉴别问题。如果你既往有过几天甚至更长时间的：

- 异常兴奋、话特别多、脑子转得飞快；
- 睡眠明显减少却不觉得困；
- 冲动消费、轻率投资、性行为轻率；
- 自我评价异常高……

请务必在第一次就诊时就告诉医生。详细鉴别诊断我们留到资料库后续"鉴别诊断"专题展开，本页只做提醒。

5.6 就诊时怎么把"合并情况"说清楚（可直接照抄给医生）

> "医生，我除了情绪低落，还有这些情况：① 最近 ____ 个月一直睡不好，主要是 ____（入睡难/早醒/多梦）；② 经常觉得 ____（心慌/紧张/坐不住）；③ 身体上 ____（具体哪里不舒服），我在 ____ 科做过 ____ 检查，结果是 ____；④ 我每周大概喝 ____ 酒/是否服用安眠药 ____；⑤ 我以前有没有过特别兴奋、睡不着、话多的阶段：____。"

参考来源

- 世界卫生组织：Depression（抑郁症）事实清单
- NICE：Depression in adults: treatment and management（NG222）
- 中华医学会精神医学分会：《中国抑郁障碍防治指南（第二版）》。
- American Psychiatric Association：DSM-5 / DSM-5-TR 官方介绍
- Wittchen HU, et al. The size and burden of mental disorders and other addictions in Europe. *Eur Neuropsychopharmacol*. 2011;21(Suppl 1):S1-S2.

1. 核心症状

> 这一页写给"正在经历的人"。抑郁的核心症状只有两条，但它们会以非常不同的样子出现在每个人身上。读它不是为了让你给自己确诊，而是帮你把"我说不清楚到底怎么了"那种感觉，翻译成可以被医生听懂的话。

1.1 两条核心症状（诊断标准里最关键的两条）

① 持续的情绪低落、悲伤、空虚或麻木

【个人体验】不是偶尔难过一下，而是**像穿了一件湿棉袄**——沉、冷、脱不下来。有人会哭，有人反而哭不出来，只是觉得心里"空了一块""麻麻的"。还有人（尤其是男性）不表现为悲伤，而是**易怒**：一点小事就烦、看谁都不顺眼、对家人没耐心。

> "我不是懒，也不是故意摆脸色。我就是连起床、刷牙、回一条微信，都要在心里给自己做半小时动员。"——这是很多患者的真实独白。

② 快感缺失 / 兴趣减退（Anhedonia）

【个人体验】最有代表性的一句话是：**"我理智上知道以前我喜欢这个，但现在……感觉不到了。"** 以前追的剧、爱吃的东西、想见的朋友、喜欢的游戏，全都变成"哦"。不是不想开心，是"开心"这个按钮好像被拔掉了。

【临床共识】这两条是诊断抑郁发作的**必要条件**：DSM-5 要求在**至少连续 2 周**里，几乎每天的大部分时间都存在其中至少一条（临床实践中通常要求同时有这两条，或其中一条加明显的功能损害），并且造成显著的痛苦或社会功能受损。

1.2 为什么"外表看着没事"不能排除抑郁

【个人体验】很多患者是"微笑型"的——白天能上班、能打招呼、甚至能开玩笑，回家却瘫在沙发上连饭都不想吃。身边人说"你看着挺好的啊"，但只有你知道，那层壳下面有多累。

【临床共识】抑郁不是靠"脸上有没有笑"来诊断的。**能演出来的正常，和真实的内在状态，是两回事。** 外表正常恰恰是很多患者延迟求助的原因之一。

1.3 核心症状自查对照表（可打印、可记录）

> 用法：最近两周，每天在心里打个勾。如果某一项"几乎每天大部分时间"都成立，并且已经持续 ≥ 2 周，请认真考虑就医。

核心症状	我的感受举例（可替换成自己的话）	最近 2 周是否几乎每天	开始日期
情绪低落 / 悲伤 / 空虚	"心里像压着石头""说不上来为什么，就是高兴不起来"	□ 是　□ 否	_____
麻木 / 没感觉	"以前能让我开心的事，现在像隔着一层玻璃"	□ 是　□ 否	_____
易激惹 / 没耐心	"一点小事就想发火，看谁都不顺眼"（尤其男性）	□ 是　□ 否	_____
兴趣减退	"以前喜欢的事，现在连碰都不想碰"	□ 是　□ 否	_____
快感缺失	"吃到以前最爱吃的东西，也没什么味道"	□ 是　□ 否	_____
功能受损	"上班 / 上学 / 做家务 / 照顾自己变得很吃力"	□ 是　□ 否	_____

【个人体验】不必每条都中。哪怕只有"情绪低落"和"兴趣减退"这两条都持续了两周以上，并且已经让你觉得"撑得很辛苦"，就值得去精神科或心理科谈一次——**不必等到"严重到撑不下去"才求助。**

1.4 持续时间与"什么时候该去看医生"

【临床共识】一个相对可操作的参考：

- 上述核心症状 **持续 ≥ 2 周**；
- 并且**已经影响**到工作、学习、人际或日常生活；
- 且不能用最近的明确丧失事件（如刚失去亲人）完全解释。

→ 满足这些，建议尽快就诊。

1.5 一个必须单独说的红灯：自伤 / 自杀念头

【个人体验】有些患者在低落最重的时候，脑子里会冒出"如果我不在了，是不是大家都轻松""活着没什么意思"这种念头。这是**抑郁这个病本身的症状**，不是你这个人"坏"或者"对不起谁"。

【临床共识】一旦你出现具体的自伤或自杀计划、或者觉得自己可能控制不住——请立刻行动：

- 告诉身边一个可信任的人，不要独自待着；
- 拨打全国心理援助热线 **12356**（2025 年起由国家卫生健康委推出的统一心理援助热线），或当地精神卫生中心急诊；
- 情况紧急时直接拨打 120 或前往最近医院急诊。

详细的危机识别与急救步骤，见本资料库模块6"危机识别与急救"专题。

参考来源

- 世界卫生组织：Depression（抑郁症）事实清单
- American Psychiatric Association：DSM-5 重性抑郁障碍诊断标准
- NICE：Depression in adults: treatment and management（NG222）
- 国家卫生健康委员会：全国统一心理援助热线 12356 相关介绍
- 中华医学会精神医学分会：《中国抑郁障碍防治指南（第二版）》。

2. 附加症状

> 上一页讲了两条核心症状。这一页讲的是"除此之外，抑郁还会怎么折腾你"——它们分成认知、躯体、行为三组。很多患者是**先注意到身体或脑子出了问题**，很久以后才意识到"哦，原来是抑郁"。

2.1 认知症状：脑子像灌了浆糊

【个人体验】

- **注意力下降**：开会、看一页书，眼睛在看，脑子像隔着一层雾，读了三行不知道自己读了啥。
- **记忆力变差**：刚说过的话、刚放的钥匙，转头就忘；工作中开始出错，自己都吓一跳。
- **决策困难**：中午吃什么、回不回这条微信，都要纠结半小时——不是选择多，是**做决定的力气没了。**
- **自责自罪 / 无价值感**："都是我的错""我是家里的负担""我什么都做不好"——这些念头根本停不下来，哪怕客观上你做得还行。
- **悲观**：看什么都先想到最坏的结果，觉得"未来不会好了"。
- **思维迟缓**：别人问话，你要缓好几秒才能组织出一句完整的话。
- **反复想到死亡**：不是立刻要做什么，而是"活着到底有什么意思"这类念头反复冒出来。

【临床共识】这些认知症状不是你"变笨了"，而是前额叶功能下降、反刍思维过度活跃的表现——**治疗起效后，它们通常是最先改善的一组。**

2.2 躯体症状：它真的会让身体疼

【个人体验】抑郁最容易被忽视的一面，就是它**披着身体的外衣**：

躯体症状	典型感受
睡眠紊乱	最常见是**早醒**（比平时早醒 2 小时以上，且再也睡不着）；也有人反过来整天嗜睡
食欲改变	明显下降（吃不下）或明显上升（尤其想吃甜食、碳水）
体重变化	一个月内体重变化超过 5%（非刻意减肥/增重）
乏力疲惫	睡了 10 小时还是累，像"被抽走了电"
不明原因疼痛	头痛、颈肩痛、背痛、全身游走性疼痛，检查无器质性问题
肠胃不适	胃胀、便秘、腹泻、食欲差
性欲下降	明显减退
女性月经紊乱	周期、经量改变

【临床共识】**早醒**是抑郁非常有特征性的睡眠信号；而"查不出毛病的躯体不适"是中国患者最先跑到综合医院各科室的原因——消化科、心内科、中医科、神经内科跑一圈，最后才被建议到精神心理科。

2.3 行为症状：你能看出来的那些"不对劲"

【个人体验】

- **行动 / 言语变慢**：走路、说话、回消息都慢半拍；家属可能觉得"他最近怎么木木的"。
- 也有人反过来表现为**激越**：坐不住、来回踱步、手抖、无法安静。
- **回避社交**：以前爱聚会，现在推掉所有邀约，"不想见人，怕被问东问西"。
- **拖延**：一件小事拖一周，不是懒，是启动不了。
- **自我封闭**：把自己关在房间里，窗帘都不想拉开。
- **个人卫生变差**：不洗澡、不换衣服、胡子好几天不刮——不是邋遢，是**连照顾自己的力气都没有了**。

【个人体验】这一段特别想对家属说：**别把这些行为理解成"他就是不想好""他懒""他针对我们"**。这是病在消耗他的能量。

2.4 附加症状自查清单（可直接使用）

> 用法：最近 2 周，在"我有没有"一栏打勾，在"持续多久"一栏写下大概天数。就诊时把这张纸带给医生看，会非常省时间。

分类	症状	具体表现	我有没有	持续多久
认知	注意力下降	看书/听人说话容易走神	□ 有 □ 无	____ 天
认知	记忆力变差	转头就忘事、工作出错	□ 有 □ 无	____ 天
认知	决策困难	小事都难以下决定	□ 有 □ 无	____ 天
认知	自责自罪	总觉得都是自己的错	□ 有 □ 无	____ 天
认知	无价值感 / 悲观	"我没用""不会好了"	□ 有 □ 无	____ 天
认知	思维迟缓	脑子像灌了浆糊	□ 有 □ 无	____ 天
认知	反复想到死亡	"活着没意思"类念头	□ 有 □ 无	____ 天
躯体	睡眠紊乱	早醒 / 失眠 / 嗜睡	□ 有 □ 无	____ 天
躯体	食欲 / 体重变化	一个月内变化 >5%	□ 有 □ 无	____ 天
躯体	乏力疲惫	睡多久都累	□ 有 □ 无	____ 天
躯体	不明原因疼痛	头痛/背痛/全身痛	□ 有 □ 无	____ 天
躯体	肠胃不适	胃胀/便秘/腹泻	□ 有 □ 无	____ 天
躯体	性欲下降	明显减退	□ 有 □ 无	____ 天
行为	行动/言语变慢或激越	反应迟钝 / 坐立不安	□ 有 □ 无	____ 天
行为	回避社交 / 自我封闭	推掉所有邀约	□ 有 □ 无	____ 天
行为	拖延	小事都启动不了	□ 有 □ 无	____ 天
行为	个人卫生变差	不洗澡、不换衣	□ 有 □ 无	____ 天

【临床共识】DSM-5 的诊断要求是：**至少 5 个症状**（其中必须包含两条核心症状之一或两条），几乎每天、持续至少 2 周，并造成功能损害。上面这张表就是帮你数清楚"我到底中了几条"。

2.5 一个重要的提醒

【个人体验】如果你的主诉是"我就是睡不好、胃不舒服、头疼"，跑了几个科都没查出问题——**请认真考虑去精神心理科聊一次。**这不是说你"想多了"，而是抑郁的躯体化在中国患者身上太常见了，早识别就能少走很多弯路。

参考来源

- 世界卫生组织：Depression（抑郁症）事实清单
- American Psychiatric Association：DSM-5 重性抑郁障碍诊断标准
- NICE：Depression in adults: treatment and management（NG222）
- 中华医学会精神医学分会：《中国抑郁障碍防治指南（第二版）》。
- Malhi GS, Mann JJ. Depression. *Lancet*. 2018;392:2299-2312. DOI: 10.1016/S0140-6736(18)31943-331943-3)

3. 不同亚型特点

> "抑郁"不是一张脸。有的人是睡不着+吃不下+整天哭，有的人是整天想睡+暴食+懒得动，有的人只在冬天发病……这些不同的"长相"在医学上叫**亚型**或**特征标注（specifiers）**。知道自己属于哪一类，能帮医生选更对的治疗方案。本页为科普，具体分型由医生判断。

3.1 亚型特点对照表（先看全）

亚型 / 特征	典型表现	患者常见感受	提示
伴焦虑痛苦	紧张、坐立不安、担心失控、心悸	"我不只是低落，我还一直慌"	焦虑越重，越要优先处理，恢复更慢
伴精神病性症状	幻觉、妄想（自罪、疑病、贫穷妄想）	"我坚信自己有罪 / 身体已经烂了"	需尽快就医，可能需联合治疗
非典型抑郁	嗜睡、暴食、体重增加、肢体像灌了铅、情绪能因好事短暂好转、对拒绝特别敏感	"别人一叫我名字我就觉得是不是我做错了"	抗抑郁药选择上可能有讲究
季节性抑郁（冬季型）	每年秋冬规律发作、春夏缓解；过眠、贪食碳水	"一到秋天我就知道完了"	光照治疗（光疗）有效
持续性抑郁障碍（恶劣心境）	≥2年长期轻度低落，不像重性发作那么剧烈	"我以为我天生就是这样的人"	容易被当成性格，治疗周期长
围产期抑郁	孕期或产后出现低落、焦虑、怕伤害宝宝	"我不是个好妈妈"	家人支持是关键，可治疗
老年抑郁	躯体不适多、记忆下降、易被误当痴呆	"我浑身都难受，记性越来越差"	需与痴呆鉴别
儿童青少年抑郁	以**易激惹**为主，不一定是哭泣	"就是烦，谁都别理我"	易被误认为叛逆

3.2 重点亚型展开讲

（1）伴焦虑痛苦的抑郁

【个人体验】最常见的组合。你不只是"不想动"，还"坐不住"——心里发紧、手心出汗、总担心"是不是要出什么事"、半夜醒来心跳很快。

【临床共识】焦虑痛苦程度是预测治疗反应和自杀风险的重要指标。如果你发现自己"低落 + 紧张"同时存在，就诊时**一定要单独把焦虑讲出来。**

（2）伴精神病性症状的抑郁

【个人体验】这是比较严重的一种。典型的妄想包括：

- **自罪妄想**：坚信自己犯了滔天大罪、对不起所有人；

- **疑病妄想**：坚信自己得了不治之症、内脏已经烂了；
- **贫穷妄想**：坚信自己和家人已经一贫如洗、活不下去；
- 也可能出现幻听（听到有人骂自己、说自己该死）。

【临床共识】这些妄想的内容通常和抑郁情绪是"配套"的（心境协调）。它**不等同于精神分裂症**——抑郁好转后，这些症状通常随之消退。但出现这类体验，请尽快就医。

（3）非典型抑郁："懒"和"能开心一下"是关键线索

【个人体验】这种亚型容易被漏诊，因为它有几个"反着来"的特点：

- **嗜睡**：不是失眠，而是整天睡不醒；
- **暴食、体重增加**：不是吃不下，而是疯狂想吃碳水；
- **肢体铅样沉重感**：胳膊腿像灌了铅，抬起来都费劲；
- **情绪反应性**：和经典抑郁不同，**遇到好事你能短暂地好起来**（比如朋友打电话来，能高兴半小时）；
- **对拒绝高度敏感**：别人一句无心的话，你能难过一整天。

【临床共识】"非典型"这个词不是说它"奇怪"，而是指它在症状模式上与经典抑郁相反。识别它有助于医生选对药物（某些经典抗抑郁药对非典型抑郁反应不如另一些）。

（4）季节性抑郁（冬季型）

【个人体验】"一到 10 月我就知道，老毛病又来了。春困秋乏是开玩笑，但我是真的每年冬天都低落、过眠、特别想吃面包和甜食，等到 3、4 月太阳一出来，自己就好了。"

【临床共识】诊断要求这种"秋冬发作、春夏缓解"的规律**连续出现 ≥ 2 年。光照治疗（每日定时接受强光照射 30 分钟左右）**是公认有效的手段之一，不是"多晒晒太阳就行"那么随意，而是有规范方案的。

（5）持续性抑郁障碍（恶劣心境）：最容易被当成"性格"

【个人体验】详见模块1"名词释义"。核心感受是："我一直以为我就是这种人——内向、悲观、没劲。直到有一年被一件事压垮，去看病，医生说：你前面那十几年也是病。"

【临床共识】ICD-11 仍单列"恶劣心境障碍（6A72）"，成人要求持续 ≥ 2 年；DSM-5 并入"持续性抑郁障碍"。这种慢性状态虽然单次症状不如重性发作剧烈，但**对生活质量的长期侵蚀非常大**，且一样可以治疗。

（6）围产期、老年、儿童青少年：特殊人群的"长相"

- **围产期抑郁**：孕期或产后出现，常伴随"我不是个好妈妈""我怕自己会伤害宝宝"的强烈内疚。家人的识别和支持比什么都重要，**它可以治疗，且不影响多数人安全哺乳**（具体用药遵医嘱）。
- **老年抑郁**：常常不主诉"心情不好"，而是主诉"睡不好、浑身疼、记性越来越差"——容易被家属当成"老糊涂了/痴呆"。它和痴呆的鉴别非常重要，因为抑郁治好后，记忆往往能明显恢复。
- **儿童青少年抑郁**：核心表现不是哭泣，而是**易激惹**——"谁都别惹我""看什么都烦"，常被家长简单归因为"叛逆""青春期"。如果同时有成绩骤降、回避朋友、睡眠食欲改变，请认真考虑就诊。

3.3 写给患者的一段话

【个人体验】看到这里你可能会对号入座："我是不是非典型？""我是不是季节性？"——**分型是医生的工作，不是你的作业。**你要做的，是把上面这些"哪些表现像我、哪些不像"记下来，在就诊时给医生提供素材，而不是自己下结论。

参考来源

- 世界卫生组织：Depression（抑郁症）事实清单
- American Psychiatric Association：DSM-5 标注（specifiers）官方介绍
- 世界卫生组织：ICD-11 浏览器
- NICE：Depression in adults: treatment and management（NG222）
- 中华医学会精神医学分会：《中国抑郁障碍防治指南（第二版）》。
- Lam RW, et al. Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments (CANMAT) 2016 Clinical Guidelines for the management of adults with major depressive disorder: Seasonal affective disorder. *Can J Psychiatry*. 2016;61(9):560-566.

4. 疾病分期

> 抑郁不是"好了"或"没好"的二元状态，它像一场感冒，有发作期、恢复期，也有需要长期保养的稳定期。这一页告诉你：现在大概在哪一期、这一期医生在想什么、你能做什么、**为什么千万不要自己觉得好一点就停药**。分期由医生判断，本页帮你听懂医生的话。

4.1 四个阶段：先看全图

阶段	大致时长（成人常见区间）	医生的目标	你能做什么
① 急性期（发作期）	通常 **6–8 周左右**（药物起效后评估），有的需 3 个月	控制急性症状，争取症状明显减轻（有效）或基本消失（临床痊愈）	遵医嘱服药、保证基本作息、不硬扛工作
② 巩固期	**4–9 个月**（症状缓解后继续治疗）	防止症状卷土重来（复燃），恢复社会功能	维持药量、逐步恢复工作/社交、定期复诊
③ 维持期	**因人而异常需数年**；多次复发者更长甚至长期	预防**新的一次**发作（复发）	学会识别预警信号、规律随访、生活方式管理
④ 缓解期（临床痊愈）	由医生评估后逐步减停	在维持足够长时间后，科学、缓慢地停药	与医生一起制定减药计划，不擅自停

> 注意：以上时长是**常见参考区间**，不是死规定。具体时长由你的医生根据发作次数、严重程度、残留症状等个体化决定。

4.2 每期的真实感受与任务

① 急性期：最难熬的那段

【个人体验】"我每天醒来第一件事就是想：今天又要熬一天。药吃了两三个星期好像没什么变化，差点想放弃。"

【临床共识】这一阶段最常见的困惑是：**"药怎么还没效?"** 抗抑郁药通常需要 **2–4 周**才开始显现情绪改善，6–8 周才能评估是否足够。这段时间请务必：

- 不要因为"前两周没感觉"就自行停药；
- 如果 2 周内副作用明显（恶心、头晕、焦虑暂时加重），及时跟医生沟通，而不是自己减量；
- 急性期中**尽量不要给自己定"必须好起来"的 KPI**，能活着、能基本自理就是胜利。

② 巩固期：感觉好一点了，但这时候最容易出事

【个人体验】"药起效了，我能睡了、能吃饭了、能回消息了。我心想：好了呀，可以停药了吧？"

【临床共识】**这恰恰是复发率最高的阶段。** 症状刚缓解时，大脑的神经可塑性其实还没有完全恢复，药物需要继续"托住"你。研究数据反复显示：

- 【研究结论】**急性期症状一消失就停药，约半数人会在几个月内复燃**；
- 而按指南完成巩固期（4–9 个月）治疗的人，复燃比例显著下降。

你在巩固期的任务不是"赶紧停药"，而是**在药物保护下慢慢把生活节奏找回来**：恢复工作、重建社交、开始规律运动。

③ 维持期：和抑郁"长期共舞"

【个人体验】"医生说我复发过两次了，建议我再吃久一点。我一开始有点沮丧——难道要吃一辈子药吗？后来想通了：高血压也得长期吃药，这没什么丢人。"

【临床共识】维持期的长短**取决于你发作过几次**：

- 首次发作、症状轻、缓解彻底：维持期可相对短；
- **发作 ≥ 2 次，或有明显家族史、残留症状、冬季发作等：通常建议维持数年**；
- **发作 ≥ 3 次：多数指南建议长期（甚至长期）维持治疗。**

维持期不是"病没好"，而是像骨折后戴护具——**等骨头真正长牢了再拆。**

④ 缓解期：科学地"毕业"

【临床共识】停药从来不是"一下子不吃了"，而是**在医生指导下逐步、缓慢减量**，通常数月内逐步完成。自行突然停药可能出现撤药反应（头晕、流感样症状、情绪反跳）。减药期间及减药后 6 个月内，都要格外留意复发预警信号（见模块6）。

4.3 一张表：分期-我的状态-治疗重点-我能做什么（可打印）

> 用法：复诊时和医生一起填这张表，能避免"我感觉好了就停药"这类误判。

阶段	我目前的状态（自评）	医生说的治疗重点	我这周能做的一件小事
急性期	□ 还在最难熬 □ 刚有点起色	控制症状、观察药物反应	_____
巩固期	□ 症状基本消失 □ 还有点残留	防复燃、恢复功能	_____
维持期	□ 状态稳定 □ 偶尔有波动	防复发、生活方式管理	_____
缓解期	□ 准备减药 □ 已停药随访	缓慢减量、识别预警	_____

4.4 为什么"症状好转 ≠ 治愈"——这是本页最重要的一句话

【研究结论】把上面的数字连起来看：

- 单次发作痊愈后，**约 50% 的人会再次发作**；
- 发作 2 次后，复发风险升至 **70%–80%**；

- 发作 3 次以上，复发风险可达 **90%**。

而**规范、足疗程治疗能把复发率显著压低**——这就是为什么医生在你"感觉已经好了"之后，仍然坚持让你继续吃药。这不是医生不信任你，而是医生见过太多"自己停药、几个月后又回来"的故事。

【个人体验】最后想说：分期是个动态的东西，不是你"进了维持期就一辈子出不来"。很多人在规范治疗、稳定数年、学会自我管理之后，在医生指导下顺利减药、停药，过上了和常人无异的生活。**抑郁是一场需要康复期的病，但不是无期徒刑。**

参考来源

- 世界卫生组织：Depression（抑郁症）事实清单
- NICE：Depression in adults: treatment and management（NG222）
- 中华医学会精神医学分会：《中国抑郁障碍防治指南（第二版）》。
- American Psychiatric Association：Practice Guideline for the Treatment of Patients with Major Depressive Disorder
- Rush AJ, et al. Effects of depression in reducing risk of relapse and recurrence. *Am J Psychiatry*.（抗抑郁药长期维持与复发率相关综述）
- Malhi GS, Mann JJ. Depression. *Lancet*. 2018;392:2299-2312. DOI: 10.1016/S0140-6736(18)31943-331943-3)

1. 生物学因素

> 抑郁不是"想不开"，它有真实的生物学基础；但也没有任何一项验血、基因检测或脑扫描能单独证明"你就是抑郁了"。这些因素解释的是"为什么你比别人更容易被压力击倒"，而不是对你的人格下判决。

一、为什么要先谈生物学

很多人第一次知道"抑郁有生物学原因"时，反应是松了一口气——原来不是我这个人不好。【临床共识】抑郁障碍是一组有生物学参与的疾病，像高血压、糖尿病一样存在易感基础；但它又和血压不同：目前没有单一的"抑郁指标"，医生靠症状、病程和功能损害来诊断，而不是靠某张化验单。

二、遗传易感性：是"易感性"，不是"宿命"

- 流行病学研究显示，抑郁障碍有家族聚集倾向。一级亲属（父母、子女、同卵兄弟姐妹）患病，本人风险大约是一般人群的 **2～3 倍**。
- 双生子研究提示同卵双生子的同病一致率高于异卵双生子，说明遗传有贡献；但同卵双生一致率也远不是 100%（多数研究在 30%～50% 量级）。
- 这意味着：抑郁是**多基因、微效基因叠加**的结果，没有一个"抑郁基因"。家族史高只代表概率升高，不代表必然发病；反过来，没有家族史也完全可能得病。

【对患者的意义】如果家里有人得过抑郁，不必惊慌，也不必互相指责"是不是你遗传给我的"。共享的饮食习惯、应对方式、压力环境同样在起作用。

三、神经递质与受体：5-HT、NE、DA

血清素（5-HT）、去甲肾上腺素（NE）、多巴胺（DA）是最常被提到的三种神经递质。抗抑郁药（如 SSRI）正是通过调节这些系统起作用。

但要警惕一个流传很广的简化说法："抑郁就是血清素太低了"。【研究结论】2022 年一项系统综述（Moncrieff 等）回顾证据后指出，"血清素不足导致抑郁"这一假说并没有得到可靠证据支持；递质异常更像是参与机制之一，而非病因本身。药物能治病，不等于病因就是"缺药"。

四、神经环路、海马与神经可塑性

脑影像研究发现，抑郁者负责情绪调节的环路（如前额叶—边缘系统）活动模式与健康人不同，部分研究观察到海马体积偏小、海马神经发生下降。慢性压力会升高糖皮质激素，损伤神经可塑性；而抗抑郁药、规律运动和心理治疗在动物模型中都被观察到可促进可塑性修复。这解释了为什么"熬过去、治疗后会慢慢好"是有生物学依据的。

五、神经内分泌：HPA 轴与皮质醇

慢性应激模型中，下丘脑—垂体—肾上腺（HPA）轴长期亢进，皮质醇持续偏高，与抑郁、失眠、食欲改变互为因果。这不是"压力大而已"，而是身体的应激开关卡住了。

六、激素与躯体状况

因素	通俗解释	对患者的意义
甲状腺功能减退	甲状腺素不足会让人乏力、嗜睡、情绪低，很像抑郁	初诊常查甲功，异常时治疗甲状腺即可明显改善情绪
性激素 / 产后 / 围绝经期	激素剧烈波动是产后抑郁、围绝经期情绪问题的诱因之一	女性在这些特殊阶段要格外关注情绪信号
慢性炎症 / 躯体疾病	感染、肿瘤、慢性病可伴发情绪低落	医生排查躯体病不是多余，是排除可治病因
某些药物	部分降压药、激素、干扰素等可诱发情绪低落	就诊时务必带上全部用药清单

【争议观点】"炎症假说"认为抑郁与低度慢性炎症有关，部分研究观察到炎症标志物升高，但抗炎治疗能否治抑郁仍在研究中，不能据此自行吃消炎药。

七、一张表看懂

机制	一句话解释	对"我"意味着什么
遗传易感性	体质上更敏感	风险升高，不注定
神经递质	情绪信号传递出问题	药物可调，但不是"缺什么补什么"
神经环路/可塑性	大脑的情绪调节肌肉变弱	治疗、运动、心理训练可修复
HPA 轴亢进	压力开关卡住	减压、规律作息是在帮身体复位
激素/躯体病	身体问题伪装成抑郁	配合检查，别只盯着"心情不好"

参考来源

- 世界卫生组织：Depression fact sheet
- NICE：Depression in adults: treatment and management, NG222
- Moncrieff J, et al. The serotonin theory of depression: a systematic umbrella review of the evidence. *Mol Psychiatry*. 2023. doi:10.1038/s41380-022-01661-0
- 黄悦勤等. 中国精神卫生调查. *Lancet Psychiatry*. 2019. doi:10.1016/S2215-0366(18)30511-X30511-X)
- NIMH：Depression

2. 心理因素

> 那些让你反复陷入低谷的思维习惯、对自己的苛刻态度、过去经历留下的反应模式，确实是抑郁的土壤。但它们是**可以被识别和改写的模式**，不是"你这个人就是想太多、活该难受"。

一、核心观念：模式是学来的，也能被改写

【临床共识】心理治疗（尤其是认知行为治疗 CBT）对抑郁有效，其前提就是：导致抑郁的负性思维和行为模式不是性格原罪，而是长期习得的反应习惯。既然是学来的，就可以通过训练重新学习。

二、贝克认知三角：抑郁时你脑子里在想什么

心理学家贝克（Aaron Beck）发现，抑郁者往往同时被三方面的负性信念困住：

1. **对自己**：我没用、我有缺陷、我不值得被爱。
2. **对世界/外界**：世界充满阻碍、别人对我不公平。
3. **对未来**：未来只会更糟，努力没有意义。

这三者互相强化，形成一个越转越深的漩涡——这也是为什么抑郁时人会觉得"道理我都懂，就是高兴不起来"。

三、常见认知歪曲类型对照表

认知歪曲	通俗含义	抑郁时的典型内心独白	更平衡的想法
非黑即白	要么完美要么失败	"这次汇报有瑕疵，我彻底完了"	"整体可以，有部分能改进"
过度概括	一件事=永远如此	"他拒绝我，说明没人会喜欢我"	"这个人不合适，不代表所有人"
灾难化	把小事想成最坏结局	"心慌一下，我是不是要猝死了"	"先观察，必要时就医"
心理过滤	只盯着负面，过滤掉好的	"一百句夸里那句批评是真的"	"那一句可以改，其余也是事实"
贬低积极	把好事说成巧合	"他夸我只是客气"	"别人的善意也值得收下"
情绪推理	感觉=事实	"我觉得自己没用，所以我就是没用"	"这是低落时的感觉，不是事实"
"应该"陈述	用苛刻规则压自己	"我应该早就好起来了"	"恢复有自己的节奏"
贴标签	一次失败定义整个人	"我是个废物"	"我这次没做好，不等于我是废物"

四、其他常见心理底色

- **完美主义与高自我批评**：对自己要求极高，微小失误也引发强烈羞耻。很多"优秀的人"因此抑郁。
- **反刍思维**：一件事在脑子里反复回放、反复自责，停不下来。反刍越久，抑郁越重。
- **依恋模式**：早年形成的"我是否值得被照顾""别人是否可靠"的内部工作模式，影响成年后应对压力和求助。

- **早年创伤与不良童年经历（ACE）**：被忽视、虐待、家庭冲突等经历会显著升高成年后抑郁风险。【研究结论】ACE 分数越高，成年抑郁、物质使用等问题风险越高——但这是**风险因素，不是判决书**，很多经历过创伤的人发展出了很强的复原力。
- **习得性无助**：长期面对无法控制的困境后，学会了"挣扎也没用"，这种被动感会延续到本可以改变的事情上。

五、最重要的一句话

【个人体验】"我之所以这样，是因为我太脆弱、想太多"——这句话本身就是抑郁思维的一部分。心理因素解释的是你为什么容易被压垮，而不是你活该被压垮。下一节的环境诱因会告诉你：没有谁在真空中得病。

参考来源

- Beck AT. *Cognitive Therapy and the Emotional Disorders*. International Universities Press, 1976.
- WHO：Depression fact sheet
- NICE：Depression in adults: treatment and management, NG222
- Hughes K, et al. The relationship between multiple adverse childhood experiences and health: systematic review and meta-analysis. *BMC Public Health*. 2017;17:1-15.
- 中华医学会精神医学分会.《中国抑郁障碍防治指南》（第二版）. 中华医学电子音像出版社.

3. 环境诱因

> 很少有人是"凭空"抑郁的。重大变故会击倒人，长期慢性压力更是像滴水穿石。但请记住：**环境因素触发的是疾病，不是你的错**——就像淋雨会感冒，没人会因此责怪淋雨的人。

一、素质—应激模型：理解"为什么是现在"

【临床共识】当代主流模型是"素质—应激模型"（diathesis-stress model）：你先天和早年形成的"易感素质"是杯子里已有的水，生活中的应激事件是不断往里添的水。杯子满了溢出来，就是一次发作。所以同样一件事，有人扛得住，有人扛不住——不是谁坚强谁脆弱，是杯子里本来有多少水不一样。

二、常见环境诱因清单

急性重大事件

- 亲人离世、失恋、离婚、关系破裂。
- 被裁员、失业、重大经济损失。
- 突发重大疾病、外伤、事故。
- 遭受暴力、霸凌、重大羞辱性事件。

慢性长期压力（更隐蔽，也更常见）

- 长期高强度工作、996、职业耗竭。
- 长期照顾病患老人或孩子（照顾者负担）。
- 长期孤独、社会隔离、独居缺乏人际联结。
- 长期家庭冲突、家暴、有毒关系。
- 长期睡眠剥夺、倒班、作息紊乱。
- 迁居、出国、文化适应困难。
- 产后（激素 + 睡眠剥夺 + 角色剧变叠加）。
- 重大公共事件（疫情、灾害）带来的集体性焦虑。

【研究结论】追踪研究发现，**慢性持续的压力**对抑郁的预测力往往不亚于单一重大事件——它不戏剧化，所以容易被自己和别人忽略。

三、环境诱因自查表

诱因类别	常见场景	我现在有几分符合（0–3）
丧失	近半年内失去重要关系/亲人	|

诱因类别	常见场景	我现在有几分符合（0–3）
工作/经济压力	长期超负荷、失业、负债	
人际冲突	家庭、职场、亲密关系长期紧张	
孤独隔离	一周几乎没有可以说话的人	
照顾负担	长期照顾他人，没有自己的时间	
睡眠紊乱	长期失眠/熬夜/倒班	
身体变故	本人或家人生病、手术	
产后/激素期	产后、围绝经期等阶段	

> 打勾不是为了自责"我压力这么大活该病了"，而是帮你和医生看清：哪些是可以动手改善的外部条件。

四、时间关系的小知识

很多抑郁发作前 3～6 个月确实能找到应激事件；但也有不少人是"压力已经过去，人却垮了"——这符合应激后 HPA 轴和神经系统延迟反应的特点，不代表"你反应过度"。

五、给患者的两句话

1. **不能把得病归咎于环境，也不能把它当成纯外部事件**——环境触发、素质承接，两者缺一不可。
2. **能改的环境要动手**（能调整工作就调整，能求助就求助），但别指望"把环境全改好才配好起来"——很多人是在环境没变的情况下，靠治疗先把杯子里的水倒出去。

六、正常应激反应 vs 需要就医

- 遭遇重大丧失后，几周内情绪低落、想哭、失眠，多数人会随时间和支持慢慢恢复。
- 【临床共识】如果低落持续超过两周、几乎全天如此、兴趣完全丧失、出现无价值感或自伤念头、功能明显受损（不能上班/上学/自理），就不再是"扛一扛就过去"的范围，应就诊。
- 慢性压力没有明确的"事件"，最容易被忽视——如果你已经连续几个月觉得"撑不住"，不需要等一件"大事"才允许自己求助。

七、多因素叠加模型

没有一个人是被单一原因压垮的：一段糟糕的工作（环境）+ 天生敏感的气质（素质）+ 长期反刍的习惯（心理）+ 最近连续熬夜（行为），杯子才会溢出来。理解这一点，你就不会再执着于"到底是谁的错"，而会去想：**现在我能松动哪一块？**

参考来源

- WHO：Depression fact sheet
- NICE：Depression in adults: treatment and management, NG222

- 黄悦勤等. 中国精神卫生调查. *Lancet Psychiatry*. 2019. doi:10.1016/S2215-0366(18)30511-X30511-X)
- Kendler KS, et al. Stressful life events, genetic liability, and onset of an episode of major depression in women. *Arch Gen Psychiatry*. 1995;52(10):833-842.
- WHO mhGAP 干预指南：Depression management<tool_call>

</invoke>

4. 常见误区澄清

> 这一篇专门拆那些让人更羞耻、更不敢求助的说法。每一条误区背后，都站着一个不好意思看病的人。如果你曾对号入座过任何一条，请把它划掉。

误区—事实—可以怎么想

误区	事实	可以怎么想
抑郁就是性格软弱、心胸狭窄	抑郁是有生物学和心理基础的疾病，和坚强与否无关	"我生病了，不是我这个人差"
就是想不开，想开点就好了	抑郁时大脑的情绪调节功能下降，"想开"恰恰做不到	"我需要治疗，而不是被劝两句"
穷人/闲人才抑郁，矫情	各阶层、各职业、各文化都会得病，名人也不例外	"和我有没有钱、忙不忙没关系"
单一原因造成的，比如失恋/失业	是素质、心理模式、环境、躯体因素叠加	"不用逼自己找一个罪魁祸首"
都怪父母遗传，或都怪我自己	多基因遗传、共享环境共同作用，谁都不该被追责	"这不是任何一个人的错"
男人/强者不会抑郁	男性患病率略低但求助率更低，常以易怒、酗酒、逃避表现	"我也可以是那个会求助的强者"
"我经历的事不够惨，所以不配得病"	发病看易感性与叠加，不看"苦难排行榜"	"我的痛苦不需要别人审批"
得了抑郁就是一辈子完了	多数人经规范治疗可明显好转、恢复功能	"这是一段可以过去的病程"

为什么这些误区必须拆

【临床共识】污名和自我指责是抑郁者延误就医、不坚持治疗的主要原因之一。"我是不是太矫情了"这个念头本身，往往就让人把号又退了。

【个人体验】很多康复者回忆，最难的不是症状本身，而是"我是不是活该"。把这句话换掉，治疗之路就走顺了一半。

一个小练习

下次脑子里冒出"我是不是太脆弱了"，把它改写成：

> "我的身体和大脑现在生病了，就像我感冒时不会骂自己免疫力差一样。"

五、身边人常说的话，你可以这样回应

别人常说	内心真实 OS	你可以试着说
"你就是想太多"	我也不想，但停不下来	"这不是想不想的问题，是生病了"
"比你惨的人多了"	那为什么我还是这么难受	"痛苦不需要比赛，我的感受是真的"
"出去旅旅游就好了"	我连出门都没力气	"现在更需要的是看病和规律治疗"
"你就是闲的"	我每天累到崩溃	"忙和闲都可能抑郁，这不是原因"
"为了孩子/家人也要振作"	我已经很努力在撑了	"正是为了他们，我要规范治疗"

六、关于"是不是我爸妈害的"

很多人患病后会翻旧账：是不是我父母的教育方式？是不是家里的气氛？【个人体验】去责怪一个已经生病的家庭，和去责怪自己一样，都不解决问题。早年经历确实是风险因素之一，但你现在成年了，治疗室、药物、自我照顾都在你自己手里。把力气从"追责"转到"康复"，路会顺很多。

七、一个判断标准

下次再听到任何一句让你羞耻的话，问自己：**"如果我得的是肺炎/骨折，这句话还说得出口吗？"** 说不出口，那它就不该被用在抑郁身上。

八、家属/伴侣常有的误区

- "他就是跟我闹情绪，哄哄就好"——情绪低落不是撒娇，哄和劝代替不了治疗。
- "家里没人得过，他怎么会得"——没有家族史也完全可能患病。
- "都住院了，是不是疯了"——精神科住院和内科住院一样，是为了系统治疗，不是"发疯"。

【个人体验】很多患者最需要的一句支持是："这不是你的错，我们一起想办法。"如果你正在读这篇，也请把这句话留给自己。

参考来源

- WHO：Depression fact sheet
- NICE：Depression in adults: treatment and management, NG222
- 中华医学会精神医学分会.《中国抑郁障碍防治指南》（第二版）.
- WHO mhGAP：Guide

5. 诱发复发的常见触发事件

> 复发不是你"前功尽弃"，也不是失败。它像感冒会再得一样常见。知道哪些是自己的"雷区"，提前踩好刹车，复发风险就能明显下降。

一、最需要警惕的触发事件（按可干预程度排序）

1. **擅自减药、停药**——【临床共识】这是最常见、也最可避免的复发原因。症状一好就停药，复发率显著升高；是否减停必须由医生评估，通常建议症状缓解后继续维持治疗数月至更久。
2. **睡眠紊乱、连续熬夜/倒时差**——睡眠是情绪的承重墙，连续几天睡不好，情绪阈值立刻下降。
3. **持续高压或突发应激**——失业、分手、丧亲、家庭冲突、重大考试。
4. **季节变换**——秋冬季日照减少，部分人出现季节性情绪低落。
5. **产后**——激素波动叠加睡眠剥夺。
6. **躯体疾病、手术、感染**——身体应激会拖垮情绪。
7. **酒精、镇静类物质、毒品**——短期放松，长期破坏情绪调节和睡眠。
8. **社交退缩后长期孤立**——一个人扛、切断联系，是复发的温床。
9. **治疗中断、失访**——不再复诊、不再监测，苗头出现时没人帮你看。

二、复发触发自检表

触发事件	早期苗头（我要警惕的信号）	我的应对预案（提前写好）
想减药/停药	"我好了，可以不吃了"	先约医生，不擅自改
连续熬夜	凌晨还醒着、白天撑不住	固定起床时间，必要时复诊调助眠
突发压力	心慌、想哭、不想见人	联系信任的人/心理咨询师，不硬扛
季节变换	入秋后情绪莫名低落	多户外活动，必要时提前复诊
喝酒/ substance	借酒消愁后更糟	设定上限，难受时改用别的求助方式
社交退缩	开始不回消息、不出门	哪怕每周见一个人也行

三、两句话让你安心

- **有触发因素 ≠ 一定会复发。**它只是提醒你：该把维持治疗和自我照顾拧紧一点。
- **提前写好"应对预案"是最有效的预防。**等复发苗头出来再想怎么办，往往来不及；现在状态好的时候写好，未来的你会感谢现在的你。

【个人体验】康复者常说："复发不是回到原点，是带着经验再走一遍。"

四、复发早期苗头清单（出现 2 条以上就要警觉）

- 连续几天入睡困难或早醒；
- 对以前喜欢的事又开始提不起劲；
- 容易因为小事烦躁、想哭；
- 不想见人、消息开始不回；
- 脑子里冒出"停药也没关系"的念头；
- 注意力下降，工作/家务开始出错；
- 又开始喝酒或比以前喝得多。

【临床共识】这些信号比"全面崩溃"早出现一到两周，是干预的黄金窗口。

五、一份具体的"应对预案"长什么样

举个例子，你可以照这个格式写自己的：

> 当我连续三天睡不好，并且开始不想回朋友消息时：
> 1. 本周内预约主治医生复诊，说明情况；
> 2. 不擅自减药；
> 3. 主动约一个信任的朋友吃顿饭（哪怕只坐半小时）；
> 4. 把晚上的酒换成无酒精饮料；
> 5. 如果出现自伤念头，立刻打心理援助热线或去急诊。

把这张纸贴在冰箱上。状态好的时候写，状态差的时候照着做。

六、复发不等于失败

【个人体验】多次复发的人常说：每复发一次，你就更认得自己的早期信号。复发率随发作次数升高是事实，但**规范维持治疗 + 提前预案**能显著降低概率。你不是在"防一次失败"，而是在学一套受用很久的自我管理技能。

参考来源

- NICE：Depression in adults: treatment and management, NG222（含复发预防与维持治疗建议）
- WHO：Depression fact sheet
- 中华医学会精神医学分会. 《中国抑郁障碍防治指南》（第二版）.
- Guloksuz S, van Os J. The slow death of the concept of schizophrenia and the painful birth of the psychosis spectrum. *Psychol Med*. 2018（关于复发与应激模型的一般讨论）.
- 美国精神病学会：DSM-5 抑郁障碍诊断与病程

1. 就诊渠道

> 第一步往往最难：不知道去哪、怕被别人看见、怕说错话。这一篇把常见渠道讲清楚，让你心里有底——**诊断和开药，只有精神科执业医师能做；心理咨询师不能替代医生。**

一、主要就诊渠道对照

渠道	能做什么	不能做什么	适合谁
精神卫生中心/精神专科医院	完整诊断、开药、物理治疗、住院	排队久、病耻感环境相对重	症状较重、需要药物或系统治疗
综合医院精神科/心理科/心身医学科	诊断、开药、与躯体疾病同治	号源紧张	同时有身体不适、想在普通医院看
基层医疗机构/全科	初步识别、转诊、随访	不能处理复杂病例	轻症、随访、开转诊单
心理咨询机构/学校心理辅导/EAP	谈话治疗、情绪支持、心理评估	**不能做医学诊断、不能开药**	已确诊配合治疗、或轻度情绪困扰
互联网医院/线上复诊	复诊、续方开药、线上咨询	首诊一般不建议、不能做体格检查	老患者续药、不便线下者
急诊/住院	紧急自杀自伤风险、严重木僵/躁狂	不是普通就诊渠道	有 immediate 安全风险时

二、挂号科别怎么选

- 第一次看、不知道轻重：挂"精神科"或"心理科"普通门诊即可，不必一上来抢专家号。
- 以身体不适为主（胸闷、失眠、查不出原因）：可挂"心身医学科"或"身心医学科"。
- 综合医院没有精神科：先看全科/内科排查身体问题，请医生转诊。

三、几个你可能担心的问题

隐私与保密。【临床共识】精神科病历受隐私保护，未经本人同意不得向单位、家属随意披露（危及自身或他人安全等法定情形除外）。

费用与医保。 多数地区精神科门诊、常用抗抑郁药已纳入医保/门诊慢特病范围，挂号时可问收费处。心理咨询一般自费为主。

心理咨询 ≠ 看病。 如果你已经持续两周以上情绪低落、影响生活，单纯和咨询师聊天可能不够；该走的医学诊断流程不能省。反过来，确诊后配合心理咨询，效果往往更好。

四、什么时候直接去急诊

出现强烈自伤/自杀念头、已经有计划或准备、整夜哭喊无法入睡、行为紊乱——不要等普通号，直接去最近的精神科急诊或综合医院急诊。

五、第一次挂号的实操建议

- 不知道自己多重：先挂**普通号**，让医生评估，不必一上来抢专家号（专家号贵且等待久，初诊普通号足够）。
- 挂不上号：很多医院有预约平台/公众号，提前 1～7 天放号；也可到分诊台说明情况请护士帮忙加号。
- 综合医院没号：先挂全科/内科，告知"情绪低落、失眠很久"，请医生开具转诊或排查身体问题。
- 异地/小城居民：可先到县医院或社区卫生服务中心，由基层医生转诊到上级精神卫生机构。

六、线上复诊的边界

【临床共识】互联网医院适合**已经确诊、病情稳定的老患者**复诊续方；首次诊断、症状波动大、有自伤风险时，必须线下面诊。线上不能做体格检查、抽血、风险评估，别图省事。

七、隐私与病历，你需要知道的

- 精神科病历属于敏感个人信息，受法律保护；
- 一般情况下，医生不会主动把病情告诉你单位、学校、家属；
- 例外：当你有明确自伤/伤人风险、或涉及未成年人保护等法定情形时，医生有义务采取必要措施（通知家属/急救），这是在保护你；
- 入职/入学体检通常不查精神科既往史（特殊岗位另有规定），不必过度担心"被记录在案"。

八、费用大概什么量级

- 普通挂号费十几到几十元，专家号几十到上百元；
- 常用抗抑郁药多数已进医保，月药费几十到一两百元不等（因药而异）；
- 心理治疗多为自费，每次数百元；部分城市已将心理治疗纳入医保；
- 门诊慢特病/门特认定后，报销比例会提高——就诊时主动问收费处。

参考来源

- WHO：Depression fact sheet
- WHO mhGAP：Guide
- NICE：Depression in adults: treatment and management, NG222
- 中华医学会精神医学分会.《中国抑郁障碍防治指南》（第二版）.
- NIMH：Seeking Help for Mental Health Problems

2. 就诊准备

> 第一次进诊室，脑子往往一片空白。提前把要说的话写下来，不是为了显得专业，而是帮你在紧张时不漏掉关键信息。**你不需要写得像病历，写大白话、举具体例子就够了。**

一、就诊前信息整理模板（可直接抄写）

1）现在的状态

- 最主要的不舒服是什么：＿＿＿＿＿＿＿
- 从什么时候开始的（大概日期/几周前）：＿＿＿＿
- 一天里什么时候最重 / 最轻：＿＿＿＿＿＿＿

2）睡眠、饮食、体重

- 最近一周大概几点睡、几点醒、能睡几小时：＿＿＿＿
- 早醒吗（比平时早醒 1～2 小时且睡不着）：是 / 否
- 食欲变化：明显变好 / 变差 / 差不多
- 最近一个月体重变化：约＿＿斤

3）情绪、兴趣、精力

- 还能不能做以前喜欢的事：＿＿＿＿
- 最近有没有觉得"活着没意思"或伤害自己的念头：＿＿＿＿
- 工作/学习/家务受影响程度（0–10）：＿＿

4）病史与家族史

- 以前住过院/看过精神心理科吗：＿＿＿＿
- 家里父母、兄弟姐妹有没有类似情况：＿＿＿＿
- 有没有甲状腺、贫血、慢性病：＿＿＿＿

5）用药与物质（带药盒或拍照）

- 现在在吃的药（处方药/保健品/中药）：＿＿＿＿
- 以前吃过抗抑郁药吗？反应如何：＿＿＿＿
- 喝酒/吸烟/其他物质情况：＿＿＿＿

6）女性补充（如适用）

- 月经周期、是否产后、是否在围绝经期：＿＿＿＿

7）我最想问医生的问题（写 2–3 个）

- ＿＿＿＿＿＿＿
- ＿＿＿＿＿＿＿

二、一周睡眠/情绪简表（就诊前 7 天可粗略记）

日期	入睡时间	醒来时间	睡眠质量(0–3)	情绪(0–3)	备注
周一					
周二					
周三					
周四					
周五					
周六					
周日					

三、怎么说医生最容易懂

不用讲得专业，举具体例子：

- ✗ "我最近状态不好。"
- ✓ "过去三周大多数早晨起不来床，已经请假两次，周末整天躺着，以前喜欢的球赛也不想看了。"

医生最需要的是：**起病时间 + 持续多久 + 对生活的影响 + 有没有自杀念头。**

四、陪同与单独谈话

- 你有权选择是否让家属陪同；也有权在谈话中要求"想单独和医生说几句"。
- 有些话当着家人不好开口（比如自杀念头、酗酒），单独说反而能让医生更准确判断。
- 家属可以在外面等，或在医生同意时一起了解后续安排。

五、就诊时可以主动问的问题

1. 我这个情况大概属于什么？需要做哪些检查？
2. 如果需要吃药，常见副作用有哪些？多久起效？
3. 一般要吃多久？能不能自己停？
4. 需不需要配合心理咨询？

5. 下次什么时候复诊？出现什么情况要立刻来？
6. 生活上（睡眠、运动、饮酒）我该注意什么？

六、时间预期

第一次就诊通常 15～30 分钟（普通门诊），专家号可能更短但问诊更深。带好证件、医保卡、既往病历和药盒。初诊往往要抽血、约检查，不是一次就能全部定下来。

七、就诊当天要带的东西（清单）

- 身份证、医保卡；
- 既往病历本、出院小结（如有）；
- 现在在吃的所有药的药盒，或手机拍照（包括中药、保健品、止痛药）；
- 上面那份"就诊前信息整理模板"；
- 一支笔和一张纸，方便记医生说的要点；
- 如果有自杀念头，最好有人陪同前往。

八、一段示范对话，帮你不紧张

> **医生**：你今天来主要想解决什么问题？
> **你**：我最近一个多月情绪很低，早上起不来，已经请假两次。以前喜欢打球，现在完全不想动。大概三周前开始觉得活着没意思，但还没有具体计划。
> **医生**：睡眠怎么样？
> **你**：晚上两三点才能睡着，早上七点醒了就再也睡不着。胃口差了，一个月瘦了五六斤。
> **医生**：以前有没有过特别兴奋、几天几夜不睡也不累的时候？
> **你**：……好像大学毕业那阵有过一阵子，连续一周特别能聊、花钱也大手大脚，后来自己好了。

看，就是这样——**照实说、举例子、不评价自己**。医生问什么答什么，不需要你"表现得正常"。

九、如果紧张得说不出话

可以直接把写好的那张纸递给医生，说："我有点紧张，先按这个说。"医生见得多了，完全理解。也可以请陪同的人在必要时补充，但涉及内心感受（尤其自杀念头），建议自己说。

十、第一次就诊后，你应该带走的信息

- 医生的初步判断（是不是抑郁、大概多重）；
- 开了什么药、怎么吃、常见副作用、多久起效；
- 需不需要做检查、什么时候拿结果；
- 下次复诊时间；

- 什么情况要立刻回来（出现自伤念头、药物严重不适）。

没听清楚就大胆问："您再说一遍这个药怎么吃？"——这是你的权利。

十一、如果一次没说清楚，怎么办

没关系。医生看病不是一锤定音。你可以：

- 复诊时把这次漏掉的话补在纸条上；
- 用手机备忘录记下次想补充的内容；
- 如果有自杀念头或严重不适，不要等复诊周期，提前联系医生或急诊。

【个人体验】很多康复者都说：第一次就诊离开诊室时，反而觉得松了一口气——因为终于把这件事说给了一个听得懂、不会评判你的人。

参考来源

- NICE：Depression in adults: treatment and management, NG222（评估与病史采集建议）
- WHO mhGAP：Guide
- 中华医学会精神医学分会. 《中国抑郁障碍防治指南》（第二版）.
- NIMH：Depression: What you need to know
- APA：DSM-5 抑郁障碍诊断标准

3. 医生诊断流程

> 你可能会奇怪：医生为什么问这么多、还要我抽血？这一篇把诊室里会发生的事提前告诉你——**诊断不是做一道题，而是把"症状、病程、功能损害、躯体排查"拼在一起判断。**

一、诊断是怎么建立的

1）病史采集与精神检查

医生会像"望闻问切"一样观察和提问：外表与衣着、言语快慢与多少、情绪是低落还是易怒、思维内容有没有消极念头、注意力和记忆力如何、你对自己病情有没有认识（自知力）。这些都是诊断信息，不是闲聊。

2）病程标准

【临床共识】按 ICD-11 / DSM-5，抑郁发作通常要求核心症状持续**至少两周**，且造成明显功能损害。医生反复问"多久了"，是在卡这条时间线。

3）严重程度与功能损害

症状多不多、轻还是重，更重要的是：还能不能上班、上学、照顾自己、维持人际关系。功能受损越明显，治疗越积极。

二、为什么要做一堆检查

常见检查	排查什么
血常规	贫血等血液问题可表现为乏力情绪低
生化（肝肾功、血糖血脂）	躯体疾病、用药前基线
甲状腺功能	甲减/甲亢酷似抑郁/焦虑
维生素 B12、叶酸、维生素 D	缺乏与情绪障碍相关
必要时头颅影像/脑电图	排除脑器质病变（老年、起病突然、有神经症状时）

【临床共识】这些检查不是过度医疗，而是因为**有些躯体疾病和药物会伪装成抑郁**，漏掉了会耽误真正的病。

三、为什么医生要追问"你以前有没有特别嗨的时候"

这是在排查**双相情感障碍**（见"鉴别诊断"篇）。如果既往有过持续几天异常兴奋、话多、挥霍、睡眠需要减少、冲动的时期，诊断和用药策略会完全不同——单用抗抑郁药可能诱发转躁。

四、关于"一次就能确诊吗"

不能。【临床共识】抑郁的诊断主要靠临床访谈，量表只是辅助。首次就诊信息不全、症状可能变化，医生有时会说"先观察、用药后复诊再看"，这不是敷衍，是负责任。

五、就诊流程速查表

环节	会发生什么	我需要准备什么	大概多久
挂号	选科室、挂号	证件、医保卡	线上几分钟/现场排队
初诊访谈	问症状、病史、观察	带"就诊前信息整理"	15–30 分钟
开检查	抽血、约化验	空腹要求（如需）	半小时内
复诊	看结果、调药	记录用药反应	10–20 分钟
确诊与方案	解释诊断、开药/心理治疗建议	提前写好问题清单	视情况

六、精神检查到底在查什么

观察维度	医生在看什么	你不用紧张，自然表现就好
外表与行为	衣着整洁度、动作快慢、是否退缩	平时怎样就怎样
言语	语速、音量、话多还是话少	慢慢说没关系
情绪	是低落、焦虑、易怒还是平淡	真实感受可以直接说
思维内容	有没有消极念头、自罪、疑病	这是诊断关键，别隐瞒
认知功能	注意力、记忆力、定向	不是考试，不会就说不会
自知力	你是否认为自己需要治疗	说"我也不知道算不算病"很正常

七、为什么第一次不给"最终答案"

【临床共识】抑郁是临床诊断，没有验血指标。第一次门诊信息有限，医生要排除躯体病、看药物反应、观察症状变化，有时需要 1～3 次复诊才能稳定诊断。这期间你觉得"医生是不是没把握"——不是，是负责任。

八、你在诊断过程中的权利

- 有权问"我这个诊断依据是什么"；
- 有权问"为什么要做这项检查"；
- 有权对治疗方案提出疑问（副作用、疗程、替代方案）；
- 如果对第一位医生判断有疑虑，可以换一位复诊，这不叫"不配合"。

参考来源

- WHO：ICD-11 精神、行为或神经发育障碍

- APA：DSM-5 抑郁障碍诊断标准
- NICE：Depression in adults: NG222
- WHO mhGAP：Guide
- 中华医学会精神医学分会. 《中国抑郁障碍防治指南》（第二版）.

4. 常用自评量表说明

> **【临床共识】自评量表只用于筛查和症状监测，不能作为确诊依据。** 无论网上自测分数多高，诊断都必须由精神科医生面诊。量表分数是"温度计"，不是"判决书"。

一、PHQ-9（患者健康问卷-9）

PHQ-9 是目前使用最广的抑郁筛查工具，共 9 个条目，回顾**过去两周**内下列情况出现的频率。

评分方式：每条 0–3 分

- 0 = 完全没有
- 1 = 有几天
- 2 = 一半以上时间
- 3 = 几乎每天

序号	条目（过去两周）	0	1	2	3
1	做事时提不起劲或没有兴趣				
2	感到心情低落、沮丧或绝望				
3	入睡困难、睡不安稳或睡眠过多				
4	感觉疲倦或没有活力				
5	食欲不振或吃太多				
6	觉得自己很糟，或觉得自己很失败，或让自己/家人失望				
7	对事物专注有困难（如看报、看电视）				
8	动作或说话缓慢到别人可察觉？或相反——烦躁坐立不安				
9	有不如死掉或用某种方式伤害自己的念头				

总分范围 0–27 分，分段解释：

总分	含义	建议行动
0–4	无 / 极轻微	日常自我照顾即可
5–9	轻度	关注情绪变化、规律作息；持续不适可咨询
10–14	中度	建议就诊评估，可结合心理治疗
15–19	中重度	建议尽快就医，通常需要药物/心理联合
20–27	重度	尽快精神科就诊，评估安全性

【特别注意·第 9 条】只要第 9 条得分 ≥1（出现自伤/自杀念头），无论总分多少，都应**立即**与专业人员或可信任的人联系，不要等复诊、不要反复自测。≥10 分是常用的筛查阳性界值（Kroenke 等 2001，敏感度/特异度约 88%）。

二、SDS（抑郁自评量表）

Zung 编制，共 20 个陈述句，按最近一周感受 4 级评分，换算为标准分。常作初步筛查参考；不同版本分界值略有差异，**网络上的"自动出结果"不一定准确**，分数仅作参考。

三、HAMD / HDRS（汉密尔顿抑郁量表）

【重要】这是**他评量表**，由经过培训的医生/评估者通过访谈观察打分，用于评估严重程度和疗效。**你不需要自己填，也不要在网上找"汉密尔顿自评版"。**

四、常一起用的两个

- **GAD-7（广泛性焦虑量表）**：7 个条目，查焦虑；焦虑和抑郁常常一起出现。
- **PHQ-2**：前两个条目做快速初筛，阳性再做完整版 PHQ-9。

五、量表使用的注意事项

1. 按真实感受作答，不要为了"好看"或"确诊"改答案。
2. **不要反复自测制造焦虑**——一周最多一次，把分数写下来给医生看即可。
3. 分数变化可以反映治疗效果，但生活功能（能不能上班、见人）比分数更重要。
4. 量表提示自伤念头时，按第 9 条原则处理，别拖。

六、GAD-7（焦虑筛查，常与 PHQ-9 一起用）

焦虑和抑郁常常手拉手出现，医生常让你一起填 GAD-7。同样回顾**过去两周**，0–3 分四级：

条目	0	1	2	3
1. 感觉紧张、焦虑或急切				
2. 不能停止或控制担忧				
3. 对各种各样的事情担忧过多				
4. 很难放松下来				
5. 由于不安而无法静坐				
6. 变得容易烦恼或急躁				
7. 感到似乎将有可怕的事情发生而害怕				

总分 0–21：0–4 无明显焦虑，5–9 轻度，10–14 中度，15–21 重度。和 PHQ-9 一样，它只是筛查。

七、其他常见量表（了解即可）

- **PHQ-2**：只取 PHQ-9 前两条，用于人群快速初筛；阳性再做完整 PHQ-9。
- **SDS（Zung）**：20 题，正向反向计分各半，标准分 50 以上提示抑郁可能。
- **BDI（贝克抑郁问卷）**：21 题，临床研究和心理评估常用，国内也有使用。
- **HAM-D / HDRS**：他评，医生用（前面讲过）。
- **HAM-A（汉密尔顿焦虑量表）**：他评，医生评估焦虑严重度。

八、自测的正确姿势（重要）

1. **一周最多测一次。**天天测、每次看分数涨跌，反而会制造新的焦虑——分数本来就有波动。
2. 用**同一份量表**在**相同回顾周期**下比较，不要今天 PHQ-9、明天换个网上的"抑郁测试"。
3. 把分数和日期记在本子上，复诊时带给医生看，比你口头说"好像好一点"有用。
4. 分数下降 ≠ 可以停药；分数升高也不必恐慌，结合你的实际生活状态一起判断。
5. 网络上各种"三分钟测抑郁"小程序鱼龙混杂，**以医生用的标准化量表（PHQ-9、GAD-7 等）为准。**

【再强调一次】无论分数多少，量表都不能确诊。它是手电筒，不是诊断书。

九、一句话记住

量表是"体温枪"——它告诉你有没有发热、烧到多少度，但不会告诉你是感冒、肺炎还是新冠。**拿分数去找医生，让医生做诊断和处方，这才是量表的正确用法。**

【临床共识】任何时候，只要你觉得不安全、有伤害自己的念头，不必先做量表、不必等分数，直接求助（热线/急诊/信任的人）。

参考来源

- Kroenke K, Spitzer RL, Williams JBW. **The PHQ-9: Validity of a brief depression severity measure.** *J Gen Intern Med*. 2001;16(9):606-613. doi:10.1023/A:1009083624315
- Hamilton M. **A rating scale for depression.** *J Neurol Neurosurg Psychiatry*. 1960;23:56-62.
- NICE：Depression in adults: NG222
- WHO mhGAP：Guide
- APA：DSM-5 抑郁障碍诊断标准

5. 鉴别诊断

> "心情不好、没力气、睡不着"——这些表现可能是抑郁，也可能是别的病。医生之所以排查一堆，是因为**有些病长得像抑郁，治法完全不同。**这一篇告诉你要留意哪些线索，就诊时主动告诉医生。

一、为什么"像抑郁"不等于"是抑郁"

【临床共识】抑郁的诊断是"排除性"的之一：先排除躯体疾病、物质、其他精神障碍，再下诊断。漏诊双相、甲减，都可能让治疗走弯路。

二、重点：双相情感障碍的抑郁发作

【重点·极易误诊】双相情感障碍患者在"抑郁相"时，表现和单相抑郁几乎一样，容易被当成普通抑郁。**单用抗抑郁药而不处理双相特质，可能诱发躁狂/轻躁狂、甚至快速循环。**

就诊时请主动告诉医生：**你有没有过这样的时期——**

- 连续几天异常兴奋、话多、脑子转得特别快；
- 睡眠需要明显减少（只睡 2–3 小时就精力充沛）；
- 疯狂购物、轻率投资、冲动性行为；
- 自我评价膨胀、觉得自己无所不能；
- 那段时间别人提醒你"你最近不太对劲"。

哪怕只是几天、事后觉得"那时候状态特别好"，也一定要说。【研究结论】很多双相患者在明确诊断前曾多年被当作单相抑郁治疗。

三、需要鉴别的情况对照表

需要鉴别的情况	相似表现	关键区别线索	要做的检查 / 要告诉医生的话
甲状腺功能减退	乏力、嗜睡、情绪低、体重增	怕冷、便秘、皮肤干、月经紊乱	查甲状腺功能；告知体重与怕冷变化
贫血	乏力、没精神	面色苍白、头晕、月经量多	血常规
维生素 B12/叶酸/维生素 D 缺乏	情绪低、疲劳	饮食单一、胃肠吸收问题	抽血查维生素水平
脑器质病变（卒中、肿瘤、帕金森、痴呆）	情绪低、兴趣下降	起病突然、伴头痛/记忆下降/肢体症状	头颅影像、神经科会诊
慢性感染/肿瘤等躯体病	持续低落、乏力	体重下降、长期低烧、疼痛	常规筛查、告知病程特点
药物/物质所致	情绪低、失眠	近期新用激素、降压药、干扰素、大量饮酒	带上全部用药清单，如实说饮酒量

需要鉴别的情况	相似表现	关键区别线索	要做的检查 / 要告诉医生的话
正常丧亲（哀伤）	失去亲人后低落	哀伤是波浪式、自尊保留、有怀念而非全盘无价值感	医生会区分"哀伤"与"抑郁障碍"
双相抑郁发作	与单相抑郁几乎相同	**既往躁狂/轻躁狂史**（见上）	主动回忆并告知"特别嗨"的时期
焦虑障碍 / 创伤后应激障碍	担心、紧张、失眠	以过度担忧、惊恐、闪回为主	告知有没有特定恐惧事件
老年期"抑郁性假性痴呆"	记忆力下降、反应慢	抗抑郁治疗后认知可改善；与真性痴呆相鉴别	老年起病、伴情绪问题时告知医生

四、关于"哀伤"与抑郁的区别

失去亲人后悲伤、哭泣、想念，是正常反应。【临床共识】如果低落持续超过两周、几乎全天如此、伴随强烈无价值感/自杀念头/功能严重受损，才更像叠加了抑郁障碍——**哀伤不需要"振作"，但叠加的抑郁需要治疗**，两者不互斥。

五、给患者的行动清单

1. 就诊时把"既往有没有异常兴奋期"这件事专门提一句。
2. 带上所有用药（包括保健品、中药）。
3. 如实说饮酒量——这不丢人，是诊断依据。
4. 如果医生查出来是甲减/贫血等，先治原发病，情绪往往跟着好转。

六、双相为什么是"重中之重"

【临床共识】双相情感障碍（既往叫躁郁症）分 I 型（有过明确躁狂发作）和 II 型（轻躁狂 + 重性抑郁）。患者大多时间处在抑郁相，就诊时主诉全是抑郁，**平均要隔很多年才被正确诊断。**

为什么必须分清楚：

- 单相抑郁：抗抑郁药通常是一线选择；
- 双相抑郁：单用抗抑郁药可能诱发躁狂、轻躁狂，或让情绪"摆荡"得更快（快速循环）；治疗以心境稳定剂为主。

所以医生反复追问"你有没有过嗨过头的时候"，不是闲聊天，是在避免给你开错药。

轻躁狂和"心情好、效率高"怎么区分？

- 正常的开心：不会让别人觉得"你最近不对劲"；不需要更少睡眠；不会事后追悔（乱花钱、冲动消费、失态）。
- 轻躁狂：持续至少连续几天，自我感觉极好、睡眠需要骤减、话多、主意变得快、冲动行为，事后自己也可能意识到"那段时间我有点飘"。

哪怕你现在觉得那是"我人生状态最好的一段"，也要告诉医生。

七、哀伤（丧亲反应）与抑郁的更细区别

维度	正常哀伤	抑郁障碍
情绪节奏	波浪式，时好时坏	几乎全天持续低落
自我价值	多能保留，会怀念逝者	强烈无价值感、自罪
自杀念头	多是"想跟着走"而非"我活不下去"	反复出现、有计划
功能	可随时间慢慢恢复	持续受损、越来越重

两者可以叠加：失去亲人后既哀伤又抑郁，**该治还是要治**，不会因为"你在服丧"就硬扛。

八、药物/物质诱发的情绪低落（要主动汇报）

以下情况就诊时务必告诉医生：近期新用或调整过——

- 糖皮质激素（泼尼松等）；
- 部分降压药（如利血平、β受体阻滞剂个例）；
- 干扰素、部分抗肿瘤药；
- 避孕药、产后激素剧变；
- 酒精、镇静催眠药、大麻等物质的使用或戒断。

由这些引起的情绪问题，**处理原用药/物质**往往比抗抑郁药更关键。

九、老年期要特别当心

老年人情绪低、记性差、动作慢，既可能是抑郁，也可能是痴呆。【临床共识】"抑郁性假性痴呆"在抗抑郁治疗后认知常可改善；反之，真性痴呆早期也伴情绪问题。两者鉴别需要神经心理测评和影像，家属要做的是：**如实告诉医生"是先情绪差还是先忘事"**，这个先后顺序非常关键。

参考来源

- APA：DSM-5 抑郁障碍与双相障碍诊断标准
- WHO：ICD-11
- NICE：Depression in adults: NG222
- 中华医学会精神医学分会.《中国抑郁障碍防治指南》（第二版）.
- 黄悦勤等. 中国精神卫生调查（抑郁与双相共病/流行病学）. *Lancet Psychiatry*. 2019. doi:10.1016/S2215-0366(18)30511-X30511-X)
- WHO mhGAP：Guide

5.1 药物治疗

> 抗抑郁药是治疗中度至重度抑郁障碍的重要手段之一，但它不是"快乐药"，也不是一次性根治的钥匙。它的作用是逐步把大脑调节情绪的能力拉回正轨，给心理康复和生活重建腾出空间。本页只介绍类别、起效规律、常见反应与用药原则，**不涉及具体剂量与个体化方案**——你吃哪种、吃多少、怎么停，必须由精神科医生根据你的情况决定。

一、先建立几个正确预期

【临床共识】抑郁障碍是一种有生物学基础的疾病，不是"想不开""意志力差"。就像高血压需要药物把血压稳住，抑郁也常需要药物帮助神经递质系统（尤其是 5-羟色胺、去甲肾上腺素等）恢复平衡。

- 药物针对的是**疾病本身**，而不是你这个人的性格。
- 多数人需要的是"药物 + 心理治疗 + 生活调整"的组合，单用或联合由医生评估。
- 【研究结论】约三分之二的患者在规范治疗后症状会明显改善；即使第一种药效果不理想，也有换用、联合、增效等多条路可走，不要因为一次效果不好就认定"药对我没用"。

二、常见抗抑郁药类别与代表药（通用名）

下面只列**类别和通用名**，帮助你看懂医生处方和药品说明书，不代表你应该自行选用。

类别	代表通用名	大致特点与提示
SSRI（选择性5-羟色胺再摄取抑制剂）	氟西汀、舍曲林、帕罗西汀、氟伏沙明、西酞普兰、艾司西酞普兰	目前最常用的一线选择，耐受性较好；不同人对其中某一种反应差异较大，常需试选
SNRI（5-羟色胺与去甲肾上腺素再摄取抑制剂）	文拉法辛、度洛西汀	作用更广，对伴疼痛、乏力的抑郁有时更合适；文拉法辛部分人血压会轻度升高
NaSSA（去甲肾上腺素能与特异性5-羟色胺能抗抑郁药）	米氮平	镇静、食欲增加作用较明显，适合伴失眠、消瘦者；有人会体重增加、白天嗜睡
三环类/四环类（老一代）	阿米替林、马普替林、氯米帕明等	疗效确切但副作用（口干、便秘、心慌、体位性头晕）较多，过量危险，现多作为二线或特定情况使用
MAOI（单胺氧化酶抑制剂）	吗氯贝胺等	因与食物和药物相互作用多，现已很少常规使用
新型多靶点药	伏硫西汀、维拉佐酮	对认知症状、情绪有不同作用谱，性功能影响相对小，价格通常较高
褪黑素能受体激动剂	阿戈美拉汀	对睡眠节律紊乱者较友好，需定期监测肝功能
其他	曲唑酮	常利用其镇静作用改善睡眠，低剂量时多用于助眠

类别	代表通用名	大致特点与提示
植物药	圣约翰草提取物（贯叶连翘）	**不是"天然就安全"**：与很多药物（抗抑郁药、避孕药、抗凝药等）相互作用强，可能影响肝脏代谢；若正在服用或打算服用，必须告知医生，切勿与处方抗抑郁药自行叠加

【个人体验】很多人第一次拿到药盒时会紧张，担心"一旦开始吃就停不下来"。后面"用药常见顾虑"会专门解释。

三、起效规律：最容易让人半途而废的一关

这是本页最重要的一节，请耐心读完。

时间窗	通常发生的变化	你的正确做法
服药最初几天～1周	几乎感觉不到情绪变好；反而可能出现恶心、头晕、犯困或焦虑加重	**不要急着停药。**这是身体在适应
约2–4周	睡眠、食欲、紧张感可能先开始松动；情绪的改善往往滞后	坚持按医嘱服药，记录身体反应
约6–8周	多数人在此阶段才能较充分地评估这一种药是否对症	复诊，由医生判断疗效与是否需要调整

【临床共识】抗抑郁药**不是吃了立刻开心的药。**它通常在数周内逐步起效，而且常常先改善睡眠和焦虑，再改善情绪。"吃了一两周没感觉就停"是最常见、也最可惜的做法——往往在药快要起效时被停掉。

治疗初期的自杀风险监测（尤其要重视）

【临床共识】在用药最初的1–2周（以及加量阶段），部分患者——尤其是25岁以下青少年和年轻成人——可能出现一过性的焦虑、激越或自杀念头增多。这不是"药让你更糟"，而是需要被严密观察的窗口期。

- 如果服药后出现"以前没有过的、强烈的想结束自己的念头"，**立即联系医生或复诊**，不要等下次预约。
- 家属在此期间应多留意情绪和行为变化。
- 医生会权衡利弊后决定继续观察、调整剂量或换药。

四、副作用：短期不适 vs 必须尽快告诉医生

副作用个体差异很大，**多数早期不适会在1–2周内自行减轻**，不要因轻微反应就自行停药。但你要能分清"忍一忍会过去"和"必须马上说"。

A. 短期常见不适（多在1–2周内逐渐减轻）

- 轻度恶心（通常随餐或饭后服用可缓解）
- 头痛、轻微头晕
- 口干、轻度腹泻或便秘
- 嗜睡，或相反的轻度失眠
- 服药初期短暂的焦虑、坐立不安感

B. 需要在复诊时主动告诉医生（不一定停药，但要被记录和处理）

反应	说明
性功能方面的变化（性欲、高潮困难等）	较常见，尤其 SSRI；很多人不好意思说，但**这是可以和医生讨论、调整的**，不必默默忍受
体重或食欲明显变化	米氮平等较明显；可结合饮食运动一起管理
异常多汗	部分人会出现
持续便秘、排尿不畅	需医生评估
血压变化（尤其用文拉法辛者）	可自我监测，复诊告知

C. 危险信号：出现以下任何一条，尽快联系医生或急诊

危险反应	典型表现	行动
5-羟色胺综合征	高热、意识混乱、明显激越、肌肉僵硬或不自主抽动、大汗淋漓、心跳很快	**立即急诊**，这是急症
诱发躁狂/轻躁狂	突然异常兴奋、话多、睡眠需要明显减少、冲动消费、觉得自己特别厉害	**立即复诊**——这提示可能是双相情感障碍，治疗方向会改变
异常出血/瘀斑	无故牙龈出血、黑便、皮肤大片瘀斑	尽快就医
低钠血症	老年人体位性头晕、乏力、意识模糊、抽筋	尽快就医
皮疹、过敏	服药后新发皮疹，尤其伴发热	停药并就医
QT间期延长相关	心悸、晕厥感	告知医生，必要时查心电图

【争议观点】网上常有人把抗抑郁药描述得非常可怕，也有人把它说得毫无副作用。两种极端都不真实：它确实有副作用和需要监测的风险，但在医生指导下规范使用是安全、成熟的治疗手段。

五、用药总原则：足量、足疗程、不擅自停

1. 为什么要"足疗程"

抑郁治疗通常分三个阶段，时间概念如下（具体时长由医生根据你的发作次数和严重程度决定）：

阶段	大致目标	你需要知道的
急性期	控制症状，达到临床缓解	通常需要数周～数月，药要吃够、吃对
巩固期	防止症状刚好转就反弹	症状消失后**仍需继续服药一段时间**，因为"感觉好了"不等于"病好了"
维持期	降低复发风险	反复发作、有家族史者，维持治疗更重要

【临床共识】很多人"一感觉好转就自己停药"，结果在数月内复发，而每复发一次，未来复发的风险就升高一截。**过早自行停药是复发最常见的人为原因之一。**

2. 为什么不能突然停药

抗抑郁药（尤其 SSRI/SNRI）突然停掉，可能出现"撤药反应"：

- 头晕、像被电击一下的感觉
- 恶心、类似感冒的不适
- 烦躁、失眠、情绪波动、易激惹

撤药反应本身通常会逐渐过去，但它容易被误读为"我又抑郁了"而慌乱；更重要的是，**突然停药会显著升高复发风险。**

【临床共识】停药必须在医生指导下**缓慢、逐步减量**，给身体适应的时间。哪怕你已经决定要停，也要先和医生约好节奏。

3. 漏服了怎么办

- **不要下次自己加倍补吃**，那会增加副作用风险。
- 想起来时若离下次服药还久，按医嘱补服一次即可；若已接近下次服药时间，跳过这次、按原计划继续。
- 记不清、拿不准时，问开药医生或药师，而不是凭感觉加倍。

六、换药、联合用药与增效治疗

如果第一种药效果不好，并不意味着"没救了"。医生可能会考虑：

- **换用另一种不同类别的抗抑郁药**；
- **联合用药**：两种作用机制互补的药搭配；
- **增效治疗**：在抗抑郁药基础上加用小剂量非典型抗精神病药、锂盐等，用于难治性抑郁。

这些决策都涉及相互作用和安全性，**必须由医生评估和实施**，切勿自行叠加网上看到的"组合"。

七、相互作用与特殊情况

- **MAOI 与其他抗抑郁药之间换药**，需要一段"清洗期"，否则可能引发5-羟色胺综合征——这也是为什么换药一定要听医生的。
- 避免同时使用其他会升高5-羟色胺的药物/物质（部分感冒药、止痛药、圣约翰草等），用药前先问医生或药师。
- **酒精、违禁物质**会加重抑郁、干扰药效、增加镇静风险，应尽量避免。
- 正在服用、打算开始服用任何其他药物、保健品、中成药，都要告诉医生。

妊娠、备孕、哺乳

这是一个需要**医生与孕妇共同权衡**的决策，不能简单说"一定不能吃"或"随便吃"：

- 不治疗的中重度抑郁本身，对母亲和胎儿也有风险（孕期情绪、产后照护能力等）。
- 某些药物在孕期相对更常用，但具体选择必须由精神科 + 产科医生共同评估。
- **如果你在备孕或已怀孕，不要自行停药**，尽快告知医生，一起制定方案。

老年、肝肾功能疾病

老年人更易出现低钠、体位性低血压，起始剂量常更小；肝肾功能不全者药物代谢不同。这些都需要医生个体化调整。

八、用药常见顾虑答疑

你的担心	客观说明
"会不会上瘾、一辈子戒不掉？"	抗抑郁药**不属于成瘾性物质**，不会像安眠药/酒精那样越吃越想要、不吃就 craving。"需要长期吃"是因为疾病本身容易复发，就像降压药需要长期吃一样，不是成瘾。
"吃了会不会变傻、反应变慢？"	少数人初期会有犯困、思维略钝，多在适应后缓解；抑郁本身才是让人注意力、记忆力下降的原因。规范治疗后，很多人反而觉得脑子更清楚。
"会不会发胖？"	不同药差异大（米氮平等较易增重）。体重可通过饮食、运动管理，且这一顾虑可以在选药时就和医生沟通。
"好了不就可以停了吗？"	恰恰相反——"感觉好转"是治疗起效的信号，但巩固和维持期是用来**防止反弹**的。自行过早停药，是复发最常见的原因。
"我靠自己扛行不行？"	轻度可尝试心理治疗和生活调整；但中重度抑郁时，"硬扛"常常错过最佳干预期，药物能帮你恢复到有能力做心理治疗和自我调节的状态。

九、一张表看懂用药全过程

阶段	时间感	重点任务	复诊节奏
启动期	第1–2周	适应副作用、监测初期情绪变化、不漏服	按医嘱，有危险信号随时就医
起效期	第2–6周	观察睡眠/焦虑/情绪变化，记录反应	复诊评估
充分评估期	第6–8周	判断疗效，决定是否继续/换药	复诊
巩固期	症状消失后数月	不擅自减停，配合心理治疗与生活重建	规律复诊
维持期	反复发作人群	长期管理，与医生商定维持时长	定期复诊

十、你可以现在就做的三件事

1. 把正在吃/准备吃的药名（通用名）记在手机里，复诊时主动告诉医生你的身体反应。
2. 告诉一位你信任的家人/朋友你在治疗中，让他在你"想自行停药"时提醒你先问医生。
3. 把开药医生/医院的联系方式存好，尤其是出现危险反应时知道找谁。

> **再次提醒**：本页所有内容用于帮助你理解治疗、更好地和医生沟通。**具体用药、剂量、加减停，必须由精神科面诊医生决定。** 如果你正处在情绪低谷，请同时阅读本资料库《模块6》的自我照顾与危机干预内容。

参考来源

- NICE（英国国家卫生与临床优化研究所）：*Depression in adults: treatment and management (NG222)*. https://www.nice.org.uk/guidance/ng222
- 世界卫生组织（WHO）：*Depression fact sheet*. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/depression
- 美国国家精神卫生研究院（NIMH）：*Depression*. https://www.nimh.nih.gov/health/topics/depression
- 《中国抑郁障碍防治指南》（第二版），中华医学会精神医学分会。
- 加拿大情绪和焦虑治疗网络（CANMAT）成人抑郁障碍管理指南。
- 美国精神医学学会（APA）：*Practice Guideline for the Treatment of Patients with Major Depressive Disorder*.

5.2 心理治疗

> 心理治疗不是"找人聊聊天想开点"，而是一套有理论、有结构、有证据的专业干预。它和药物治疗不是二选一：轻度抑郁可优先单用心理治疗，中重度通常建议药物与心理联合。找对治疗师、建立安全的治疗关系，本身就是疗效的重要部分。

一、常见心理治疗方法一览

疗法	核心理念	适合情况	大致形式
CBT 认知行为疗法	情绪受"我们如何解释事情"影响；通过行为激活和认知重构，打破抑郁的恶性循环	各型抑郁的一线选择，证据最强	结构化，通常8–16次，每次约45–60分钟，有议程、有家庭作业
MBCT 正念认知疗法	把正念练习与认知疗法结合，学会觉察"我有一个想法"而不被它卷走	**预防复发**，尤其反复发作的抑郁	团体8周课程，每天家庭正念练习
IPT 人际关系治疗	抑郁常与人际困难相关：哀伤、角色冲突、角色转变、人际缺陷	人际困扰明显、丧亲、身份转变期	短程，约12–16次
BA 行为激活	抑郁让人退缩、退缩又加重抑郁；从一点点恢复有意义的活动入手	动力低、生活停滞，也可作为CBT的基础部分	结构化，记录活动与情绪
支持性心理治疗	在安全关系中倾听、鼓励、稳定情绪	症状较重、或作为其他治疗的辅助	较灵活，以支持陪伴为主
心理动力学治疗	探索早期关系与潜意识模式如何影响当下情绪	希望深入了解自己、问题较慢性	长程，频率较高
夫妻/家庭治疗	情绪问题常与家庭互动模式互为因果	关系冲突明显、家人卷入度高	伴侣或家庭共同参与

【临床共识】在这些方法中，**CBT 和 MBCT 对抑郁的证据最充分**：CBT 对发作期治疗有效，MBCT 对"减少反复发作"证据尤其强。

二、不同强度抑郁的治疗组合

【临床共识】综合各国指南：

- **轻度抑郁**：可先单用心理治疗（如 CBT/BA）、加强运动、社会支持，定期观察。
- **中度至重度抑郁**：通常建议**药物治疗 + 心理治疗联合**，效果往往优于单用其一。
- **出现以下情况，不能只做心理治疗**：严重迟滞（连起床、进食都困难）、明显自杀风险、伴有幻觉妄想等精神病性症状——这些需要先由精神科处理。

三、谁是"精神科医生"，谁是"心理咨询师"

很多人混淆这两个角色，分工其实很清楚：

	精神科医师	心理治疗师/心理咨询师
能否下诊断	能	不能（可做心理评估与咨询）
能否开药	**能**	**不能**
主要工作	药物治疗、严重病例管理、危机处理、住院	谈话治疗、CBT/IPT等干预、心理支持
常见配合	医生管"药"，治疗师管"聊"，二者协作	

【个人体验】理想状态下，你是一个"团队"：精神科医生把控药物与安全，心理治疗师带你做深入的工作。如果有人只聊几次就急着给你开药，或只做咨询却告诉你"你不用吃药"，都值得多问一句、换一家正规机构核实。

四、第一次心理治疗会发生什么

很多人对"第一次走进咨询室"紧张，下面是大致流程，让你心里有底：

1. **建立关系与知情同意**：治疗师介绍保密原则、设置（时间、频率、费用、如何预约取消）。
2. **了解你的情况**：你会被邀请讲述现在的困扰、什么时候开始、对生活的影响、过去的经历和家庭情况。
3. **初步评估**：可能会填一些量表（如抑郁/焦虑自评），帮助量化问题。
4. **共同定目标**：和你一起商量"这段时间想改善什么"，而不是治疗师单方面规定。
5. **布置小作业（CBT类）**：可能是记情绪日记、安排一个小活动——这不是"考试"，是练习。

你可以在第一次就问：你受训于哪种流派？我们大致怎么进行？我的目标怎么衡量？专业的治疗师会乐意回答。

五、如何判断治疗师是否专业

选择时可以留意：

- **资质与受训**：有正规学历/受训背景，属于可查证的专业体系；
- **督导与伦理**：持续接受督导，遵守伦理边界（不发展双重关系、不与你建立治疗以外的亲密关系、不索取财物以外的好处）；
- **会做评估和转介**：发现需要药物或住院时，会建议你同时看精神科，而不是硬留在咨询里；
- **保密与边界清晰**：会事先说明保密的范围（如自伤伤人风险时需要突破保密、联系紧急联系人）。

六、治疗关系与现实预期

【临床共识】研究反复发现，**治疗关系的质量**（你是否感到被尊重、被听见、安全）对疗效的预测力，不亚于用的是哪种具体技术。这意味着：

- 如果在某段关系里你总觉得被评判、被说教、不被理解，换一个治疗师是合理的，**这不代表"你不适合做心理治疗"**。
- 心理治疗不会一次见效，它更像健身——需要规律、需要练习、会有反复。
- 【个人体验】有的人做完一次咨询反而情绪更低落，因为触及了痛苦的事。这不等于失败，只要整体方向在推进、安全有保障，可以和治疗师讨论这种感受。

什么时候该考虑换治疗师

- 他/她总是迟到、随意取消、不遵守约定；
- 不给你解释、催促你做不想做的事；
- 与你发展出治疗以外的暧昧/金钱/商业关系；
- 你感到长期不被尊重，或几次下来毫无进展且不与你讨论原因。

换治疗师是你的权利，不必有心理负担。

七、咨询的不同形式

形式	特点
门诊面对面	最经典，适合多数人
长程治疗	问题较慢性、想深入探索自己
团体治疗	与有相似困扰的人一起，收获"原来不只我这样"，且费用较低
线上咨询/视频	方便、可及，但危机处理的即时性弱于线下，高风险者仍建议线下

【争议观点】线上心理治疗的可及性很好，但对于有较强自杀风险、或需要严密观察的人，线下精神科随访更稳妥。

> **提醒**：心理治疗有效，但它需要时间和你的参与。如果你目前症状很重、连来做治疗的精力都没有，请先就医（精神科/急诊），把状态稳定一些，再开始心理工作效果更好。

参考来源

- NICE：*Depression in adults: treatment and management (NG222)*. https://www.nice.org.uk/guidance/ng222
- 世界卫生组织（WHO）：*Depression fact sheet*. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/depression
- Kuyken W, et al. *Efficacy of Mindfulness-Based Cognitive Therapy in Prevention of Depressive Relapse: An Individual Patient Data Meta-analysis from Randomized Trials.* JAMA Psychiatry.
- 美国国家精神卫生研究院（NIMH）：*Depression*. https://www.nimh.nih.gov/health/topics/depression
- 《中国抑郁障碍防治指南》（第二版），中华医学会精神医学分会。

5.3 物理治疗

> "物理治疗"这个词容易让人联想到可怕的画面，其实它是一类成熟的、由专业团队操作的医疗手段。它既不是"惩罚"，也不是"一招根治"，而是在药物和心理治疗不够用时的重要补充。是否需要、做哪种，由精神科团队根据你的情况评估决定。

一、无抽搐电休克治疗（MECT）

MECT 是最常被误解、也最"名声吓人"的一种。它的现代版本与老电影里的"电刑"完全不同。

它用于什么情况

【临床共识】以下情况，医生常会考虑 MECT：

- 重度抑郁，伴**强烈、反复的自杀念头或行为**；
- **拒食、拒饮、抑郁性木僵**（一动不动、不进食，身体有衰竭风险）；
- 伴有精神病性症状（幻觉、妄想）的抑郁；
- **难治性抑郁**——多种药物规范治疗后效果仍不理想；
- 患者对药物不能耐受，或身体状况不适合用药；
- 孕期出现严重抑郁，需要快速控制又顾虑用药时，也可能在团队评估后考虑。

大致过程

- 在**全身麻醉 + 肌肉松弛剂**下进行，你全程无意识、无痛苦；
- 通过短暂、可控的大脑刺激诱发一次治疗所需的发作，现代技术下肌肉几乎不动，所以叫"无抽搐"；
- 通常一个疗程由多次治疗组成，之后由团队评估是否需要维持治疗。

常见不良反应

- 治疗后短期内可能有**近事记忆下降**、头痛、恶心；
- 多数记忆问题会随时间逐渐恢复，个体差异存在；
- 麻醉相关的风险由麻醉团队评估把关。

【争议观点】关于 MECT 对记忆的长期影响，研究结果并不完全一致，但它在特定危重情况下的救命价值是被公认的。重要的是**知情同意**：做之前，医生会向你和家属讲清收益、风险和替代方案。

【个人体验】很多人是在"药物已经压不住、人已经很危险"的时候才接受 MECT，事后回忆，它帮自己跨过了最难的那道坎。不必被旧印象吓退，但也不必把它神化为"一次就好"。

二、重复经颅磁刺激（rTMS）

它是什么

一种**无创**的门诊治疗：用磁场刺激大脑特定区域（与情绪调节相关的皮层），你全程清醒、躺着即可，不需要麻醉。

用于什么情况

【临床共识】多用于**成人难治性抑郁**——作为药物效果不佳时的辅助或替代选择。一个疗程通常持续数周（约4–6周，按工作日进行）。

常见不适与禁忌

- 常见不适：治疗部位头皮轻微不适、轻度头痛，多较轻微；
- **禁忌/需评估**：颅内有金属植入物、有癫痫病史、戴心脏起搏器等情况，需要医生提前评估是否适合。

三、其他较少展开的方法

- **tDCS（经颅直流电刺激）**：证据相对弱于 rTMS，仍在研究；
- **光照治疗**：对**季节性抑郁**（秋冬加重）有一定证据；
- **迷走神经刺激、冬眠疗法等**：多用于特定的难治性病例，由专科团队掌握，这里不展开。

四、对照表：物理治疗怎么选

治疗	适用人群	大致过程	常见反应	你可以问医生的问题
MECT	重度伴强烈自杀行为、拒食木僵、精神病性抑郁、难治性、药物不能耐受	全麻下多次治疗，住院/日间	短期记忆下降、头痛恶心，多逐渐恢复	我为什么适合它？疗程几次？记忆影响多久？替代方案是什么？
rTMS	成人难治性抑郁的辅助/替代	门诊、清醒、约4–6周	头皮不适、轻头痛	我需要做多少次？和我的药物怎么配合？
光照治疗	季节性抑郁	每日照特定灯光一段时间	轻微眼疲、失眠（傍晚照可能影响入睡）	什么时间照、照多久？

五、关于物理治疗的几个事实

1. **它不是惩罚。** 它和开药、手术一样，是为了帮你恢复，由你知情同意后进行。
2. **它不是万能。** 多数人仍需要后续的药物维持和心理康复。
3. **决定权在专业团队。** 不要因为"听说谁做过"就主动要求，也不要因为家人建议就拒绝——和医生充分讨论利弊后再决定。
4. **家属的角色**是陪伴、协助签署知情同意、观察治疗后状态，而不是代替你做所有决定。

> **提醒**：本页用于消除误解、帮助你与医生沟通。是否进行物理治疗、采用哪种，必须由精神科团队面诊评估。如果你此刻有强烈的自伤/自杀冲动，请直接参阅《模块6·危机识别与急救》。

参考来源

- NICE：*Depression in adults: treatment and management (NG222)*. https://www.nice.org.uk/guidance/ng222
- 美国国家精神卫生研究院（NIMH）：*Depression*. https://www.nimh.nih.gov/health/topics/depression
- 世界卫生组织（WHO）：*Depression fact sheet*. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/depression
- 《中国抑郁障碍防治指南》（第二版），中华医学会精神医学分会。
- CANMAT 成人抑郁障碍管理指南（关于物理治疗的推荐）。

1. 复发预警信号

> 抑郁像一段会反复的旅程，但复发不是"失败"，而是可以被识别、被提前拦截的过程。研究发现：发作次数越多，未来复发的风险越高；而在复发苗头刚出现时就干预，常常能把一次发作掐短、甚至拦下。学会认出自己的"早期信号"，是康复期最重要的功课之一。

一、为什么康复期还要一直"监测"

【研究结论】抑郁障碍有慢性、反复发作的倾向。每多一次发作，大脑对类似压力的"易感痕迹"就深一层。但好消息是：

- 早期识别 + 早期干预，能明显缩短下一次发作的时间、减轻严重程度；
- 坚持维持期治疗、规律作息，本身就是在给复发"上保险"。

【个人体验】很多康复者说，复发不是"某天突然垮掉"，而是几天到几周里，一些细小的变化一点点累积起来——只是当时自己没意识到。这张表，就是帮你把这些变化"显性化"。

二、常见的复发早期信号

下面这些，不一定每次都全出现，但一旦你发现自己**连续两周左右**出现其中好几条，就要警觉：

睡眠与精力

- **睡眠改变**，尤其是**失眠或早醒**（凌晨醒来就再难入睡）——这是最敏感的信号之一；
- 白天体力持续变差，做一点小事就累；
- 早上尤其难熬（晨重暮轻）。

情绪与想法

- 情绪持续走低，"高兴不起来"的日子变多；
- **消极念头增多**，或冒出"不如死了算了""活着没意义"这类想法；
- 变得容易烦躁、对小事易怒；
- 注意力、专注力明显下降。

行为与社交

- 兴趣下降，以前喜欢的事都不想做了；
- **社交退缩**：不想回消息、推掉约见、一个人闷着；
- 旧有的负性思维模式又回来了（"我就是不行""一切都没希望"）；
- **开始回避吃药、回避复诊**（这本身就是危险信号）。

身体与饮食

- 食欲明显增加或减少，体重变化；
- 不明原因的头痛、身体不舒服。

三、你的"个人化早期信号"

上面是通用信号，但**每个人的复发"开场剧本"不一样。**请回想你过去几次发作前，最先出现的是什么？

【个人体验】有人复发前最先变的是睡眠，有人是开始疯狂刷手机到凌晨，有人是突然谁都不想理。**你最该记住的，是"你自己那次最早不一样的地方"。** 把它写在下面，存到手机里。

四、复发预警自检表

建议每1–2周对照打一次勾，或让信任的家人帮你一起看。

预警信号	我过去发作前出现过吗?	近两周有没有?	如果出现，我的应对是
失眠 / 早醒	□有 □没有	□有 □没有	（例：固定起床时间、减少午睡、联系医生）
兴趣下降、不想做喜欢的事	□有 □没有	□有 □没有	
消极念头 / "不如死了"	□有 □没有	□有 □没有	
体力持续变差、晨起尤甚	□有 □没有	□有 □没有	
情绪持续走低、易激惹	□有 □没有	□有 □没有	
注意力变差、做事难集中	□有 □没有	□有 □没有	
社交退缩、不想见人回消息	□有 □没有	□有 □没有	
旧有负性思维回来了	□有 □没有	□有 □没有	
食欲/体重明显变化	□有 □没有	□有 □没有	
想回避吃药 / 回避复诊	□有 □没有	□有 □没有	

> 当这张表上"近两周"的勾攒到 **3条及以上**，或出现了消极念头，请直接进入下面的"行动阶梯"，不要等。

五、出现信号后的"行动阶梯"

按层级往上走，越早行动越主动：

层级	情况	你可以做的
第1级	刚出现1–2个轻微信号，功能还正常	启动自我照顾（规律作息、出门走走、按计划服药、用情绪日记记录）
第2级	信号增多，持续超过两周	**告诉信任的家人/朋友**你状态有点往下走，请他陪你留意

层级	情况	你可以做的
第3级	明显下滑、工作生活受影响	**提前复诊 / 主动联系治疗团队**，不要等下一次预约
第4级	出现自杀念头或无法自我照顾	**立即求助**：联系治疗团队、家人陪伴，必要时拨打12356心理援助热线，或直接急诊（详见《危机识别与急救》）

【临床共识】复发初期往往**不需要"重启一大轮治疗"**，可能只是医生微调一下维持方案、加强几次心理支持，就能稳住。拖得越久，越难拉回来。

六、怎样区分"正常几天心情不好"和"复发苗头"

普通人也会有情绪低落的日子，关键看三点：

维度	正常的情绪波动	需要警惕的复发苗头
持续时间	几小时到一两天，诱因过后能缓过来	持续两周以上，越来越重
信号数量	偶尔一两条	好几条同时出现（对照上表）
功能影响	还能正常吃饭、上班、见人	开始影响睡眠、工作、社交，人"转不动"

一句话：**短暂、孤立、有原因、能恢复**——多半是正常的；**持续、多个、无明显诱因、且功能在下滑**——就要按复发处理。

七、平时可以做的防复发习惯

1. **缓解期也坚持维持治疗**：别因为"感觉好了"就自行减药停药（见《药物治疗》）。
2. **保存一份"情绪晴雨表"**：每周简单打分（0–10分的情绪状态），画成趋势，下滑一目了然。
3. **规律作息**：固定起床和睡觉时间，比"补觉"更重要。
4. **留好你的"求助清单"**：把治疗团队、家人、热线写在安全计划里（见《危机识别与急救》）。
5. **让一个亲近的人知道"怎么看你"**：你状态不对时，他能比你更早发现。

> 复发不是你不够坚强，它是这个病的一部分。能在它刚冒头时就认出来、找人帮忙，恰恰是你康复能力的体现。

参考来源

- NICE：*Depression in adults: treatment and management (NG222).* https://www.nice.org.uk/guidance/ng222
- Kuyken W, et al. *Mindfulness-Based Cognitive Therapy to Prevent Relapse in Recurrent Depression.* JAMA Intern Med / JAMA Psychiatry 系列个体患者数据 meta 分析.
- 世界卫生组织（WHO）：*Depression fact sheet*. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/depression

- 美国国家精神卫生研究院（NIMH）：*Depression*. https://www.nimh.nih.gov/health/topics/depression
- 《中国抑郁障碍防治指南》（第二版），中华医学会精神医学分会。

2. 日常自我照顾策略

> 这一页讲的是康复期的"自我照顾"，但请先摆正位置：**它是专业治疗的辅助，不是"靠意志力自愈"的替代。** 如果你正处在严重发作期——连吃饭、起床都困难——请先就医，而不是逼自己"按这页做"。自我照顾的目标，是帮你在治疗之上一点点恢复生活的节奏。

一、睡眠管理

抑郁和睡眠常常互为因果：睡不好，情绪更糟；情绪糟，更睡不着。

- **固定起床时间**：比"几点睡"更重要。每天同一时间起来，哪怕前一晚没睡好。
- **早上接触自然光**：起床后拉开窗帘、出门走走，帮生物钟校准。
- **睡前1小时减速**：放下手机、调暗灯光，做一点放松的事。
- **床只用来睡觉**：不要在床上工作、刷手机、焦虑，让大脑把"床=睡觉"重新连起来。
- **睡不着别硬逼自己**：越努力想睡越清醒。躺20分钟还睡不着，就起来做点安静的事，有困意再回床。
- **慎用酒精助眠**：酒精让人昏沉，但会破坏后半夜睡眠，还会加重抑郁、干扰药效。

【个人体验】很多康复者发现，把"起床时间固定"这一件小事做到，整个人的节律就慢慢回来了。

二、运动

【研究结论】规律的**有氧运动**（快走、慢跑、骑车等）对轻中度抑郁有明确的辅助改善作用，效果可与一些基础干预相比，长期坚持还能降低复发。

但请注意执行方式：

- **从极小目标开始**：比如"今天出门走10分钟"，而不是一上来定"每天跑5公里"。
- **不要搞"运动打卡羞耻"**：今天没做到，不是失败，明天继续就好。运动是为了照顾自己，不是给自己加一个新的考核。
- **哪怕出门站一站也算数**：动力最低的时候，"穿上鞋下楼"这一个动作就值得肯定。

三、饮食

- **规律进餐**：抑郁常让人饥一顿饱一顿，先把"一日三餐"的节奏稳住。
- **血糖稳定**：少吃高糖饮料、精制零食大起大落的刺激，对情绪有帮助。
- **【研究结论】地中海饮食模式**（多蔬果、全谷、鱼类、橄榄油，少加工食品）与较好的情绪状态相关，但这是一种整体饮食结构，**不是某一种"抗抑郁食物"的奇迹。**
- **不过度迷信保健品**：没有单一食物或保健品能治疗抑郁，补剂不能替代药物与治疗。

四、社交：最低剂量维持

抑郁时最怕的就是"越退缩越孤独，越孤独越抑郁"。

- **"最低剂量社交"**：不需要强撑着聚会，哪怕每天和一个人说一句话、回一条消息，也是在维持连接。
- **每天一个微小联结**：给朋友发个表情、和邻居点个头、在家人群里冒个泡。
- **不必为"没力气见人"愧疚**：先做到"最低剂量"就够了。

五、压力减负与任务拆解

抑郁状态下，一个普通任务都像一座山。方法是把任务切到"小到不可能失败"：

- 不要想"打扫房间"，只想"把这桌上的两个杯子洗掉"。
- 不要想"写完报告"，只想"打开文档写第一句话"。
- **降低决策负担**：穿什么、吃什么这种小事，提前定好、减少反复纠结。
- **允许降低期待**：康复期把标准从"做到最好"调成"做一点就行"，是智慧，不是偷懒。

六、正念与呼吸（简单版）

- **3分钟呼吸空间**：停下手里的事——①先觉察此刻的想法和感受；②把注意力集中到呼吸上；③再把觉察扩展到全身。一天做几次即可。
- **身体扫描**：躺着，把注意力从脚到头慢慢移过身体，不评价、只观察。这是 MBCT 的基础练习。

【个人体验】正念不是"让脑子放空"（那根本做不到），而是学会"注意到自己走神了，再轻轻拉回来"——这个动作本身就是在练"不被念头卷走"。

七、情绪日记模板

每天花2分钟记一笔，情绪会变得可观察、可管理。

日期	情绪(0–10)	发生了什么事	身体感觉	我做了什么	今天一件小事
例：10/11	4	早上被领导说方案要改	胸口发紧、肩酸	出门走了10分钟	楼下的猫蹭了我

八、行为激活：愉快事件与成就事件清单

抑郁让人什么都不想做。下面两张表用来"主动安排"，而不是等情绪好了才去做——**往往是先做了，情绪才跟着好起来。**

愉快事件清单（做了会让我稍微舒服一点的小事）：

- 例：晒太阳、听某首歌、泡一杯热茶、和朋友聊两句、洗澡、整理桌面……

成就事件清单（哪怕很小、但我完成了的事）：

- 例：今天按时起床了、吃了饭、回复了那条一直拖着的消息、出门走了走……

> 做法：每周从"愉快清单"里挑1–2件排进日程，做完在"成就清单"里记一笔。这是行为激活（BA）的自助版。

九、防复发生活节律表（参考）

时段	安排
起床后	固定时间起、见光、喝水、按时服药
上午	做当天最重要的一件"小任务"
午后	一次出门活动/运动（哪怕10分钟）
傍晚	最低剂量社交：联系一个人
睡前1小时	放下手机、放松、准备睡觉
每天	记一笔情绪日记

十、给"完全没力气的日子"的最低生存清单

有些日子连"自我照顾"都嫌重。这种时候，只需要做到这五件事，就算胜利：

1. **吃一点东西**（哪怕几口）；
2. **喝够水**；
3. **洗把脸/简单洗漱**；
4. **吃该吃的药**；
5. **联系一个人**（哪怕只发一句"我今天不太好"）。

【个人体验】度过那种日子的诀窍，就是把目标降到"只要活着、基本维持"就好，不要求自己积极、不要求自己进步。熬过去，就是进步。

> **再强调一次**：这些方法是帮你康复的"脚手架"，不能替代药物和心理治疗。如果你按这页做了很久仍持续下滑，请回到医生和治疗师那里，而不是独自硬扛。

参考来源

- NICE：*Depression in adults: treatment and management (NG222)*. https://www.nice.org.uk/guidance/ng222
- 世界卫生组织（WHO）：*Depression fact sheet*. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/depression
- 美国国家精神卫生研究院（NIMH）：*Depression*. https://www.nimh.nih.gov/health/topics/depression
- 行为激活（Behavioral Activation）相关循证综述，见 CBT/BA 治疗指南。

- 《中国抑郁障碍防治指南》（第二版），中华医学会精神医学分会。

3. 负性思维觉察与调整（简化版CBT）

> 抑郁时，我们脑子里会冒出大量"我不行、没希望、都是我的错"的念头。这一页教你一件事：**想法不等于事实。** 学会看见这些自动冒出来的念头，并给它们换一个更平衡的角度，是认知行为疗法（CBT）的核心。它是一项需要反复练习的技能，严重时配合治疗师一起做。

一、一个最基础的认知模型

不是事情本身让我们难过，而是我们**对事情的解释**让我们难过。

情境（发生了什么） → 自动想法（脑子里闪过的解释） → 情绪（感受） → 行为（我做了什么）

举例：朋友半天没回消息。

- 自动想法A："他是不是生我气了，我肯定又哪里做错了" → 难过、退缩 → 不敢再联系。
- 自动想法B："他可能在忙" → 平静 → 该干嘛干嘛。

同样的事，不同的解释，带来完全不同的情绪和行为。**抑郁状态下，我们的"自动想法"往往偏向负面、失真。**

二、抑郁中常见的"思维歪曲"

歪曲类型	内心独白例子	可以这样反问自己
非黑即白	"这次没做好，我就是彻底失败的人"	有没有中间状态？60分算不算？
灾难化	"今天状态差，我这辈子都好不了了"	最坏真的会发生吗？有多大可能？
过度概括	"又搞砸了一次，我做什么都不行"	一次=每次？有没有做成过的事？
心理过滤	满屏好评里只抓住那一条批评	我是不是只盯着负面、漏了别的？
读心术	"他肯定觉得我很没用"	我真的知道他在想什么吗？有证据吗？
应该陈述	"我本该早就好起来，我太没用了"	"应该"是谁定的？现实就是这样，该不该先接受？
个人化	"团队没成，全是我的错"	这件事还有没有别的因素？
情绪推理	"我觉得自己很糟，所以我真的很糟"	"我感觉"等于"事实"吗？感觉会骗人吗？

【个人体验】刚开始练时，你会发现这些念头每天冒出来几十次，自己却完全没察觉。**第一步只是"看见"，不急着反驳。**

三、负性思维记录表（五栏）——可打印模板

当你情绪明显低落时，把下面这张表填一遍。它是CBT的经典自助工具。

①情境	②自动想法 & 情绪强度 (0–10)	③支持这个想法的证据 / 反对的证据	④平衡的替代想法	⑤重新打分情绪 (0–10)
发生了什么？什么时候？和谁？	脑子里闪过什么？当时多难过？	证据两边都列，不只列负面	更客观、更平衡的看法是什么？	填完后现在情绪几分？

一个填写范例

①情境	②自动想法 & 情绪	③证据对比	④平衡替代想法	⑤重评
开会时我发言卡了壳，大家笑了一下	想法："我太丢人了，所有人都觉得我不行。" 难过9分	支持：我确实卡壳了。反对：笑的是玩笑不是嘲笑；以前我也有讲得顺的时候；没人事后提起	"我这次紧张卡壳了，但这不代表我整个人不行。大家更可能没放在心上。"	难过降到5分

> 注意：目标不是把"我不行"硬改成"我超棒"，而是找到一个**更接近事实、更平衡**的说法。情绪分数通常会从9降到4–6，而不是变成0——这就够了。

四、练习步骤

1. **先记录，不急着反驳**：情绪上来时，先把情境和自动想法写下来。光是"看见"它，就已经拉开了一点距离。
2. **找证据**：像上面表格那样，强迫自己把"反对这个想法的证据"也列出来——抑郁会让你自动忽略它们。
3. **换角度**：如果好朋友遇到同样的事，你会怎么劝他？把那句话对自己说一遍。
4. **行为实验**：选一个小顾虑，做一个"试验"看看结果。比如"我一发消息朋友就会烦我吗？"——发一条试试，用真实结果检验想法。

五、常见困难

你的感受	说明
"我做不到，这没用"	注意——**"这没用"本身就是抑郁的负性思维。**刚开始练都很别扭，多试几次才见效果。
"我就是想往积极了想，可做不到"	不追求"积极"，追求"平衡"。硬灌鸡汤反而更累。
"我老是忍不住反刍同一件事"	**反刍**是反复咀嚼痛苦、越想越沉；**有益反思**是有目标、想完能放下。区别在于：你是在找解决办法，还是在原地打转。
"我情绪太重，根本没法填表"	那就先不填，先去做《日常自我照顾》里的小事，或直接联系治疗师。这页工具是"状态还行时"的练习，不是重症时的任务。

六、"给自己的同情信"练习

抑郁对自己往往格外苛刻。试试这个练习：

1. 想象一个**真正关心你、对你很宽容**的人（朋友、家人、甚至一个假想的善意角色）。
2. 用他的口吻，给此刻的你写一段话：他会怎么看待你现在的挣扎？他会对你说什么？
3. 大声读一遍。

【个人体验】很多人写着写着会哭——因为我们对别人那么宽容，对自己却那么狠。这封信，就是把那份宽容借回来给自己。

七、和正念结合：念头观察

MBCT 里有一个很有用的句式——当负性念头冒出来时，在心里对自己说：

> **"我现在有一个想法：我很糟糕。"**

而不是直接认同"我很糟糕"。

只是加上"我有一个想法"这几个字，你就从"沉浸在想法里"变成了"观察到一个念头经过"。念头像云，会来也会走；你不是那朵云，你是看云的那片天空。

> 这是一项技能，像学骑车——刚开始歪歪扭扭很正常。若你发现自己持续陷在强烈的负性思维里走不出来，那是该回到治疗师那里的时候，而不是你"不够努力"。

参考来源

- NICE：*Depression in adults: treatment and management (NG222)*. https://www.nice.org.uk/guidance/ng222
- 美国国家精神卫生研究院（NIMH）：*Depression*. https://www.nimh.nih.gov/health/topics/depression
- Beck JS. *Cognitive Behavior Therapy: Basics and Beyond*（CBT 经典教材）。
- Kuyken W, et al. *MBCT 预防抑郁复发*系列个体患者数据 meta 分析。
- 《中国抑郁障碍防治指南》（第二版），中华医学会精神医学分会。

4. 危机识别与急救

> **如果你此刻正被强烈的痛苦抓住，或担心自己/身边人不安全，请先看这一页最上面的求助方式——不必读完再行动。**
>
> 在中国大陆：**全国统一心理援助热线 12356**（24小时、免费）；医疗急救 **120**；报警 **110**。
>
> 本页只讲如何识别风险、如何求助、如何让环境更安全。**它不描述任何伤害自己的方法**——因为那不是这一页该做的事，这一页的唯一目的，是帮你或你身边的人活下来、被接住。

〇、先记住最重要的两句话

1. **"说出来不会诱发自杀。"** 很多人担心"我问了，他才去想"。恰恰相反——平静、直接地问"你是不是想过伤害自己？有没有计划？"，会让那个独自扛着秘密的人松一口气，反而降低风险。不说，才危险。
2. **求助不是给人添麻烦，是这个世界上最值得做的事。** 哪怕你觉得"我不值得被救"，这个念头本身就是抑郁在说话，不要相信它。

一、风险分级：从念头到行动，越往后越紧急

自杀风险是一个连续谱，可以大致分成四级。**级别越高，越要立即动用身边的人和紧急资源。** 请注意：下面只描述"信号"和"该做什么"，不提供任何方法细节。

I 级：被动的死亡念头 / 觉得活着没意思

- **信号**："活着真没劲""要是能一觉睡过去不再醒来就好了""人活着到底有什么意义"。没有想主动去做什么，只是觉得生无可恋。
- **这很重要，不是"矫情"**：被动念头往往是早期信号，认真对待它，很多危机在这里就能被拦住。
- **你的行动**：
- 不要独自闷着——告诉一个你信任的人："我最近老是觉得活着没意思，我有点担心自己。"
- **联系你的治疗团队**，或拨打 **12356** 心理援助热线聊一聊。
- 不要饮酒，不要独处太久。

II 级：主动的念头，但还没有计划

- **信号**：反复出现"不想活了""想结束这一切"的念头，但**没有想过具体什么时候、在哪里、怎么做**，也没有做任何准备。
- **你的行动**：
- **24小时内要有信任的人知道并陪伴你**，不要一个人待着。
- 尽快到精神科/心理科做一次评估，哪怕你觉得"还没那么严重"。
- 拨打 **12356**，或你的治疗团队电话，把现在的状态如实说出来。

- 让家人/信任的人帮忙，把眼前可能造成危险的物品**收走或移开**（具体怎么处理听专业人员的，不必自己研究）。

III 级：有了具体计划，或出现准备行为

- **信号**：脑子里有了具体的时间、地点、方式；或出现准备行为——比如囤积药物、写遗言/遗书、安排后事、把心爱的东西送人、向人道别；又或者**长时间低落之后突然异常平静、"放下了"**（这往往是已经做出决定后的安静，非常危险）。
- **你的行动（这是真正的紧急情况）**：
- **立刻让一个人24小时不离地陪着你**，不要独处。
- **立即去急诊，或拨打 120 / 110**，直接说明情况。
- 不要自己开车、不要独自前往；让信任的人陪你去。
- 此刻不要花时间填表、做计划——直接找人和找急诊。

IV 级：已经采取行动，或正在进行中

- **信号**：已经发生了自伤行为，或正在进行中。
- **你的行动**：
- **立即拨打 120（急救）和 110（报警）。**
- 保持电话畅通，听从调度员的指导，在专业人员到达前**不要独自处理、不要自行搬动、不要喂食喂水。**
- 如果身边有人，请他立刻去叫人/打电话，你留在身边陪着（在确保自身安全的前提下）。

> **任何一级，只要你心里没底，都可以直接往上一级行动。** 宁可反应过度，不要追悔莫及。

特别要警惕的"高危信号"

以下因素会让风险明显升高，出现时尤其要果断求助：

- **强烈的绝望感**："我永远好不了了，没有任何希望。"
- **说出来或写出来的自杀言语**，包括在网上、社交媒体上的留言、告别话。
- **过去有过自杀尝试**——这是最强的风险预测因素之一，务必告诉医生。
- **饮酒、使用违禁物质**后情绪失控。
- **近期急性应激**（重大丧失、冲突、失业、重病诊断）。
- **严重的社会隔离**：一个人住、和家人断联、没人可以说话。
- **"突然好转"的平静**：长期痛苦后反而显得解脱、安排后事——这不是真的好了，可能是危险信号。

二、中国求助渠道（核实日期：2026-10-11）

> 以下号码为公开核实信息。**热线号码可能调整，拨打前以当地官方公布为准。**

渠道	号码 / 方式	说明
全国统一心理援助热线	**12356**	2025年5月起全国统一使用，24小时、免费，提供心理咨询与危机干预。**首选。**
医疗急救	**120**	任何紧急、已发生危险时
报警	**110**	现场有现实安全威胁、需要警力时
当地精神卫生中心 / 精神专科医院急诊	查你所在城市的地址电话	有自杀风险、需要专业评估时的对口去处
北京心理危机研究与干预中心热线（回龙观医院）	**010-82951332**（手机）；座机 800-810-1117	作为补充渠道，24小时公益热线

【核实依据】12356 由国家卫健委通知设置、2025年起全国统一开通并普及；北京热线设在北京回龙观医院。

三、怎么开口求助：可以直接照抄的话

很多人卡在"不知道怎么说"。下面是现成的话，直接发出去/说出来就行。

发给家人 / 伴侣

> "我最近状态很差，脑子里老是有不想活的念头。我不想一个人扛了，能不能今天陪我待一会儿？我们可能还需要联系一下我的医生/去趟急诊。"

发给朋友

> "有件事我认真地跟你说：我这几天很难受，出现了伤害自己的想法。我现在需要你在我身边。你不用会劝我，陪着我、听我说话就好。"

告诉同事（如需请假/求助）

> "我最近因为健康原因需要暂时调整一下，去看医生。谢谢你的理解，具体情况我方便时再细说。"（不必把隐私全摊开）

打给12356 / 医生时

> "我现在抑郁情绪很重，出现了（被动/主动/有计划的）自杀念头。我想求助，请问我现在该怎么办？"

> 你不需要"够严重"才配打这个电话。任何让你不安的念头，都值得一个电话。

四、我的个人安全计划（Stanley-Brown 六步模板）

安全计划（Safety Planning）是国际公认有效的自助工具：**在你还平静、有能力的时候，提前写好一份"出事时照着做"的清单**，存手机、给信任的人也存一份。请在专业人士或信任的人协助下一起完成。

> **使用时机提醒**：如果此刻危险已经迫在眉睫（III/IV级），**不要先填表，立刻找人、立刻打120/110。**这份表是给"感觉不对、但还没到最急"的时候用的。

《我的安全计划》

第1步：我的警告信号

（哪些想法、情绪、身体感觉、行为出现，说明我状态在下滑——参考《复发预警信号》）

- 例：连续失眠、突然不想理人、脑子里反复出现"没意义"……

第2步：我可以先自己做的内部应对

（不去麻烦别人、能立刻转移注意力的事，目的是先稳住一下）

- 例：做几次深呼吸、出门走一圈、听一首喜欢的歌、洗个热水澡、撸猫、做3分钟呼吸练习……

第3步：可以让我分散注意力的人和社交场景

（找谁待着、去哪里能让我从念头里抽离——不一定要倾诉，只是"在一起"）

- 人名/联系方式：_____
- 可以去的地方：_____

第4步：我可以求助的家人和朋友

（直接向他们说明我的状态，请他们陪伴或帮忙）

- 姓名 + 电话：_____
- 姓名 + 电话：_____
- （提前征得对方同意）

第5步：专业人士与机构联系方式

- 我的精神科医生 / 治疗师：_____（医院、电话、出诊时间）
- 当地精神卫生中心/急诊：_____
- **心理援助热线：12356**；急救：120；报警：110

第6步：让环境更安全

（在专业人士或信任的人协助下，**移除或远离可能造成危险的物品与地点**，降低我立刻能伤害到自己的机会；具体怎么整理听专业人员的指导，并在危机过后复查、更新这份计划）

我写下这份计划的日期：_____

协助我一起完成的人：_____

（建议每次复诊、每次状态变化后回来更新）

五、关于住院：它是保护，不是惩罚

【临床共识】在以下情况，医生可能会建议**住院**：

- 存在即刻的、明显的自伤/自杀危险；
- 拒食、拒饮，基本生活无法维持；
- 伴有精神病性症状、严重迟滞；
- 在家无法保证安全、缺乏可靠照护。

- **住院不是被关起来受惩罚**，而是在你最无力的时候，给你一个24小时有人看护、能稳定用药和观察的安全环境。
- **非自愿就医**：当一个人有即刻危险、又无法/拒绝自行就医时，家属和专业人员会按照当地法律程序送医——这是为了救命，不是侵犯。具体流程以当地精神卫生法规为准。
- **家属该做的**：保持冷静、陪同、向医生如实说明情况，不争吵、不激惹。

六、身边的人：该说与不该做

如果你是陪着当事人的人，下面这张表帮你稳住：

✅ 该做	❌ 不该做
平静、直接地问："你是不是想过伤害自己？有没有计划？"	回避不谈、假装没事
认真倾听，不评判、不说教	指责、羞辱："你怎么这么想不开""太自私了"
陪着他，不离开他独自待着	让他一个人"静静"
帮他联系医生、急诊、120/110/12356	承诺"我替你保密"（安全比保密重要）
告诉他"你的生命对我很重要，我们一起找办法"	轻视："这点小事至于吗""别人比你惨多了"
在专业人员指导下整理环境	和他争辩、强行控制、围观刺激

> 你不需要"会心理辅导"。**在场、稳定、不评判、帮他联系人**——就已经是极大的帮助。

七、危机过后怎么办

- **不评判**：无论是当事人还是陪伴者，事后都不要自责"当初要是……"。危机已经发生，重点是接下来。
- **尽快复诊**：让医生知道这次发生了什么，评估是否需要调整治疗（药物/住院/心理）。
- **更新安全计划**：把这次的新信号、新联系人补进去。
- **关于"限制手段"**：是否需要长期的环境调整、监护安排，请在医生和专业团队指导下进行，不要家人自己摸索极端做法。
- **陪伴者也需要喘息**：照顾一个有自杀风险的人压力很大，记得你自己也要找支持。

> **最后，请记住：** 抑郁会骗你，说"没有希望了""走投无路了""你和别人都是负担"。这些都是病的声音，不是事实。真正的事实是——**这种病是可以治的，此刻的痛苦不会永远持续，只要你愿意再坚持一下、打一个电话，就有人来接你。**
>
> 现在，如果你正需要：**12356（24小时）、120、110。**

参考来源

- 世界卫生组织（WHO）：*Suicide fact sheet*. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/suicide
- 世界卫生组织（WHO）：*LIVE LIFE: an implementation guide for suicide prevention*. https://www.who.int/publications/i/item/9789240026629
- 国家卫健委：全国统一心理援助热线（12356）相关通知，国家精神卫生项目办 https://ncmhc.org.cn/
- Brown GK, et al. *Safety Planning Intervention: A Brief Intervention to Mitigate Suicide Risk.* J Clin Psychiatry. 2008.
- Stanley B, Brown GK. *Safety Planning Intervention for the Prevention of Suicide.* Cognitive and Behavioral Practice. 2012.
- NICE：*Depression in adults: treatment and management (NG222)*. https://www.nice.org.uk/guidance/ng222
- 北京心理危机研究与干预中心（回龙观医院）：https://www.crisis.org.cn/

5. 社会支持

> 抑郁最伤人的地方之一，是它会把你和世界隔离开——你怕成为别人的负担，怕被说"矫情"，于是越来越退缩；而退缩又让你更孤独、更难好起来。这一页想告诉你：**社会支持不是"麻烦别人"，而是被研究反复证实的、保护你不复发的重要因素。** 学会有策略地求助，本身就是康复的一部分。

一、先理解：抑郁时社交为什么这么难

【个人体验】抑郁中的人对社交常有几种典型心理：

- **"我是个负担"**：觉得自己一身负能量，谁沾上谁倒霉。
- **"说了也没人懂，只会被说矫情/想太多"**。
- **"我连话都懒得说，不如一个人待着"**——而独处越久，抑郁越深。
- **怕被贴标签**：怕告诉别人后被另眼相看。

这些感受都很真实。但研究告诉我们：**在你最难的时候，哪怕一两个真正的连接，都能显著降低复发和危机风险。** 问题不是"要不要连接"，而是"用什么方式、和谁连接"。

二、怎么向不同的人说明你的情况

不必对所有人和盘托出，但对关键的人，说清楚比让对方猜要省力得多。下面是可以参考的话术。

告诉家人 / 伴侣

> "我最近被诊断为抑郁障碍，这是一种疾病，和感冒发烧一样是需要治疗的，不是我'想不开'。我现在正在吃药、看医生。我需要你的不是建议，而是有时候陪我说说话、在我状态差的时候别让我一个人待太久。"

告诉朋友

> "跟你说个事：我这段时间在应对抑郁，在治疗中。可能有时候我回消息慢、可能不太想聚会，不是针对你。你愿意的话，偶尔约我散散步、听我抱怨两句，就帮大忙了。"

告诉同事 / 单位（按需，不必全说）

> "我因为健康原因在接受治疗，需要定期去医院。工作上我会尽量安排好，谢谢你的理解。"
> 是否告诉单位、告诉多少，是你的隐私选择。国家对劳动权益有保护（见《生活与权益》相关内容），拿不准可以先问医生或查当地政策。

三、提出"具体可执行"的需求

人在被安慰时最累的，是不知道"我具体该做什么"。你越具体，对方越容易帮到你：

模糊的求助	更具体、对方更好接的版本
"我好难受"	"你能陪我下楼走20分钟吗？"
"我谁都不想见"	"今天不用长聊，你陪我坐着、各看各的手机也行。"
"帮帮我"	"今天我可能忘吃药，你晚上八点提醒我一下好吗？"
"你能不能劝劝我"	"你不用给建议，就听我说完，告诉我'我在'就够了。"

四、如何回应"不理解"

不是所有人都能立刻理解抑郁。你不必说服每一个人：

- **不必争**：有人说"你就是想太多""出去走走就好了"，你可以微笑着不接话，把精力留给真正支持你的人。
- **守住隐私边界**：你有权只告诉"需要知道的人"，不必对全公司、全家族公开。
- **谁值得深说**：先观察谁在你低谷时没有走掉，再对他多说一些。

五、支持系统地图：你身边有谁

把你身边的人按下面四类填一填。你会发现，哪怕关系网不大，也总能拼出一张"支持网"。

类别	我可以找谁	能提供什么	联系方式
能倾诉情绪的人	（朋友/家人）	听我说、不评判	
能办实事的人	（家人/同事）	陪看病、提醒吃药、帮忙跑腿	
能一起"待着"的人	（朋友）	不用说话也舒服的陪伴	
专业支持	（医生/治疗师/热线）	诊断、治疗、危机干预	医生电话：____；12356

> 如果某几栏是空的，没关系——这正是你接下来可以慢慢搭建的。热线、医生、社工，都算你的"专业支持"。

六、同伴支持与康复者团体

- **康复者团体 / 患者组织**：和走过同样路的人在一起，最大的收获是"原来我不是一个人、不是怪物"，这种正常化的力量很宝贵。
- **线上社区**：可以获得信息和陪伴，但要**甄别质量**——远离那些"只卖课""只贩卖绝望""反对吃药"的圈子。
- 【争议观点】同伴支持很治愈，但它不能替代专业治疗。如果一个社群劝你停药、或讨论伤害自己的方法，请立刻离开。

七、当家人不支持时

如果最该支持的家人反而不理解、甚至指责你，你还有别的支撑：

- **专业系统**：你的医生、心理治疗师、医院社工；
- **热线**：12356 随时有人听；
- **同事、朋友、社区工作者**：哪怕只有一个；
- **线上正规的康复者社群。**

【个人体验】很多康复者最终的支持网，并不是一开始最亲的家人，而是"半路遇到的、懂你的人"。支持是可以重新选择和建立的。

八、恢复社交的"阶梯练习"

病后重新接触人，不要一步到位。从最轻松的开始，逐级往上：

阶梯	练习
第1级	在群里给朋友的动态点个赞
第2级	发一条文字消息 / 语音
第3级	打一个不长的电话
第4级	一起出门散个步、喝杯东西
第5级	较深入地聊一次天

> 不必强求自己到第5级。停在任何一级，都在维护连接。

九、感谢与关系修复

- 康复后，记得对那些在你低谷时守着你的人说一声谢谢——这会让关系更牢固。
- 对于病中"失联""没回消息"造成的误会，也可以简单解释一句："那段时间我状态很差，不是故意不理你。"大多数人会理解。

> 抑郁让你觉得"我谁都不需要、谁也不需要我"。这是病在骗你。**人是在关系里被治愈的。** 你不需要立刻拥有庞大的支持网，只需要先找到一个人，发出第一条消息。

参考来源

- NICE：*Depression in adults: treatment and management (NG222)*. https://www.nice.org.uk/guidance/ng222
- 世界卫生组织（WHO）：*Depression fact sheet*. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/depression

- 美国国家精神卫生研究院（NIMH）：*Depression*. https://www.nimh.nih.gov/health/topics/depression
- 世界卫生组织（WHO）：*LIVE LIFE*（社会联结与保护因素）. https://www.who.int/publications/i/item/9789240026629
- 《中国抑郁障碍防治指南》（第二版），中华医学会精神医学分会。

1. 常见误区澄清

> 抑郁障碍是一种需要被认真对待的疾病，不是"想不开""矫情""懒"，也不是靠意志力就能扛过去的。本章用"误区—事实依据—你可以这样想/这样回应"的对照表，把最常见的误解一次说清。【临床共识】本章内容不替代面诊，具体用药与治疗请遵精神科医生医嘱。

一、为什么要专门"辟谣"

病耻感（stigma）是很多人迟迟不就医、不规律治疗、偷偷停药的重要原因。外界一句"想开点""你就是太闲了"，对正在发作的人来说，可能等于被推回黑暗里。下面这些说法，听起来像安慰，实际却在加重负担；把它们拆穿，既是为了让你不再自我攻击，也是为了让你身边的人明白该怎么说。

二、逐条误区对照表

1. 关于"性格"与"态度"

误区	事实依据	你可以这样想 / 这样回应
"想开点就好了"	抑郁发作时，大脑的情绪调节、睡眠、精力、注意力功能受损，不是"换个角度"就能立刻切换的。劝说、讲道理对急性发作期帮助有限，甚至增加"我连想开都做不到"的自责。【临床共识】	"我现在确实想不开，这不代表我不努力；我需要的是先看病、把状态稳下来。"对别人可说："谢谢你，我在接受治疗。"
"抑郁症就是矫情、脆弱、懒"	抑郁会显著影响睡眠、食欲、精力、决策与日常功能，是有客观生物学基础的疾病，与性格强弱无关。许多高成就者、责任心极强的人反而更容易患病。【研究结论】	"我不是懒，是病到动不了；就像骨折的人不能靠坚强站起来。"
"你就是太闲了/没事干才瞎想"	恰恰相反，高压、过劳、长期处于"必须撑住"状态的人更容易被击垮；很多患者在工作、家庭中已经被透支到极限。	"我不是闲出来的，是撑太久了；休息和治疗不是偷懒，是止损。"
"别人比你惨多了，你这算什么"	痛苦不能被比较，每个人的神经系统、压力累积与社会支持不同。"别人更惨"不能减轻当下的症状，只会让人不敢求助。	"每个人的承受力不同，我现在需要帮助，这不需要和别人比。"
"靠意志力就能扛过去"	意志力可用于"坚持就医、按时服药、完成自助练习"，但不能用来"把症状想没"。把康复变成对意志力的考验，本身就是一种伤害。	"意志力用在对的地方——找医生、吃药、复诊，而不是硬扛。"

2. 关于药物

误区	事实依据	你可以这样想 / 这样回应
"抗抑郁药会变傻、把人吃呆"	多数抗抑郁药不作用于认知功能；部分人初期会有嗜睡、反应略慢，通常随时间或调药改善。真正"发呆"的往往是抑郁本身未被控制。【临床共识】	"刚开始有点钝是常见反应，复诊告诉医生，可以调；变傻的是病，不是药。"

误区	事实依据	你可以这样想 / 这样回应
"吃药会上瘾、有依赖"	抗抑郁药（如SSRI/SNRI类）不属于成瘾性物质，不会越吃越渴求、越吃剂量越大。但突然停药可能出现撤药反应（头晕、心慌、情绪反弹），这是"需要逐渐减量"，不是"成瘾"。【临床共识】	"停药要慢慢减，听医生安排；这和毒品成瘾是两回事。"
"西药伤身体，不如中药调理"	规范使用的抗抑郁药有明确疗效证据和长期安全性数据；"纯中药无副作用"是话术，很多不明成分中成药反而添加了西药。中药可作为辅助，但不能替代规范评估与治疗。【争议观点】	"无论中西药，都要在医生指导下用，成分不明的'调理药'最危险。"
"好了就可以立刻停药"	症状缓解后通常仍需维持治疗（数月至数年，由发作次数、严重程度决定），目的是预防复发。自行过早停药复发率明显升高。【临床共识】	"感觉好只是第一步，停药时机让医生定；我会按计划复诊。"
"药吃了没用，说明我没救了"	抗抑郁药通常需要2–4周才起效，4–6周才能较充分评估；一种药效果不佳，还有换药、联合、增效、心理治疗等多种方案。【临床共识】	"给自己和医生一点时间；无效不是终点，是调整方案的信号。"

3. 关于治疗方式

误区	事实依据	你可以这样想 / 这样回应
"运动/旅游/散散心就能好，不用看医生"	运动、日照、社交对轻中度抑郁和康复期有明确辅助作用，但中重度、有自杀念头、伴有躯体症状时，单靠这些会延误治疗。	"运动是帮手，不是替代品；急性期先就医，稳定后再把运动加回来。"
"心理咨询就是聊天、灌鸡汤"	规范的心理治疗（如CBT认知行为治疗、IPT人际治疗、MBCT正念认知治疗）有结构化技术、可重复、有疗效证据，目标是改变认知模式与应对方式，不是陪聊。【临床共识】	"好的咨询会有作业、有聚焦、有阶段目标；聊完没变化可以换治疗师。"
"去精神病院看病很丢人"	抑郁就像感冒发烧一样需要专科处理；综合医院的心身医学科、心理科也是常见渠道。 stigma 是社会问题，不是患者的错。	"去看精神科和去看内科一样正常；我愿意为自己的健康负责。"
"看病会留案底、影响一生"	普通抑郁症门诊/住院病历属于个人敏感医疗信息，受法律保护，不会进入所谓"案底"；升学、就业的无犯罪记录证明与精神科就诊史无关（涉及严重冲动伤人等特殊情形另论）。【临床共识】	"病历是我自己的健康资料，不是案底；隐私受法律保护。"

4. 关于预后与自杀

误区	事实依据	你可以这样想 / 这样回应
"我这么惨，一定好不了"	抑郁是所有精神疾病中治疗反应较好的一类；经过规范治疗，多数人可显著改善并恢复功能。"好不了"是疾病本身的负性认知偏见，不是事实。【研究结论】	"这种绝望感是症状在说话，不是判决书；我见过很多人走出来。"
"抑郁症治不好、会反复发作一辈子"	抑郁确实可能复发，但复发是可以通过维持治疗、心理干预、生活方式管理来降低概率的；"复发"不等于"治不好"。	"我要做的是学会管理它，而不是被它吓退。"
"说要自杀的人不会真的自杀（最危险误区）"	大多数自杀发生前都有言语、行为信号；嘴上说"不想活"的人恰恰在求助，必须认真对待、及时干预。轻视这句话可能致命。【临床共识】	"听到这话，不要当玩笑，不要承诺保密；立刻陪在身边、联系12356/120。"
"看起来开心、会笑的人不会抑郁"	"微笑型抑郁"普遍存在，患者可能在社交场合表现正常，独处时崩溃。外表不能用来判断内心痛苦程度。	"别人看不出来，不代表我不痛苦；我有权求助。"
"青少年情绪差就是青春期叛逆，不是病"	青春期情绪波动常见，但持续两周以上的情绪低落、兴趣丧失、成绩骤降、自我封闭、自伤念头，要警惕抑郁，不能简单归为"叛逆"。【临床共识】	"持续两周以上的不对头，就该找儿童精神科/心理科评估。"

误区	事实依据	你可以这样想 / 这样回应
"老人情绪低落是年纪大了，正常"	老年抑郁常被误认为"年纪大了、想不开"，但老年人自杀风险更高、躯体化更重，同样需要治疗，不能默认"正常"。	"老人说'活着没意思'是危险信号，不是老糊涂。"

三、给自己的三句话

1. **这不是你的错。** 抑郁是疾病，不是道德缺陷。
2. **求助是强者的行为。** 愿意看医生、愿意吃药、愿意复诊，本身就是在对抗疾病。
3. **绝望感是症状，不是事实。** 等治疗起效后，你会重新看到别的可能。

四、当身边人说出这些话时

- 不争论、不硬掰：简单一句"我在治疗，会好的"即可，不必说服所有人。
- 保护自己的能量：把反复劝你的人暂时减少接触，先稳住治疗关系（医生、咨询师、一两个懂你的朋友）。
- 把这份对照表转给愿意了解你的人，比解释一百句更省力。

参考来源

- 世界卫生组织：Depression（抑郁症）事实清单
- 英国国家卫生与临床优化研究所（NICE）：Depression in adults: treatment and management，NG222
- 美国国家精神卫生研究院（NIMH）：Depression
- 国家心理健康和精神卫生防治中心：官网科普资源
- 中华医学会精神医学分会：《中国抑郁障碍防治指南》（第二版）相关共识

2. 生活与权益

> 本章讲的是你作为抑郁症患者，在就医、请假、工作、证件、求助渠道上的**一般权利与通行框架**。各地政策差异很大，具体数字、材料、流程一律以当地医保局、人社局、残联、官方热线最新口径为准。【临床共识】科普不替代法律意见，遇到劳动纠纷、工伤、歧视解除劳动合同，及时拨 12333（人社）或 12348（法律援助）。

一、就医与医保：钱的问题，先搞清楚

1. 精神科门诊、住院已经纳入医保一般报销范围

- 抑郁症属于精神障碍，在定点精神卫生中心、综合医院精神科/心身医学科就诊，门诊和住院费用通常纳入基本医保报销（具体比例、起付线、封顶线因参保类型——职工/居民/新农合——和所在地不同）。
- 很多地区把**抑郁障碍、双相情感障碍等纳入"门诊慢特病/门诊特殊病种"**管理，符合条件者申请后，门诊拿药、复查可按住院比例或更高比例报销，**大大降低长期用药负担**。是否在你当地的慢特病目录、如何申请，直接问就诊医院医保办或当地医保局。
- **异地就医**：长期在外地居住/工作，可在"国家医保服务平台"App 或参保地医保经办机构办理**异地就医备案**，备案后在异地定点医院持卡/扫码直接结算。

2. 你可以主动问医院的三句话

1. "我这个病能不能申请门诊慢特病？需要哪些材料？"
2. "开的药在医保目录里吗？有没有同等疗效但报销比例更高的替代？"
3. "住院和门诊分别大概怎么报？需要我先垫多少？"

二、病假与劳动关系：生病期间，工作怎么办

1. 请病假的基本流程

- 凭**医疗机构诊断证明 + 病假建议书/休假证明**向单位请假；精神科医生在病历与诊断证明上会写明建议休息时长。
- 病假期间，单位应按**当地规定**发放病假工资（各地比例不同，常见为不低于当地最低工资的一定百分比），不能默认"病假一分钱不发"。

2. "医疗期"是什么

- 《劳动合同法》框架下，劳动者因患病或非因工负伤需要停止工作治疗时，享有**医疗期**：在医疗期内，用人单位一般**不得随意解除劳动合同**；医疗期长短与本人实际参加工作年限、在本单位工作年限挂钩（具体月数按原劳动部规定与地方细则）。

- 医疗期满后仍不能从事原工作、也不能从事单位另行安排工作的，单位可依法解除，但需支付经济补偿等——这一步**容易产生纠纷**，不要自己签不利文件，先咨询 12333 或法律援助。

3. 用人单位能不能因为你得了抑郁症就开掉你

- **原则上不能因患病歧视性解除劳动合同。** 抑郁障碍属于疾病，不是"不能胜任工作"的充分理由；以"精神病""影响不好"为由辞退，涉嫌违法解除。
- 但现实中很多单位会用"绩效不达标""调岗"等方式施压。证据很重要：**保留诊断证明、病历、请假审批记录、考勤、与HR的聊天/邮件。**
- 反过来说，是否需要请长假、是否调整岗位、是否阶段性回归工作，应与医生评估一致，不要为了"证明自己没事"硬扛导致复发。

三、精神残疾证：能办吗？怎么办？

> 【重要】**确诊抑郁症 ≠ 一定能评上精神残疾。** 残疾评定看的是病情对**社会功能**（生活、工作、社交、自我照料）的持续影响，不是看诊断名称。

一般原则

- 评定依据国家标准 **《残疾人残疾分类和分级》GB/T 26341-2010**，由指定的残疾评定医院/医生进行。
- 通常要求：病情**持续一年以上**、经治疗仍遗留较明显的社会功能损害；急性发作期、刚用药、症状波动期一般不在评定时机。
- 向**户籍所在地或常住地县级残联**提出申请，残联会指引到指定评定机构；评定通过后核发《中华人民共和国残疾人证》。
- 持证可享受的权益因地区而异，常见包括：公交/景区优惠、康复服务补贴、个体经营税收优惠、部分岗位按比例安置残疾人的就业政策、困难残疾人生活补贴/护理补贴（需符合困难条件）。
- **不要相信"包过""花钱代办残疾证"的中介**，这是骗局；评定严格按国家标准。

四、心理援助与紧急热线（核实日期：2026-10-11）

热线	用途	备注
12356	全国统一心理援助热线，**24 小时免费**	国家卫健委 2024 年设立（国卫医政函〔2024〕259号），2025年5月1日起全国统一使用，2025年9月已全国普及。用于情绪困扰、危机干预、就医指引。号码可能调整，以当地卫健委/官方公布为准。
120	医疗急救	出现自杀/自伤正在实施、药物过量、严重躯体不适时拨打。
110	公安	现场有现实人身安全威胁、需要紧急处置时拨打。
12320	卫生健康热线	公共卫生咨询、就医指引。
12333	人社咨询	病假、医疗期、劳动合同、失业保险、医保疑问。
12348	法律援助	劳动纠纷、歧视解除、需要免费法律帮助。

热线	用途	备注
12345	政务服务便民热线	说不清归谁管时，打这个总热线转办。

> 【研究结论】12356 是目前中国大陆最权威的统一心理援助入口；把它存在手机通讯录里，最好再告诉一两个信任的人也存一份。

五、学业、就业、婚恋与隐私

事项	一般原则
学业合理便利	学生可凭诊断证明向学校申请：缓考、请假、调整宿舍、心理中心支持。高校普遍设有心理咨询中心和心理健康教育中心，多数免费且保密。
就业隐私	求职时**没有法定义务**告诉雇主自己的抑郁病史；背景调查一般不含精神科就诊记录。是否主动披露，权衡"能否获得合理便利"与"是否可能被歧视"，不确定时先咨询。
病历保密	病历属于《个人信息保护法》下的**敏感个人信息**，医疗机构不得随意向单位、学校、保险公司（除法定程序外）披露。泄露可投诉/追责。
婚恋与生育	抑郁症不影响结婚/离婚的民事权利；是否要孩子、孕期/哺乳期用药，**必须**提前与精神科 + 产科医生共同评估，不能自行停药怀孕。

六、社会救助与社区：不要误解"严重精神障碍管理"

- 社区卫生服务中心/乡镇卫生院有基本公共卫生服务，其中包含对**严重精神障碍**患者的健康管理（随访、用药指导）。
- 【重要澄清】"严重精神障碍管理治疗项目（俗称686项目）"主要针对**精神分裂症、双相情感障碍、偏执性精神病、分裂情感性障碍、癫痫所致精神障碍、严重精神发育迟滞**等六类；**抑郁障碍一般不在其常规管理范围内。**不要被"社区上门登记"吓到，也不要因为怕登记而不看病。
- 经济特别困难者：可向户籍地街道/乡镇申请**临时救助、最低生活保障（低保）**，符合条件者医疗救助会同步减免。

七、权益事项总表（随身对照）

权益事项	一般规定	我可以怎么做	咨询渠道
门诊/住院医保报销	定点医院按参保类型报销	持卡/电子医保码结算，问清报销比例	就诊医院医保办、当地医保局、国家医保服务平台App
门诊慢特病	部分地区抑郁在列，可提高门诊报销	请医生出具病情材料，向医保局申请	医院医保办、医保局、12393
异地就医备案	长期外地居住/工作可备案直接结算	在国家医保服务平台App自助备案	参保地医保经办机构
病假与病假工资	凭诊断证明请假，病假工资按地方规定	保留诊断证明、病历、请假记录	单位人事、12333

权益事项	一般规定	我可以怎么做	咨询渠道
医疗期	患病治疗期间单位一般不得随意解除	不轻易签自愿离职文件，纠纷先咨询	12333、12348 法律援助
残疾证	需持续社会功能损害达评残标准，非确诊即办	向县级残联申请，到指定机构评定	户籍地/常住地县级残联
心理援助	12356 24小时免费	存通讯录，也告诉信任的人	12356
危机干预	自杀/自伤正在实施	不承诺保密，不离人，立即120/110/12356	急诊精神科
困难救助	符合低保/临时救助条件者可申请	向街道/乡镇民政窗口申请	12345、街道民政

> 【统一提示】以上所有政策数字、比例、清单、流程**各地不同、且会更新**。办理前请以当地医保局、人社局、残联、卫健委的**最新官方口径**为准；重要文件签字前，先打 12333/12348 问一句。

参考来源

- 国家心理健康和精神卫生防治中心：12356心理援助热线相关通知
- 人民网：全国心理援助热线12356已普及相关报道
- 世界卫生组织：Depression
- 《中华人民共和国劳动合同法》（国家法律法规数据库 flk.npc.gov.cn 可查）
- 《残疾人残疾分类和分级》GB/T 26341-2010
- 《中华人民共和国精神卫生法》《中华人民共和国个人信息保护法》

3. 正规书籍与科普资源

> 书和科普能帮你理解疾病、管理情绪，但**不能替代医生面诊、药物治疗和心理治疗。**【临床共识】本章列出的都是有真实作者、真实出版社、可在图书馆或正规电商查到的资源；遇到承诺"根治""永不复发""七天走出抑郁"的，直接划走。

一、给患者本人的正规书籍（按用途分类）

1. 自助技能类（CBT/正念，适合轻中度、康复期、预防复发辅助）

书名	作者	中文版信息	适合阶段	注意事项
《伯恩斯新情绪疗法》	[美] 戴维·伯恩斯（David Burns），李亚萍译	中国城市出版社2011年版（另有科学技术文献出版社版本），ISBN 978-7-5074-2365-5	轻中度抑郁/焦虑自助、CBT思维日记练习、康复期巩固	自助书不能替代中重度抑郁的药物治疗；练习需要坚持
《穿越抑郁的正念之道》	Williams、Teasdale、Segal、Kabat-Zinn（MBCT四位创始人）	中文版已出版	反复发作、预防复发、康复期正念练习	MBCT对预防复发有证据，急性期不要只靠正念
《正念，此刻是一枝花》	乔·卡巴金（Jon Kabat-Zinn）	中文版已出版	压力管理、日常冥想入门	不是抑郁症专用治疗书，是通用正念教材

2. 康复叙事类（让你知道"有人走出来过"）

书名	作者	中文版信息	适合谁	注意事项
《活下去的理由》（Reasons to Stay Alive）	[英] 马特·海格（Matt Haig）	中文版已出版	任何觉得"撑不下去"的人	个人叙事，不是治疗手册；读的时候允许自己哭
《我有一只叫抑郁症的黑狗》	[澳] 马修·约翰斯通、安斯利·约翰斯通，康太一译	广西科学技术出版社2017年版，ISBN 978-7-5551-0704-0	患者本人 + 家属共读；篇幅短、图文并茂	原动画曾获世界卫生组织推荐；轻松易读但不代表治疗简单

3. 选书原则

- 优先选**正规出版社**（中华商务、中信、机械工业出版社、广西科技、中国城市等）、**作者有医学/心理学背景、有 ISBN 可在图书馆查到**的书。
- 警惕：书名带"治愈""奇效""七天""彻底告别""大师亲授"、作者是"某成功学导师""某能量大师"、封面全是承诺的，基本可判定为非正规读物。
- 同一本书读不下去很正常——抑郁发作期注意力本来就差，**不要逼自己"读完"**，能看几页是几页。

二、给家属的书

> 家属最需要的不是"治疗技术"，而是理解疾病、稳住自己。以下方向可在正规渠道按书名检索，选最新版即可，不固定推荐某一本避免过时。

- 围绕"抑郁家属如何陪伴、如何照顾自己"的正规心理学科普读物（注意作者是否有精神科/临床心理学背景）。
- 与患者共读《我有一只叫抑郁症的黑狗》这种图文小册子，比厚书更容易开始对话。
- 【争议观点】市面上大量"情绪疗愈""亲子关系"类书籍质量参差，**不确定的宁可先不买**，先看官方机构免费科普。

三、权威机构与免费科普资源（可核查）

资源	类型	适合谁	获取方式	注意事项
世界卫生组织（WHO）抑郁症专题	权威科普	所有人	who.int/news-room/fact-sheets/detail/depression（中文页可切换）	数据最新、无广告
WHO 自助手册《压力之下，善待自己》（Doing What Matters in Times of Stress）	免费PDF自助指南	压力/焦虑/抑郁情绪	WHO官网可免费下载，有中文版	适合轻中度压力管理，不替代治疗
国家心理健康和精神卫生防治中心	官方机构	国内患者/家属	ncmhc.org.cn	政策、科普、热线信息首发
国家卫生健康委员会	官方机构	所有人	nhc.gov.cn	指南、政策原文
中国心理卫生协会	专业协会	想找专业心理咨询师的人	cnmh.org.cn	可了解行业规范
美国NIMH抑郁症专题	权威科普	英文阅读无障碍者	nimh.nih.gov/health/topics/depression	信息严谨
英国NHS/NICE公众版（NG222）	临床指南公众版	想了解规范治疗流程者	nice.org.uk/guidance/ng222	了解国际通行标准，不是照搬英国用药

四、公益热线与正规线上问诊

- **12356**：全国统一心理援助热线，24小时免费（2025年5月起全国统一，2025年9月已普及，核实日期2026-10-11；以当地官方公布为准）。
- **正规互联网医院**：三甲医院的官方互联网医院、国家认可的互联网诊疗平台，可进行复诊开方、心理咨询初筛；**首诊仍建议线下面对面。**
- 不建议：未经资质审核的"情感咨询机构""挽回大师""塔罗占卜疗愈"（见下一节《偏方与网络疗法风险》）。

五、如何辨别一条科普内容靠不靠谱

看到一条讲抑郁症的内容，先用下面五个问题筛一遍：

1. **作者是谁？** 有没有精神科/临床心理学资质？是不是三甲医院医生？匿名"营养师""疗愈师"要打问号。
2. **有没有引用指南/研究？** 还是通篇"我有一个来访者""我亲戚"？
3. **是不是在卖东西？** 卖课、卖保健品、卖"能量仪"、卖"排毒套餐"的，动机先存疑。
4. **承诺是不是太满？** "根治""永不复发""停药也没事""不用看医生"——只要出现，直接划走。
5. **有没有制造恐慌/愧疚？** "你不吃这个就会废了""你不陪他就是不爱他"——这是营销话术，不是科普。

> 【研究结论】在精神健康领域，**免费的官方资源质量普遍高于付费网红课**；先把 WHO、国家心理健康中心、三甲医院公众号看一遍，再决定要不要花钱。

六、一个最小行动清单

- [ ] 存好 12356，告诉一位信任的人
- [ ] 从上面书表里挑一本**最薄的**开始（推荐《我有一只叫抑郁症的黑狗》）
- [ ] 关注 1–2 个官方公众号（国家心理健康和精神卫生防治中心 + 你所在地的精神卫生中心）
- [ ] 取关任何让你焦虑、觉得"自己好差"的账号

参考来源

- 世界卫生组织：Depression fact sheet
- 世界卫生组织：Doing What Matters in Times of Stress（自助手册）
- 国家心理健康和精神卫生防治中心：官网
- NICE：Depression in adults: treatment and management，NG222
- 美国 NIMH：Depression
- 《我有一只叫抑郁症的黑狗》，广西科学技术出版社2017年版，ISBN 978-7-5551-0704-0（国家出版发行信息公共服务平台可查）
- 《伯恩斯新情绪疗法》，中国城市出版社2011年版，ISBN 978-7-5074-2365-5（图书馆OPAC可查）

4. 偏方与网络疗法风险

> 当人被困在抑郁里时，特别容易抓住任何一根"稻草"。这不是傻，是绝望中的求生本能。【临床共识】但稻草救不了溺水的人，反而可能把你拖得更远。本章帮你识别哪些"疗法"是真帮手、哪些是骗局或危险，以及万一已经踩坑了怎么办——不羞耻、能补救。

一、保健品与"神药"类：哪些真有证据，哪些是坑

说法/做法	真相	风险	怎么办
"褪黑素治抑郁"	褪黑素主要调节睡眠节律，对抑郁本身**没有确定治疗作用**；对部分睡眠节律紊乱可能辅助。	长期大剂量可能影响自身分泌，与抗凝、避孕药等有相互作用。	睡眠问题让医生评估，不要自己长期吃。
"鱼油/Omega-3抗抑郁"	部分研究提示可作为**辅助**（高剂量EPA比例），证据有限，不能替代抗抑郁药。	高剂量增加出血风险，与抗凝药冲突。	想吃先告诉医生，选正规医药品牌。
"维生素B族/维生素D治抑郁"	缺乏时补充有好处，但"缺不缺"要查血；不缺而大量吃不抗抑郁。	B6过量可致周围神经病变。	先查血常规、维生素D水平，缺再补。
"圣约翰草/贯叶连翘纯天然治抑郁"	对轻中度抑郁可能有一定效果，但成分含量极不稳定。【研究结论】	**它会诱导肝药酶（CYP3A4/CYP2C19/P-gp），大幅降低避孕药、华法林、环孢素、HIV药、部分抗抑郁药的血药浓度；与SSRIs联用可能诱发5-羟色胺综合征（高热、肌僵、意识混乱）。**	**正在服任何处方药，尤其抗抑郁药、避孕药，绝对不要自行加圣约翰草；如已在吃，复诊时务必告诉医生。**
"胶原蛋白/酵素/排毒膏治情绪"	无任何抗抑郁证据。	浪费钱，部分产品非法添加西药。	不买。
"进口神药、泰国/缅甸抗抑郁偏方"	成分不明，常违规添加镇静剂、抗精神病药。	依赖、锥体外系反应、肝损伤风险。	不买、不吃；已吃带包装去医院。

二、传统/民间"疗法"类

做法	真相	风险
符水、烧香、驱邪、"中邪"仪式	把精神疾病妖魔化，延误治疗。	患者被进一步羞辱，甚至因"被治疗"受伤。
戒网瘾学校式封闭集训、"军事化管理""原生态吃苦"	针对的本是青少年行为问题，**不是抑郁症**；封闭、体罚、与家庭隔离会加重创伤。	已知多起致死、致伤、心理创伤事件。
针灸/按摩/经络仪"治抑郁"	放松可缓解部分躯体紧张，**不能作为主要治疗**。	把按摩当治疗，拖延正规就医；高价仪器是重灾区。

做法	真相	风险
"电疗保健仪"（家用、宣称替代ECT）	正规改良电抽搐治疗（MECT）是在医院麻醉监护下做的医疗操作；家用"电疗仪"不是医疗行为。	自行电击可能致伤、心律失常。
"中药调理、纯天然无副作用"	是话术。中药也有副作用、肝肾毒性、药物相互作用；"纯天然"不等于安全（马兜铃酸也是天然的）。	不明成分中成药可能私自添加低价西药，剂量不可控。

三、网络"心理疗愈"类（重灾区）

- **付费"情感挽回""抑郁自愈训练营"**：动辄几千到几万，所谓导师无资质，套路是先制造焦虑（"你不疗愈就会毁掉一生"）再卖课。
- **PUA式"男人/女人情感课"冒充心理成长**：与人本主义心理治疗完全相反，只会让人更割裂。
- **塔罗占卜、占星、灵性导师"解读你的抑郁"**：娱乐可以，**不能替代诊断**；尤其"你前世业力重""你被附身"这类说法，会加重病耻感和自罪。
- **"停药排毒""断食排毒""断联疗法"**：指导患者自行停抗抑郁药，可能诱发撤药反应、转躁、自杀风险急剧上升。
- **短视频里"我靠每天跑步/打坐/抄经就好了"的个案**：个例不是指南；讲这话的人往往是轻中度、且没告诉你他同期在吃药。

四、用酒精、大麻、毒品"自我药疗"——最高危

【临床共识】这是抑郁患者**最危险**的自我处理方式之一，必须直说：

- 酒精短期让你放松，长期会**降低5-羟色胺水平、加重抑郁、损害睡眠结构**，并显著**升高自杀风险。**
- 大麻（尤其高THC）可能诱发或加重焦虑、偏执、精神病性症状，对有双相/精神分裂家族史者尤其危险。
- 任何精神活性物质与抗抑郁药/心境稳定剂联用，都可能导致药效抵消、过度镇静、呼吸抑制。
- 一旦出现"不喝/不抽就心慌、手抖、必须靠它才能入睡"，说明已经有物质使用问题，**这是另一类需要同时治疗的疾病**，不是"靠毅力戒"。

五、识别危险信号：听到这些话术，立刻警觉

危险话术	它在干什么
"我们这个能**根治**抑郁，永不复发"	医学上抑郁是可治可管理，"根治"是营销。
"**正规医生都是庸医**，吃药就是伤害自己"	攻击医学、制造对立，把你从治疗关系里拉走。
"你必须**停药**/断药排毒"	直接制造撤药/转躁/自杀风险。
"别人都不理解你，只有我们这个团体懂你"	制造封闭、隔离家属，常见于传销式心理课。
"今天最后一天，**限时优惠**"	利用焦虑逼你冲动付款。
"你的隐私只能告诉我们，不能告诉家人/医生"	切断你与真实支持系统。
套餐价格数千至数万、不开发票、不签合同	随时跑路。

六、为什么不能用偏方替代规范治疗

1. **延误**：中重度抑郁的最佳治疗窗口就是发作期，拖几个月，大脑和社会功能的损失是累积的。
2. **撤药风险**：自行停抗抑郁药 → 撤药反应（头晕、电击感、情绪骤变）、复发、甚至转躁。
3. **自杀风险**：抑郁本身是自杀风险最高的疾病之一，偏方没有任何危机干预能力。
4. **经济损失**：骗局专挑最绝望的人下手。

七、如果已经买了/试了，怎么办——完全不晚

- **不羞耻。**几乎每个走过抑郁的人都试过一两种没用的东西，这不是你的错。
- **带上所有产品（包装盒、说明书、聊天记录、付款凭证）复诊**，直接告诉医生："我吃了这个/参加了这个课。" 医生不会评判你，只会帮你判断有没有相互作用、要不要体检。
- **还在吃的，不要突然停**（尤其被非法添加西药的"保健品"，骤停可能反跳），让医生帮你过渡。
- **要投诉/退款**：
- 市场监管/消保：**12315**
- 药品/医疗器械违法：**12331**（或12345转）
- 涉嫌诈骗：**110**
- 保留：产品照片、宣传截图、付款记录、聊天记录、合同。
- **告诉一个信任的人。**独处时最容易被下一个骗局盯上。

八、一句话总结

> 真正帮你的东西，通常有三个特征：**正规机构背书、不承诺根治、不阻止你看医生。**反过来，凡是承诺"奇迹"、让你停药、让你远离家人的，不管包装多温暖，都是陷阱。

参考来源

- 世界卫生组织：Depression
- PubMed：Drug interactions with St. John's Wort (Hypericum perforatum): a review of the clinical evidence
- 澳大利亚TGA：St John's Wort: Important interactions with prescription medicines
- NICE：Depression in adults: treatment and management，NG222
- 国家药品监督管理局：违法药品/医疗器械/保健食品警示信息

共病专题

> 抑郁很少"单打独斗"。【临床共识】在临床中，抑郁与焦虑、失眠、慢性疼痛、物质使用、强迫/创伤问题同时存在非常常见，**这不是你情况特殊、更不是你"没救"，而是疾病的常见形态。**把共病一起识别、一起治疗，效果才好。本章最后重点讲：为什么"双相情感障碍"特别容易被误诊为单相抑郁，以及你该主动告诉医生哪些线索。

一、共病为什么常见

- **神经生物学重叠**：抑郁与焦虑、失眠、慢性疼痛共享5-羟色胺、去甲肾上腺素等神经递质通路，一个出问题，别的系统容易跟着失调。
- **恶性循环**：失眠 → 情绪更差 → 更睡不着；疼痛 → 不想动 → 社交退缩 → 抑郁加重；焦虑 → 酒精麻痹 → 第二天更糟。
- **诊断边界模糊**：抑郁发作时常伴有焦虑症状，焦虑障碍久了也会抑郁；医生需要时间和纵向观察来判断主次。

> 【给你的话】共病不奇怪，也不丢人。你要做的，是在就诊时**把所有"不对劲"都列出来告诉医生**，而不是只挑最明显的那一个。

二、常见共病逐一说明

1. 焦虑障碍（广泛性焦虑、惊恐、社交焦虑）

- **你的感受**：心里悬着、静不下来、莫名害怕、心慌手抖、反复担心最坏结果；有时候"明明没什么事，但就是放松不下来"。
- **为什么一起出现**：长期焦虑消耗心理资源，最终把人推向抑郁；抑郁发作又放大对一切的灾难化想象。
- **就诊时主动说**："我除了情绪低落，还长期**紧张、心慌、对未来过度担心、怕见人/怕出事**，有没有惊恐发作过（突然心跳快、窒息感、濒死感）？"
- **治疗注意**：【临床共识】抑郁+焦虑时，医生常选对两者都有效的药物（如SSRI/SNRI类），心理治疗可同时做CBT；具体选药由医生根据你的症状谱定，**不要自己看哪种药"名气大"就要求开。**

2. 失眠/睡眠障碍

- **你的感受**：躺下脑子停不下来、凌晨三四点醒了再也睡不着、早醒（比平时早醒2小时以上且无法再睡）、白天困得要死但躺下又清醒。
- **为什么一起出现**：睡眠是抑郁的核心症状之一（尤其早醒是内源性抑郁的典型表现）；长期失眠本身就是抑郁发作和复发的危险因素。
- **就诊时主动说**：入睡难？易醒？早醒？总时长？打鼾/呼吸暂停？白天是否不可控制犯困？

- **治疗注意**：【临床共识】**慢性失眠的一线治疗是 CBT-I（失眠认知行为治疗），不是长期吃安眠药。**安眠药（苯二氮䓬类等）短期可用，但长期依赖会加重抑郁、损害认知；抗抑郁药本身改善睡眠后，很多人不需要额外安眠药。如果怀疑睡眠呼吸暂停，需做睡眠监测。

3. 躯体疼痛与躯体化

- **你的感受**：头痛、颈肩痛、腰酸、胃肠不适、胸闷、慢性游走性疼痛，做了各种检查都"没什么大问题"，但疼是真的；情绪差时疼痛加重，情绪好时减轻。
- **为什么一起出现**：抑郁/焦虑会放大疼痛信号（中枢敏化）；长期慢性疼痛本身也显著升高抑郁风险。
- **就诊时主动说**："这疼情绪差时更重、检查没器质性问题、已经持续多久。"
- **治疗注意**：【临床共识】伴慢性疼痛的抑郁，医生常考虑 SNRI 类（对疼痛和情绪都有作用）；配合运动、物理治疗、心理治疗；**不要因为"查不出问题"就被认为是装病。**

4. 物质滥用（酒精、大麻、镇静药）

- **你的感受**："不喝一杯睡不着""喝点酒才能不焦虑""抽根大麻才能放松"，渐渐发现不喝/不抽就心慌手抖、整天想着下一次。
- **为什么一起出现**：患者用物质自我麻醉；而酒精和大麻长期反而**加重抑郁、升高自杀风险**，并抵消抗抑郁药效果。
- **就诊时主动说**：**必须坦诚**——"我大概一周喝几次、一次喝多少、有没有不喝就难受的时候、有没有用过别的东西。" 医生不会评判你，隐瞒才最危险。
- **治疗注意**：【临床共识】物质使用问题需要**同时戒断/治疗**，不能一边吃抗抑郁药一边大量喝酒；有些药物在物质使用期需要调整。

5. 强迫相关与创伤相关

- **强迫（OCD）**：反复想一件事、反复洗手/检查、明知没必要但停不下来，伴随强烈焦虑，久了耗竭导致抑郁。**就诊时主动说**："我有没有反复确认、反复清洗、脑子里挥之不去的念头？" 强迫与抑郁选药思路不同（高剂量SSRI + 暴露反应预防ERP），由医生定。
- **创伤/创伤后应激（PTSD）**：经历过事故、暴力、侵害、重大丧失后，反复闪回、噩梦、回避、过度警觉、情感麻木，常与抑郁共病。**就诊时主动说**："有没有一件事过去很久了但仍反复想起/做噩梦/刻意回避相关场景？" 【临床共识】创伤需要**专门的创伤聚焦心理治疗**（如延长暴露PE、认知加工疗法CPT），不是普通"聊聊天"能解决；在创伤处理前，单纯抗抑郁药效果常打折扣。

三、重点鉴别：双相情感障碍——最容易被误诊为抑郁

> 【临床共识】**双相抑郁发作时，表现和单相抑郁几乎一模一样**：情绪低、没兴趣、疲劳、想自杀。区别在于——这个人**一生中是否还有过躁狂/轻躁狂发作。**如果漏掉了这个病史，单纯用抗抑郁药治疗，可能诱发转躁、快速循环，让病情更复杂。所以你了解下面这些线索，非常重要。

1. 躁狂/轻躁狂的核心线索（持续至少数天，明显异于平常状态）

- **心境异常高涨/莫名兴奋**：或者**异常易怒**，一点小事就爆炸。

- **睡眠需要明显减少却不觉得困**：比如一天只睡2–3小时，连续几天仍精力充沛（注意：不是失眠痛苦，是"不想睡、不困"）。
- **话多、停不下来**，别人插不上嘴；**思维奔逸**，脑子像开快车，一个念头接一个。
- **自我评价夸大**：觉得自己特别厉害、有特殊使命、能力远超现实。
- **冲动行为**：疯狂购物（花掉积蓄）、盲目投资、轻率性行为、鲁莽驾驶、暴饮暴食。
- **精力异常旺盛**：连续几天通宵工作/ social/打扫，平时根本做不到。
- **注意力容易被无关小事吸引。**

> 轻躁狂比躁狂轻（社会功能没有严重受损、没有精神病性症状），但**对诊断和用药同样关键。**很多患者把轻躁狂当成"状态好的时候"，不会主动告诉医生。

2. 为什么抗抑郁药单治可能出问题

- 【临床共识】双相患者如果只用抗抑郁药、不加心境稳定剂，部分人会从抑郁"转"到躁狂/轻躁狂，或者出现**快速循环**（一年之内抑郁/躁狂交替发作≥4次），治疗难度显著增加。
- 双相的基础治疗是**心境稳定剂**（如锂盐、丙戊酸盐等）或非典型抗精神病药，抗抑郁药只是在抑郁相时由医生谨慎短期联用。

3. 家族史线索

- 直系亲属（父母、兄弟姐妹）有没有人被诊断过"躁郁症""双相"、或者"一阵特别兴奋一阵特别消沉"、甚至因情绪问题住院/自杀？
- 你自己是不是"情绪过山车"体质——抑郁很久后突然有一段"自我感觉特别好、效率极高、睡得少、花钱大手大脚"的时期？

4. 就诊时，你可以这样直接问/这样说

- "医生，我除了这段时间低落，以前有没有过**连续几天睡得很少但人很精神、话特别多、花钱很冲动**的时候？"
- "我家里有没有人情绪像过山车？"
- "我现在吃的抗抑郁药，会不会让我变兴奋？如果出现特别开心/特别易怒/睡不着，我该怎么办？"

> 【重要】**你不需要自己下诊断。**把线索告诉医生，由医生判断是否需要评估双相；早识别、治疗框架不同，预后会好很多。

四、共病/鉴别大表（就诊时对照勾选）

共病/鉴别	你要识别的线索	你要告诉医生的话	治疗方向提示（由医生定）
焦虑障碍	长期紧张、心慌、过度担心、惊恐发作、怕社交	"我除了低落，还长期焦虑/惊恐/怕见人"	抗抑郁药（SSRI/SNRI）+ CBT

共病/鉴别	你要识别的线索	你要告诉医生的话	治疗方向提示（由医生定）
失眠	入睡难/易醒/早醒/打鼾/白天不可控困	"我的睡眠具体是这样……"	CBT-I 一线；短期安眠药需谨慎
慢性疼痛/躯体化	多处疼痛、检查无器质问题、情绪差时加重	"疼是真的，情绪差时更重"	SNRI类 + 物理治疗 + 心理
物质使用	不喝/不抽就难受、整天想着、越用越多	"我大概用多少、用多久、有没有戒断反应"	同时戒断治疗，调整用药
强迫	反复检查/清洗/念头、明知没必要停不下	"我有反复做……的习惯"	高剂量SSRI + 暴露反应预防
创伤/PTSD	闪回、噩梦、回避、过度警觉、情感麻木	"有件事过去很久了，我仍……"	创伤聚焦心理治疗 + 药物
双相（重点鉴别）	连续数天睡得少却不困、兴奋/易怒、话多、夸大、挥霍、冲动、家族情绪病史	"我有没有过一阵特别精神/特别能花钱/特别易怒？家里有没有人情绪过山车？"	心境稳定剂为基础；抗抑郁药由医生谨慎联用

五、给共病患者的三句话

1. **"我不是病情更重，我是症状更多"**——共病是常见形态，不是判决书。
2. **"一次说全，比每次只说一点点更省事"**——把上面大表当就诊提纲，写在手机备忘录里。
3. **"治疗可能需要同时走两条路"**——药物、心理、睡眠、物质戒断，医生会排优先级，你配合就好。

参考来源

- 世界卫生组织：Depression fact sheet
- NICE：Depression in adults: treatment and management，NG222
- NICE：Bipolar disorder: assessment and management，NG185
- 美国NIMH：Bipolar Disorder
- 中华医学会精神医学分会：《中国抑郁障碍防治指南》《中国双相障碍防治指南》相关共识
- 国际睡眠医学会/中国睡眠研究会：慢性失眠CBT-I一线治疗相关共识

家属参考附录

> 写给陪伴抑郁患者的家人、伴侣、父母、成年子女、朋友。【临床共识】你的角色是**支持者，不是医生。**你不需要治好他，但你可以成为他最稳的那块地板。照顾好你自己，才能真正陪他走下去——这不是自私，是长期主义。

> 【重要声明】本附录面向家属，但语气同样平等：抑郁是疾病，不是"想不开"；患者本人不是"在闹情绪"，家属也不是"活该受罪"。本章所有医学建议不替代面诊，用药与治疗方案请遵精神科医生医嘱。

一、先定位：你到底是谁

- 你**不是**治疗师：不要自己诊断、不要替他调药、不要评判"这个医生靠不靠谱"。
- 你**是**：稳定的陪伴者、就医协助者、生活节律的共同维持者、安全的观察者。
- 一条黄金原则：**"我在"比"我懂"更重要；"陪着"比"解决"更重要。**

二、"该说 / 不该说"对照表（12 对以上，直接可用）

别再说	试着这样说	为什么
"你就是想太多 / 想开点"	"我看到你最近很难受，这不是你的错。"	否定感受只会让他闭嘴。
"你就是太闲了，忙起来就好了"	"你愿意的话，我陪你做点小事；不想动也没关系。"	把疾病归因为懒，是二次伤害。
"你看别人比你惨多了"	"痛苦没法比，你现在是真的在受苦。"	比较不会减轻痛苦，只会让人不敢求助。
"你要坚强 / 你必须撑住"	"累了就歇，我陪着你，不用在我面前撑。"	坚强的要求对急性发作期是压迫。
"为了我 / 为了孩子 / 为了这个家，你也要好起来"	"你对我很重要，但你不需要为了我硬撑；我们一起面对。"	道德绑架会加重内疚，内疚是抑郁的燃料。
"你就是懒 / 不上进"	"我注意到你最近起不来，是身体/情绪出问题了，我们去看看？"	疾病导致的退缩不是懒惰。
"药有副作用，别吃了 / 是药三分毒"	"药的副作用可以跟医生说，咱们一起复诊问问。"	劝自行停药可能致命。
"我都为你做了这么多了，你怎么还这样"	"我有点累，但我没怪你；我们一起想办法。"	付出感一旦说出口，就变成了债务。
"你就是玻璃心 / 太脆弱"	"你现在比平时脆弱，是病在影响，不是你这个人不行。"	把状态和人格分开。
"你就是矫情 / 装病"	"我可能不太懂，但我看到你是真的不舒服，我信你。"	信任比理解更基础。
"出去玩玩 / 旅旅游就好了"	"等你状态好一点，我们再考虑出门；现在你想在家待着就在家待着。"	强迫社交对急性期是消耗。

别再说	试着这样说	为什么
"我早就跟你说过……"	"不说教了，现在最重要的是你好不好。"	事后诸葛亮只会让人羞愧。
"你倒是说话啊 / 你整天闷着算什么"	"不想说话也没关系，我坐这里陪你。"	允许沉默。
"你这样让我很崩溃 / 我快被你逼疯了"	"我今天状态也不太好，我先去自己待一会儿，晚一点再陪你。"	家属的情绪要表达，但不要倒在患者身上。
"一切都会好起来的"	"我不知道什么时候会好，但我会一直在。"	虚假的乐观不如真实的陪伴。

三、实际可以做的 8 件事

1. **陪诊**：第一次就诊、复诊时陪他去，帮忙记医生说的话——抑郁发作时注意力很差，回家就忘。
2. **提醒服药，但不监督对立**："该吃药了哦"是温柔提醒；不要翻包检查、不要质问"你今天吃没吃"。
3. **维持生活节律**：一起按时吃饭、一起晒太阳10分钟、晚上一起散步——不催促，只同行。
4. **把任务拆到极小**：不是"你要振作"，而是"能不能一起把碗洗了""能不能下楼拿个快递"。
5. **帮他筛信息**：把网上那些"七天治愈"的垃圾内容挡掉，把靠谱的资料（12356、正规医院）放他手边。
6. **保护他的隐私**：不跟亲戚邻居说"他病了"；不发朋友圈；病历、药盒收好。
7. **配合治疗**：医生建议住院就住院，建议心理治疗就帮他预约；**不要替他拒绝治疗。**
8. **观察并记录**（见第六节）。

四、沟通原则（5 条）

1. **倾听多于建议**：他说的时候，先复述"我听到你是说……"，别急着给方案。
2. **允许沉默**：坐在一起不说话，也是陪伴。
3. **不承诺对自杀/自伤保密**：如果他告诉你"我不想活了"，**不要替他保密**——先保证他人身安全，再解释为什么不能替他守这个秘密。
4. **不道德绑架**："你这样我怎么办"这类话不要说。
5. **尊重自主权**：他不想说话、不想出门、不想见人，在**没有安全风险**的前提下允许他；但就诊、吃药这种关键事项，要温柔而坚定地推动。

五、危机时家属怎么办（只写安全，不写方法）

> 如果你发现他有以下情况：表达强烈的"不想活了/活着没意思"、安排后事、告别、把珍贵东西送人、突然异常平静、已经藏药/藏工具——**这是危机信号。**

- **直接问**："你是不是有过不想活的念头？有没有想过怎么做？"——**直接问不会"提醒"他自杀，反而让他感到被看见。**问完不要慌、不要骂。
- **不离人**：在确保你自身安全的前提下，不要让他独处。把可能被用于自伤的危险物品移开（不要展开具体方法，让专业人员处理）。
- **立刻求助**：
- **12356**（全国24小时心理援助热线，免费，2025年已全国普及，核实日期2026-10-11，以当地官方公布为准）

- **120**（急救）/ **110**（公安，现场有人身威胁时）
- 直接送**有精神科急诊的三甲医院/精神卫生中心。**
- **住院不是抛弃他**：急性期住院是最安全的选择，配合医生；不要因为"面子"拒绝住院。
- **事后**：他情绪平复后，不要指责"你差点把我吓死"，而是说"我当时很怕失去你，我们以后遇到这种情况怎么办"。

六、如何观察与记录（给家属的小本子）

每天花两分钟记一下，复诊时给医生看，比回忆一个月前强得多：

- **睡眠**：昨晚大约几点睡、醒几次、几点醒、白天补不补觉。
- **饮食**：今天吃了多少、有没有食欲、体重变化。
- **言语**：有没有突然说"活着没意思""你们以后怎么办""我是累赘"。
- **行为**：有没有把东西送人、开始清理手机/电脑、辞掉重要工作、突然异常平静。
- **药物反应**：有没有明显嗜睡、心慌、恶心、手抖、"好像变兴奋了/话特别多/睡得很少却不困"（后者要警惕转躁）。
- **情绪**：是平稳、低落、还是烦躁易怒。

> 【临床共识】"睡得少却精神特别好、话多、花钱冲动"是**双相转躁**的线索，要第一时间告诉医生。

七、家属自己也要被照顾

- **你不是他的医生，也不是他的药。**把全部生活押在他身上，两个人都会垮。
- **给自己喘息**：和其他家属轮班、请护工、每周留半天给自己的事。这不是抛弃，是让你能撑得久。
- **你可以有自己的情绪**：委屈、疲惫、生气都是正常的；找你自己的朋友、心理咨询、家属支持团体（很多精神卫生中心有家属互助小组）。
- **不要自责**："我是不是哪里做得不好"——抑郁是疾病，不是你造成的。
- **处理你自己的病耻感**：你愿不愿意告诉自己的朋友/同事，同样是一个需要你自己权衡的事；不必勉强。

八、不同对象的特别提示

- **青少年家属**：不要把问题归为"青春期叛逆"；持续两周以上的低落、厌学、自伤痕迹（手臂划痕）、网络上的消极帖子，都要认真对待；**青少年抑郁自杀风险更高**，不要等。
- **老年家属**：老人常说"我老了没用了""给你们添麻烦"，这不是谦虚，是危险信号；老人躯体化多（头痛、胃肠不适），检查没大问题时要想到情绪问题。
- **伴侣家属**：抑郁期他可能不想亲热、不想说话、对什么都没兴趣——这是病，不是对你没感情；等他好了，关系会慢慢回来。不要在他最需要你的时候谈"我们是不是不合适"。

九、康复期如何陪伴

- **不催促**："你怎么还不好"是最伤人的话。

- **容忍反复**：偶尔几天状态回落是正常的，不是"前功尽弃"。
- **庆祝小进步**：今天他出门买了个菜、今天他自己热了饭——具体地、真诚地夸。
- **逐步还给他自主权**：病好一点之后，让他自己做决定、自己安排生活，不要一直当"病人"照顾。

十、家属一周陪伴自检（每周日花2分钟勾选）

- [ ] 这周我有没有说过"想开点/你就是太闲"？（说过没关系，下周注意）
- [ ] 这周我有没有陪他按时复诊/取药？
- [ ] 这周我有没有观察并记录他的睡眠、情绪、言语、行为？
- [ ] 这周我有没有留半天给自己喘息？
- [ ] 这周我有没有把自己的情绪倒给他？（有的话，下周找朋友/咨询师）
- [ ] 这周我有没有把他当"病人"而不是"人"对待？
- [ ] 我和他的紧急联系电话是否仍然存在手机里？

十一、紧急联系卡（可抄到手机备忘录 / 打印放钱包）

```
==============================
   精神健康紧急联系卡
==============================
患者姓名：_______________
主治医院/科室：___________
主治医生/电话：__________
正在使用药物（不要自行停）：
   _____________________

【24小时心理援助】12356
【医疗急救】        120
【公安】            110
【人社咨询】        12333
【法律援助】        12348

家属/信任的人：
  姓名：_______ 电话：______
  姓名：_______ 电话：______

最近的有精神科急诊的医院：
  名称：_________________
  地址：_________________
  电话：_________________

【如果出现强烈不想活、安排后事、
  突然异常平静、自伤行为——
  不要让他独处，立即拨打120/12356，
  就近送精神科急诊。】
==============================
```

> 把这张卡**同时存在患者手机、家属手机、贴在冰箱上**三份。希望你永远用不上，但一定要有。

参考来源

- 世界卫生组织：Depression fact sheet
- 世界卫生组织：Guidance on community mental health services
- 世界卫生组织：Suicide prevention（PREVENT suicide）
- 国家心理健康和精神卫生防治中心：12356热线与家属科普
- NICE：Depression in adults: treatment and management，NG222
- 《中华人民共和国精神卫生法》（国家法律法规数据库 flk.npc.gov.cn）

康复者视角

> 【个人体验】**本文为个人经历的综合与化名呈现，不代表所有抑郁症患者的体验，也不能作为任何治疗依据。每个人的治疗反应不同，用药方案请务必遵医嘱。** 我们写这些，是想让正在黑暗里的你知道：有人真的走出来过，而且走出来之后，生活还可以继续。

> 【临床共识】真正的康复（recovery）不是"从此再也不难过"，而是**学会与症状共处、有能力在波动中重新站起来**。下面三个故事都不回避反复、副作用、等待和笨拙——这才是真实的复原。

故事一：反复发作后，重新坐回办公室的程序员

【个人体验】以下为化名故事。

我32岁那年第三次复发。前两次我都以为"自己能扛过去"，辞职、旅游、跑步、看了一堆心理学的书，每次好一点就停。第三次是在连续加班三个月后，我早上醒过来，盯着天花板，**连伸手拿手机的力气都没有**。那一刻我突然明白：这次不是靠意志力能解决的。

那段时间的错误认知：我觉得自己是个失败者——一个写了十年代码的人，连起床都做不到。我不敢告诉任何人，怕被同事知道，怕leader觉得我"抗压能力差"。我甚至偷偷查过"抑郁症会不会影响以后找工作"，越查越绝望。

就医与治疗的真实过程：是我太太硬拉我去的精神卫生中心。第一次坐在医生面前，我哭得说不出话。医生给我开了药，**前两周我几乎没觉得有任何变化，反而有点恶心、犯困**。我差点放弃。复诊时医生说，这是正常的，药通常要三四周才起效。我就这么硬等了四周。第五周的某个早上，我发现自己**居然愿意掀开被子了**——不是开心，是"愿意试试"。后来我又做了一段时间认知行为治疗，学着把脑子里"我是个失败者"那些自动想法一条条记下来、反驳。

副作用和反复：药不是没有代价——初期有点嗜睡，体重也涨了几斤；中途我自己减过一次药，两周后情绪直接塌下去一次，那次教训让我老老实实复诊了三年。**我现在知道，"感觉好了"和"可以停药"之间，隔着很长一段维持期。**

转折：不是某件大事，是一点点小事——我重新能在周末陪孩子去公园，能在食堂和同事开个玩笑。有一次我写完一段代码，突然意识到：我已经三个小时没想起"活着没意思"这件事了。

给当下的你：如果你现在正处在"连伸手都难"的阶段，我想告诉你——**那个阶段是真的会过去的，但你得先让医生帮你。**别像我前两次那样硬扛，硬扛的代价是又复发两次。吃药不丢人，复诊不丢人，**愿意为自己多撑一次，就很了不起。**

故事二：从月子里掉进深渊的妈妈

【个人体验】以下为化名故事。

我以为生了孩子我会是那种开心的妈妈。结果出院第三天，我坐在床上喂奶，看着怀里的宝宝，**心里一点感觉都没有，只有一个念头：我怎么把他带到这个世界上来受苦。**我整夜整夜地哭，觉得自己是个坏妈妈。

那段时间的错误认知：所有人都跟我说"产后都这样，过段时间就好了""你要坚强，为了孩子"。我也这么以为，直到有天我抱着孩子站在阳台，脑子里闪过一个很可怕的念头——我被自己吓到了，立刻回房间哭着跟我老公说"我可能真的病了"。

就医与治疗：我们去了妇幼保健院的心理门诊，医生说是**产后抑郁**，不是我"矫情"。因为在哺乳，医生选了对乳汁影响相对小的方案，并且反复跟我确认"你现在能不能保证宝宝安全"。前两周我还是很丧，医生说这在预期内。**最艰难的是前一个月，我每天都在"我是不是个好妈妈"的自我攻击里。**后来我老公请了年假，我妈过来搭把手，我才终于能睡上一个整觉。

转折：大概是我老公有天晚上没说"你要坚强"，而是说了一句："**睡不着就不睡，我陪着你，孩子我来抱。**"我当场就崩了，哭了很久。那天之后，我开始愿意承认"我需要帮助"。

现在：孩子两岁了，我还在维持小剂量的药，定期复诊。我学会了一件事——**好妈妈不是"从来不崩溃的妈妈"，是"崩溃了还能求助的妈妈"。**我也敢在妈妈群里说我产后抑郁过，至少有三个妈妈私下来找我说"原来不是我一个人"。

给当下的你：如果你刚生完孩子、心里没有那种"应有的"幸福感，**这不代表你不爱孩子，也不代表你是个坏妈妈。**这是病，和乳腺炎一样，是需要治的。别等"自己好起来"，现在就告诉一个你信得过的人，让他陪你去医院。

故事三：从急诊室捡回一条命的年轻人

【个人体验】以下为化名故事。

我24岁，确诊那年是我大学毕业第二年。我不是那种"看起来可怜"的人，我平时甚至挺爱笑。但那天晚上我在出租屋里已经把东西都收拾好了——是我室友撞开门，打了120。

那段时间的错误认知：我一直觉得"我这种程度不至于看病"，网上那些"真正要自杀的人不会说出来"的说法反而让我更安静。我以为求助是给别人添麻烦，是"矫情"。**现在我知道，那是我最后悔的一个念头。**

就医与治疗：急诊之后直接住了院。住院那段时间我是麻木的，不想说话，不想见人。护士姐姐每天来跟我聊几句，不强迫我"开心起来"，就是陪着。药物起效比我想象中慢，中间有过一次反复，医生调了方案。**最让我意外的是，出院后我开始接受每周一次的心理治疗，那是我第一次有人认真听我说话、不打断我、不说教。**

转折：不是痊愈，是某次治疗师问我："你有没有一件事，是你生病之前喜欢、现在还愿意试一下的？"我想了很久，说："画画。"她就说："那这周我们试试，画10分钟就好。"我画了。画得很烂，但我那天第一次**没有批评自己。**

现在：我出院两年了，药还在吃，工作也慢慢回到正轨。我手机里存着12356和我信任的两个朋友的号码。**我不再要求自己"永远不复发"，我只要求自己——下次再撑不住时，别再一个人扛，直接拨电话。**

给当下的你：如果你现在正想着"说了也没人在乎""我是不是在矫情"——**请现在就拨12356，或者敲开一个人的门。**你不是在添麻烦，你是在救自己。我在康复的这头等你。

康复不是直线：关于"波动"和"与症状共处"

【个人体验】以上三位都经历过：

- **好一段时间 → 突然又低落几天**：这不是"复发失败"，可能就是感冒、熬夜、换季、压力带来的情绪波动。学会识别"这是波动还是复发"，比要求自己"永远好"更现实。
- **"我都好了为什么还吃药"**：维持期的药是为了稳住你，不是因为你"一直病着"。
- **偶尔还是会想"活着有什么意思"**：念头不等于行动。念头来了，看着它过去，该干嘛干嘛——这是训练出来的。

> 【临床共识】康复（recovery）是一个**方向**，不是一个终点。你不需要"完全好"才能开始好好生活；你可以一边治，一边慢慢把生活拼回来一点。

参考来源

- 世界卫生组织：Depression fact sheet
- 世界卫生组织：Doing What Matters in Times of Stress（自助手册）
- 美国NIMH：Depression
- NICE：Depression in adults: treatment and management，NG222
- 国家心理健康和精神卫生防治中心：官网科普